

自学中医之路丛书

肺病辨治

黑龙江中医学院 主编

审 阅

长春中医学院

辽宁中医学院

内蒙古医学院中医系

北京中医学院

北京中医学院分院

天津中医学院

河北中医学院

天津科学技术出版社

责任编辑：于伯海

自学中医之路丛书

肺病辨治

黑龙江中医学院 主编

审 阅

长春中医学院 辽宁中医学院
内蒙古医学院中医系 北京中医学院
北京中医学院分院 天津中医学院
河北中医学院

★

天津科学技术出版社出版

天津市赤峰道130号

天津新华印刷二厂印刷

新华书店天津发行所发行

★

开本787×1092毫米 1/32 印张5.25 字数108 000

1988年1月第1版

1988年1月第1次印刷

印数：1—6 410

ISBN 7-5302-0138-4/R·50 定价：1.25元

C0119360



编 者 的 话

历史悠久的中国医药学，有着独特的理论体系和丰富的临床经验。在当今世界医学之林中愈发闪耀着夺目的光彩，国内外学者越来越看到中医学宝库的巨大蕴藏量及其对世界科学的深远影响。从而，形成学习、研究中医药学的热潮，并且呈现出日益国际化的发展趋势。

然而，中医古籍汗牛充栋，浩如烟海，且文理古奥，颇艰索解。初学之人，常感无从入手，叹为观止。为了适应学习中医的需要，我们编写了这套《自学中医之路》丛书，以供初学中医人员及广大中医工作者和西医学习中医等同志们在教学、医疗工作中应用与参考。

本丛书的内容包括中医基础理论和临床辨证论治两部分共十六个分册。计有阴阳五行学说、病因病机学说、脏腑经络学说、诊法概要、八纲与八法、六经辨证、卫气营血辨证、脏腑病证常用方药、心病辨治、肝病辨治、脾病辨治、肺病辨治、肾病辨治、中医病案分析、历代临证格言选萃、针灸与按摩。

编写中，我们本着：①理论联系实际的原则。对基础理论的阐述，力求概念准确，逻辑性强，思维清晰，切合实用；五脏辨治等分册，结合内、外、妇、儿等学科常见病证，详细介绍辨证论治的规律与方法。②保持中医理论的科学性，系统性和完整性。尽量避免某些教材中存在的不必要的重复、

冗繁和脱节。做到深入浅出，简明精练。各分册能够独立成章，又使全丛书统一、谐调，成为有机的整体。③本丛书内容的深度和广度，以最近卫生部组织编写并审定的全国高等中医药教材为依据，并汲取各院校教学、医疗、科研的新成果、新经验。可以说，本丛书既是自学中医的普及读物，又可作中医院校的辅导教材。

本丛书是由天津科学技术出版社组稿，由天津中医学院、北京中医学院、北京中医学院分院、黑龙江中医学院、长春中医学院、辽宁中医学院、河北中医学院、内蒙古医学院等八所院校集体编写的。在全体编写人员的努力和天津科学技术出版社编辑同志的协助下，历时二年，几经修订，才得以奉献给广大读者。书中不足之处恳请批评指正，以便使本书进一步修改、完善，更好地为中医事业的发展发挥出应有的作用。

《自学中医之路》丛书编写组

1986年6月

目 录

一、风寒束肺.....	(2)
(一)感冒	(2)
(二)咳嗽	(6)
(三)喘证	(8)
(四)哮证	(9)
(五)水肿	(12)
(六)自汗	(15)
(七)小儿肺炎喘咳	(17)
(八)顿咳	(19)
(九)急惊风	(21)
(十)产后发热	(22)
二、风热袭肺.....	(23)
(一)感冒	(24)
(二)咳嗽	(26)
(三)喘证	(27)
(四)肺病	(28)
(五)咳血、鼻衄	(30)
(六)小儿肺炎喘咳	(33)
(七)风疹	(34)
(八)急惊风	(36)
(九)流脑	(37)
(十)白喉	(38)

(十一)产后发热	(38)
三、燥邪伤肺	(38)
(一)咳嗽	(39)
(二)失音	(40)
四、痰湿犯肺	(41)
(一)咳嗽	(42)
(二)喘证	(43)
(三)痰证	(44)
五、痰热郁肺	(45)
(一)肺癰	(46)
(二)胸痛	(47)
(三)咳嗽	(48)
(四)哮证	(48)
(五)小儿肺炎喘咳	(50)
(六)顿咳	(51)
六、肺热	(52)
(一)癰闭	(53)
(二)消渴	(54)
(三)咳血	(57)
(四)痿证	(58)
(五)小儿咳嗽	(59)
(六)小儿肺癆	(60)
七、饮停胸肺	(61)
(一)支饮	(63)
(二)悬饮	(63)
八、肺气虚	(64)
(一)感冒	(65)
(二)喘证	(66)

(三)哮喘	·····(66)
(四)虚劳	·····(67)
(五)自汗	·····(69)
(六)产后自汗	·····(69)
九、肺阴虚	·····(70)
(一)感冒	·····(70)
(二)咳嗽	·····(71)
(三)肺癆	·····(72)
(四)肺痿	·····(76)
(五)虚劳	·····(77)
(六)咳血	·····(78)
(七)白喉	·····(79)
(八)顿咳	·····(79)
十、气阴两虚	·····(80)
(一)肺癆	·····(80)
(二)痰证	·····(81)
十一、肺中虚冷	·····(82)
(一)肺痿	·····(82)
十二、肝火犯肺	·····(83)
(一)咳嗽	·····(83)
(二)咳血	·····(84)
(三)鼻衄	·····(85)
十三、肺脾气虚	·····(86)
(一)虚劳	·····(87)
(二)小儿遗尿	·····(87)
(三)小儿咳嗽	·····(89)
(四)小儿肺炎喘咳	·····(89)
(五)顿咳	·····(90)

十四、心肺气虚	(90)
(一)胸痛	(91)
(二)心悸	(92)
十五、肺肾气虚	(93)
(一)喘证	(94)
(二)咳嗽	(95)
十六、肺肾阴虚	(95)
(一)肺癆	(96)
(二)经行吐衄	(97)
十七、大肠湿热	(98)
(一)痢疾	(98)
(二)泄泻	(101)
(三)霍乱	(102)
(四)便血	(104)
十八、大肠寒湿	(105)
(一)泄泻	(105)
(二)霍乱	(107)
(三)痢疾	(108)
十九、大肠实热	(109)
(一)便秘	(110)
(二)腹痛	(111)
(三)昏迷	(112)
二十、大肠虚寒	(113)
(一)泄泻	(114)
(二)便秘	(114)
(三)腹痛	(115)
(四)痢疾	(116)
二十一、大肠液亏	(117)

(一)便秘	(118)
(二)产后大便难	(119)
附篇：常见疾病	(120)
一、感冒	(120)
二、咳嗽	(121)
三、喘证	(123)
四、哮证	(124)
五、饮证	(126)
六、肺痿	(127)
七、肺癰	(128)
八、肺癆	(129)
九、痢疾	(130)
十、便秘	(131)
十一、汗证	(133)
十二、痰证	(135)
十三、小儿感冒	(136)
十四、小儿咳嗽	(138)
十五、小儿肺炎喘咳	(139)
十六、小儿哮喘	(141)
十七、小儿汗证	(142)
十八、麻疹	(143)
十九、风疹	(145)
二十、幼儿急疹	(146)
二十一、猩红热	(147)
二十二、水痘	(148)
二十三、疥腮	(149)
二十四、白喉	(149)
二十五、百日咳	(151)

二十六、小儿肺癆	(152)
二十七、经行吐衄	(153)
二十八、妊娠咳嗽	(154)
二十九、产后大便难	(154)
三十、产后发热	(154)
三十一、产后自汗、盗汗	(156)
三十二、产后身痛	(156)

肺为五脏之一，位于人体的胸腔之中。由于肺的位置是五脏中最高的，因而又称“华盖”；因肺叶娇嫩，不耐寒热，容易受外邪的侵袭，故肺又称“娇脏”。肺为魄的居处，在五脏中属金。其上开窍于鼻，下覆诸脏，与大肠互为表里，共同组成肺大肠系统。

肺的第一个生理功能为主气，司呼吸。肺主气的功能是指人体一身之气都归属于肺，由肺所主；肺司呼吸是指肺是体内外气体交换的场所，主人体的呼吸功能。肺的第二个生理功能是主宣发与肃降。所谓“宣发”是宣布与发散的意思，即肺有向上升宣和向体表布散的作用；所谓“肃降”是清肃、洁净和下降的意思，也就是说肺有使肺气向下通降和保持呼吸道洁净的作用。宣发与肃降的功能是一对相互制约和相互依存的矛盾运动。宣发与肃降正常，气道就会通畅，呼吸均匀，以保持体内外的气体的正常交换。肺的第三个功能是通调水道。“通”就是疏通，“调”是调节，“水道”是水液运行与排出的道路。肺的通调水道的功能是指肺对水液的输布、运行和排泄起疏通和调节作用。肺的第四个功能是“朝百脉”、主治节。“朝”即朝向、聚汇之意。“肺朝百脉”是指全身的血液都通过络脉而朝向肺脏聚汇。这些血液在肺中进行气体交换，然后再输布到全身。“治节”即治理与调节，肺的治节功能是对肺的所有生理功能的高度总结

和概括。除了以上四个主要生理功能外，肺还有辅佐心脏和主声音的功能。此外，还应指出，肺在志为忧，在液为涕，在窍为鼻，在体合皮，其华在毛。由于肺脏内含大肠，肺和大肠相表里，所以我们还应了解大肠的功能。大肠接受小肠下注的浊物，再吸收其中部分多余的水分，使食物残渣变为粪便由大肠传导经肛门排出。如由各种因素导致肺及大肠的生理功能紊乱，就会引起肺大肠系统的多种病证。现分述如下。

一、风 寒 束 肺

风寒束肺是由外感风寒之邪，束缚于肺及皮表而引起的以恶寒发热、头身疼痛、咳嗽、咳痰清稀、气喘、鼻流清涕、不渴、无汗，或有头面及四肢浮肿、苔白、脉浮紧为主要证候的病证。之所以产生以上诸证，是由于肌表卫阳之气为风寒之邪所束而不得散越，所以出现恶寒发热或头痛、身痛之证；风寒之邪束肺，肺失宣降，所以可见咳嗽、气喘等证；因感受风寒之邪，肺失布散，津液化为痰涎，故咳痰清稀；肺为水之上源，有通调水道的功能，由于风寒束肺，水道不通，所以水湿之邪泛滥，流溢于头面四肢，故见头面四肢浮肿。由于肺主皮毛，风寒束于皮表，卫气被遏制，毛孔闭塞，因此表实无汗。苔白、脉浮紧为外感风寒之舌脉的表现。常见疾病为感冒、咳嗽、喘证、哮证、水肿、妊娠咳嗽、产后发热以及儿科的肺炎喘咳、急惊风、顿咳等等。

（一）感冒

“感冒”有感受、冒犯外邪之意。此病名首先见于北宋

《仁斋直指方·诸风》篇中。本病是指风邪侵袭人体而引起的以头痛、鼻塞、流涕、喷嚏、恶寒、发热为主要临床表现的外感疾病。感冒为一常见的病证，全年均可发病，但以冬、春两季为多见。如果病情严重，在一个时期内广泛流行，不分男女老少相互传染，症状相似者称为“时行感冒”。由于病情上有轻有重，所以有人将轻者称为“伤风”，将重者称为“重伤风”。在临床证候表现上有风寒、风热两大类，此外还有挟暑、挟湿等兼证以及体虚感冒等。

《素问·骨空论篇》说：“风从外中入，令人振寒汗出，头痛身重恶寒。”可见感冒的原因，从总的方面看来都与感受风邪有关，而且多发于气候突变，寒暖失常之时。所谓“气候突变”是指在四时中，应季的气候突然来到，如冬季的风寒，春季的风热，夏季的暑湿，秋季的燥气，梅雨季节的湿气等突然来到。这里应该指出，风邪虽为六淫之首，但在不同季节中，往往随时令之气而侵入；所谓的“寒暖失常”是指一年四季之中气候失常的变化。如春季应温不温而反见寒，夏季应热不热而反见冷，秋季应凉不凉而反见热，冬季应寒不寒而反见温，就是“寒暖失常”，也称“非其时而有其气。”综上所述，不难看出，由于气候突然变化，或寒暖失常，使外邪得以侵入人体发生感冒，或引起时行感冒流行。而风寒感冒就是风邪挟杂寒邪而导致的。

需要特别指出的是，风邪得以侵袭人体，往往又是在人体的正气虚弱、肺卫的调节功能失常的情况下发生的。这就是中医所说的“邪之所凑，其气必虚”的道理。如果一个人起居有节，寒暖调适得当，正气充足，即使受到风邪侵袭也不会患感冒。反之如生活起居失常，不注意随气候变化而调

节自己衣着厚薄，或者在过度疲劳之后，由于皮表腠理不密，卫气不固，毛孔稀疏，则外邪易于侵袭人体。这就是内外因相引而发病的道理。所以清·李用粹在《证治汇补·伤风》篇说：“有平昔之气虚弱，表疏腠松，略有不谨，即显风证者，此表里两因之虚证也。”那么究竟什么样的体质容易感受风寒之邪呢？中医认为，阳虚体质的病人易感风寒之邪。这是因为阳气不足的人，卫气不固，腠理不密，易为风寒之邪所袭有关。

感冒是一种以感受风邪为特点的疾病，而风邪伤人有独自的特点。这些特点是，“风性轻扬”、“伤于风者，上先受之”。所谓“轻扬”、说的是风邪具有升发、向上的特性；所谓“上”是指人体的上部。由于头面属人体之上，肺为脏腑之华盖，故外感风邪以头面及肺系见证较多；此外风邪还具有“善行数变”的特点。“善行”是指风邪致病具有病位行无定处的特点；“数变”是指风邪具有变幻无常和发病迅速的特性。所以感冒在临床上有发病急骤、兼证和并病多的特点。风邪袭人，通常从皮毛、口鼻而入，内归于肺。由于肺主呼吸，开窍于鼻，外合皮毛，职司卫外，性属娇脏，不耐邪侵，故外邪侵表时，肺卫首当其冲。感受外邪之后，卫阳被遏，营卫失和，正邪相争，所以会出现恶寒发热等证候。外邪犯肺，则气道受阻，肺气失于宣肃，则见咳嗽、鼻塞等肺系典型症状，

外感风寒型的感冒除了有感冒的共同症状外，常有自己的独特临床表现。这些表现是鼻塞声重，喷嚏，流清涕，喉痒，咳嗽，痰多稀薄。甚至发热恶寒，头痛身痛，无汗，口不渴，舌苔薄白，脉浮或浮紧。

以上症状的产生都与风寒外袭，肺气失宣有关。由于肺开窍于鼻、系于喉、主呼吸，一旦风寒束肺，就会导致鼻塞、声重、流涕、喷嚏、喉痒、咳嗽；气化敷布失职，气不化津则咳痰清稀；由于风寒束表，而寒又为阴邪，其性凝闭，最易伤阳，卫阳被遏，毛孔闭塞，故可见恶寒、无汗、头痛身痛；正邪相争故发热；外感风寒，故口不渴，舌苔薄白、脉浮是风邪在表的征象，紧为感受寒邪的表现。

本型的感冒可用辛温解表、宣肺散寒的方法治疗。轻证的可用葱豉汤（葱白、豆豉）加杏仁、苏叶、防风、荆芥治疗。正方的葱白辛温，疏畅肌表以散风寒为主药；豆豉辛甘透表达邪；苏叶、杏仁宣肺化痰；荆芥、防风辛温发散风寒之邪。如果病人恶寒发热较甚，头痛，肢体酸痛，无汗者乃为风寒重证，可用荆防败毒散治疗，方由荆芥、防风、柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独活、茯苓、桔梗、甘草等组成。方中荆芥、防风辛温发散；柴胡、薄荷疏表解热；川芎活血散风兼治头痛；前胡、桔梗、枳壳、茯苓、甘草宣肺理气、化痰止咳；羌活、独活祛风散寒除湿是治头痛和身痛的要药。如头痛明显可加用白芷；咳嗽重者加白前；痰多者可加半夏。若恶寒明显而无汗者，可用加味麻黄汤治疗，方由麻黄、桂枝、杏仁、甘草、苏叶、葛根等组成。若素体阳气不足较重又复感风寒者，证见恶寒、无汗、苔白、脉沉者，治以温阳散寒解表。可用麻黄附子细辛汤治疗，方由麻黄、附子、细辛等组成。如果是风寒挟湿证，临床可兼见头重体倦、胸闷泛恶、纳呆腹泻、口淡、舌苔白腻等证，可用羌活胜湿汤治疗，方由羌活、独活、川芎、蔓荆子、甘草、防风、藁本等组成，以疏风寒、散湿邪。如风寒挟痰，兼见咳嗽痰多，胸

肉食少者可合用二陈汤治疗，方由陈皮、茯苓、半夏、甘草组成，以理气化痰。

本病一般病程在5~10日之间，只要治疗得当，预后是良好的。治疗感冒不仅应根据感受外邪的不同采取不同的治法，而且对兼证的治疗和体虚感冒的病人，还应根据具体情况辨证施治。一般说来，治感冒不宜表散太过，以免伤正气，也不应补益太早，以免使外邪留滞。

（二）咳嗽

咳嗽是肺系的主要病证之一。中医认为“咳”与“嗽”是两种病证，即“有声无痰谓之咳，有痰无声谓之嗽，有痰有声谓之咳嗽”。但现在多把咳嗽归纳成一个病证。本病是由于肺系受邪或肺脏虚损而致，其病位在肺。所以《素问·宣明五气篇》说：“五气所病……肺为咳。”清代医家喻嘉言也说：“咳者，肺之本病也。”但是其它脏腑功能失调，也能影响肺的宣发、肃降功能，而导致咳嗽病的发生。所以《素问·咳论篇》又指出：“五脏六腑皆能令人咳，非独肺也。”咳嗽命名不一，分类方法也颇多。《素问·咳论篇》根据五脏六腑分类，把咳嗽分成心咳、肝咳、脾咳、肺咳、肾咳等；隋·巢元方在《诸病源候论·咳嗽候》中，又把咳嗽分为十种；明·张景岳则根据咳嗽产生的两大原因，而将咳嗽分为外感、内伤两大类，即由感受外邪而引起的咳嗽称为外感咳嗽，由于脏腑功能失调而引起的咳嗽称为内伤咳嗽，他说：“咳嗽之要，止惟二证，何为二证？一曰外感，二曰内伤，而尽之矣。”风寒束肺咳嗽即属于外感咳嗽的一种。

外感风寒咳嗽的病因，是由风寒之邪侵袭肺卫导致。因为肺主气，司呼吸，外合皮毛。一旦遭受风寒之邪侵袭，虽

皮毛先受风寒邪气，但邪气可从皮毛内传肺脏，导致肺气壅遏不通，清肃之令失常，进而导致痰液的滋生，阻塞气道，肺气不降而上逆，引起咳嗽一证。

外感风寒所致咳嗽病常以咳嗽、痰稀色白为特点。另外此证常伴有鼻塞、流清涕等肺经症状，同时可出现头痛、骨节酸痛、寒热无汗等表实症状以及舌苔薄白、脉浮等舌象脉象。由于风寒之邪犯肺，肺气失于宣肃之功，故咳嗽鼻塞；肺气被遏，津液失布，故咳痰流涕；由于外感寒邪故痰涕清稀；风寒袭表，阻遏经络，腠理闭塞，故可见恶寒发热、无汗、头痛及关节疼痛的表现。舌苔薄白、脉浮主风寒在表。

外感咳嗽总的治则为发表祛邪。对于风寒束肺引起的咳嗽则应采用疏风散寒、宣肺宁嗽的方法治疗。所以张景岳说：“外感之咳阳邪也，阳邪自外而入故治宜辛温，邪得温而自散也。”常用方剂为杏苏散，方由杏仁、紫苏叶、橘皮、半夏、生姜、枳壳、桔梗、前胡、茯苓、甘草、大枣组成。方中紫苏、生姜疏散风寒；前胡、杏仁、桔梗、甘草宣肺化痰止咳；陈皮、枳壳、半夏、茯苓理气燥湿化痰。以上诸药共奏疏风散寒、宣肺宁咳之效。如头痛甚者可加川芎；身痛甚者可加羌活；肺气壅塞较重而憋气者，可加麻黄；咳甚者加紫菀、冬花。如风寒外束，肺热内郁，证见恶寒鼻塞，咳嗽声哑，痰稠难咳，口渴咽痛，或有身热，甚至气逆而喘，舌苔白根黄、脉浮数者，可用散寒清热之法治疗，常用方剂为麻杏石甘汤，方由麻黄、杏仁、石膏、甘草组成。

妇女妊娠咳嗽也有因外感风寒所致的，治法与上相同，但需注意胎气和阴血两方面的因素。

外感咳嗽起病较急，但病势轻浅，只要治疗得当，常在

短期内可治愈，不留病根，预后较好。

（三）喘证

喘证是以呼吸急促，甚至张口抬肩，鼻翼煽动为特征。

《内经》对喘证早有“喘息”、“鼻张”、“肩息”等详细的症状描绘。《金匱要略》则称本证为“上气”。喘证在临床上可分虚实两大类，实喘呼吸深长有余，呼出为快，气粗声高，脉数有力，病多在肺，治宜祛邪利气；虚喘呼吸短促难续，深吸为快，气怯声低，脉微弱或浮大中空，病势徐缓，时轻时重，过劳加重，病在肺肾两脏，治以培补摄纳为主。

风寒外袭引起的喘证为实喘证型之一。常由于重感风寒，皮毛郁闭，内阻肺气而致，因肺为气之主，职司呼吸，外合皮毛，为五脏华盖，故外邪侵袭可使肺气失于宣降，呼吸不利，气逆而为喘促。

风寒袭肺的喘证初期常有畏寒、头痛、无汗、口不渴、舌苔薄白、脉浮紧等外感风寒表证。其临床特点多喘息胸闷，咳嗽、咳痰稀薄色白。这些临床表现的产生是由于风寒先犯皮毛，继之内侵肺脏，邪气壅实，肺失清肃下降，故喘息胸闷、咳嗽；由于外感寒邪，津液失化，故咳痰稀薄色白。

风寒袭肺引起的喘证在临床上应采用散寒宣肺平喘的方法治疗。麻黄汤（麻黄、桂枝、杏仁、炙甘草）为常用方剂。方中麻黄、桂枝辛温发汗，散寒平喘；杏仁、炙甘草顺气化痰。临床中尚可加入苏子、橘红为助。如经用上方发汗后而喘未止，可改用桂枝加厚朴杏仁汤治疗。方由桂枝、芍药、炙甘草、生姜、大枣、厚朴、杏仁等组成。如风寒在表，肺有郁热，喘逆上气，汗出口渴烦闷，甚则身热不退，气急鼻

煽，乃肺中郁热已成，病势转剧，治宜宣肺泄热平喘，方用麻杏石甘汤（见风寒束肺咳嗽一节）。

治疗风寒喘证，固然可以使用平喘药，但不可专靠肃肺平喘之品治疗，必须以解表宣肺为主，下气平喘为次。如通过解表宣肺方法使肺主呼吸功能恢复正常，喘证自然平息。

一般说来风寒喘证只要治疗及时、用药得当，常可短期治愈，预后较好。

（四）哮证

哮证是一种发作性的痰鸣气喘性疾患。以呼吸急促，喉间痰鸣为特征。《内经》称之为“喘鸣”。《金匱要略》对本病也有详细记载。在金元以前，哮证与喘证统属于“喘促”病的范畴。中医文献中也多不加区别，但两者病因与临床表现是不相同的。哮证是有宿根（病根）的疾病，是一种发作性疾病，是以呼吸急促，喉间哮鸣为特征的疾患，但是由于哮证发作时每每兼喘，所以有人称哮证为“哮喘”。而喘证是一种以呼吸急促，甚至张口抬肩、鼻翼煽动为特征的疾病，喘证往往没有喉间痰鸣这一症状。所以明·虞天民在《医学正传·哮喘》篇中说：“哮以声响名，喘以气息言。”就是这个道理。

哮证在临床上分为冷哮和热哮两大类。但无论是冷哮还是热哮在病因上均可分为主因与诱因。主因皆为宿疾。内伏于肺。冷哮乃寒痰伏于肺内所致。但寒痰又是如何产生的呢？中医认为寒痰来源有两条途径。第一条途径为屡感风寒，失于发散，寒邪深入肺俞；第二条途径是经常饮食生冷，伤及肺气，使上焦津液不布，凝聚而成寒痰。所以《灵枢·邪气脏腑病形篇》说：“形寒饮冷则伤肺。”所谓“形寒”是指人

体感受风寒之邪，所谓“饮冷”即是饮食生冷之意。但是只有寒痰这一主因尚不足以导致哮喘发生，还需要有一定的诱因，如感受外邪、饮食、情志、劳倦等，其中尤以气候变化与本病发作最为密切，而冷哮就是因为再次感受风寒之邪所诱发。也就是说，内伏之痰为上述诱因触发，痰升气阻是发生哮喘的关键。发病之时，痰随气升，气因痰阻，阻寒气道，肺管因而变得狭窄，肺气升降不利，以致呼吸困难，气息喘促；同时，由于喘促发作，气体出入频繁，引动触发停积之痰，而出现哮喘之声。所以清·李国粹在《证治汇补·哮喘》篇中说：“哮为痰喘之久而发者，因内有壅塞之气，外有非时之感，膈有胶固之痰，三者相合，闭拒气道，搏击有声，发为哮喘。”

哮喘的发作，常骤然起病。但大多数病人是有先兆症状可查的。如咽喉作痒、喷嚏、胸中不适等。发作时，常有咽梗胸闷，逐渐呼吸困难，呼气延长，喉中痰鸣，痰粘量少，咳吐不利，甚至张口抬肩，目胀睛突，不能平卧，烦躁不安，面色苍白，唇甲青紫，额出冷汗，或伴有寒热等证。

冷哮的临床表现除呼吸急促、喉中有哮喘音外，其特点是痰白而粘，或稀薄多沫，胸膈满闷如窒，面色晦滞带青，口不渴，或渴而喜热饮，舌苔白滑、脉浮紧，或兼头痛，发热恶寒等证。那么以上症状是如何产生的呢，这是由于寒痰内伏于肺中，为诱因所触发，气道受阻，痰气相击，故喘促哮喘有声；痰不能咳出，肺气闭阻，胸阳不振，故胸膈窒闷，面色晦滞带青；口不渴为无热；渴而喜热饮为有寒；舌苔白滑也为内有寒痰之象。因是外感风寒所诱发，故可见头痛、发热恶寒、无汗、脉浮紧等证。

对于冷哮应以温肺散寒、豁痰利窍的方法治疗。方用射干麻黄汤（射干、麻黄、细辛、紫菀、冬花、半夏、五味子、生姜、大枣）或小青龙汤（麻黄、芍药、细辛、干姜、甘草、桂枝、五味子、半夏）治疗。以上两方皆有细辛、半夏，而又分别加生姜或干姜温化寒痰，以麻黄宣肺平喘，用五味子收敛耗散之气。上两方不同之处也是明显的，因射干麻黄汤有射干、紫菀、款冬花，所以化痰利咽喉之力较强；小青龙汤中因桂枝、麻黄合用，所以常用于外感风寒而内有寒痰之证。临床用方时应有所侧重。另外，在发作以后，咳痰甚多可用冷哮丸治疗，方用麻黄、细辛、杏仁、甘草、胆星、半夏、川乌、川椒、白矾、牙皂、紫菀、款冬花、神曲等，以温肺化痰。

除了内服药物之外，冷哮尚可用敷涂法治疗。临床常用白芥子涂法，即用白芥子净末50克、延胡索50克、甘遂25克、细辛25克，共为细末，加入麝香2.5克混拌均匀，用姜汁调药。于三伏天时，选肺俞、膏肓、百劳等穴涂抹上药。涂药后可能有轻微的麻木疼痛感，但不要去掉。每次敷药约一小时，方可去掉。每十天敷涂一次，常可奏效。

经治疗后，表解而哮喘渐平，或病久阳虚，哮喘而面白汗出，四肢不温，疲惫无力，气短难续，舌淡胖嫩，脉弱者，可用苏子降气汤治疗，方中有苏子、橘皮、半夏、当归、前胡、厚朴、肉桂、甘草、生姜、大枣、紫苏叶等，以温阳补虚、化痰降气。

哮证初起属实者，治宜攻邪为主，可用豁痰宣肺降逆法。由于临床上有冷哮、热哮之分（鉴别见热哮一节），因此治疗要有所区别。若病程较长，经常反复发作，正气日渐

虚损，会造成邪少虚多的哮喘发作状态。此时治疗又不可拘泥于攻邪之说，应注意培补摄纳，佐以化痰利气，这即是治疗常法中的变法。

（五）水肿

水肿也称“浮肿”、“跗肿”、“胖肿”。是指体内水液滞留，泛滥肌肤，引起头面、眼睑、四肢、腹背甚至全身浮肿的病证。严重时，可伴有胸水、腹水。《内经》将本病称作“水”，并按不同的临床表现，把水肿分为风水、石水、涌水等几种。汉·张仲景则把本病称为“水气”，其分类方法有两种：其一是根据病因脉证不同而把本病分为风水、皮水、正水、石水；其二是按五脏的证候偏轻偏重，把本病分为心水、肝水、脾水、肺水、肾水。目前水肿的分类方法则是按金元时期医家朱丹溪的分类方法，即把水肿分为阳水、阴水两大类。

阳水中常见的证型之一是风水泛滥。本型水肿是由于外感风寒之邪，由皮毛内侵于肺，致使肺气不宣，壅遏不畅。因为肺为水之上源，又主皮毛，当肺气失宣时，不能通调水道，下输膀胱。这样就会使风遏水阻，风水相搏，水邪流溢于肌肤，引起水肿。

当然水肿的发生除了与肺有关外，还与脾、肾两脏有关。因为人体水液的代谢，输布主要是靠肺气的通调，脾气的转输，肾气的开阖以及三焦和膀胱的气化功能的正常来维持的。若外感风邪水湿，内伤饮食劳倦，不仅会造成肺气不宣，不能通调水道，而且会引起脾为湿困，运化不健和肾气亏虚，开阖不利，膀胱气化功能失司，这样就可以引起水邪泛滥。而在发病机理上，肺、脾、肾三者又是相互联系、相互影响

的。正如《景岳全书·肿胀》篇说的那样：“凡水肿等证，乃肺脾肾三脏相干之病。盖水为至阴，故其本在肾；水化于气，故其标在肺；水惟畏土，故其制在脾。今肺虚则气不化精而化水，脾虚则土不制水而反克，肾虚则水无所主而妄行。”这段文字说明了水肿的发病与肺、脾、肾三脏的关系以及水肿发病的标本关键所在。但风水泛滥却以风邪袭人，肺不化精及通调水道功能失常为主，其它两脏功能失常并不占主导地位。

风水泛滥型的水肿常从眼睑肿起，继则四肢及全身皆肿，来势迅速，肢节酸重，小便不利，常伴有恶寒、发热等证。或有咳嗽而喘，舌苔薄白、脉浮滑或紧的表现。上述症状的产生与外感风寒之邪有关。由于外感风邪，肺气失宣，肺之通调水道功能失职，故小便不利，水津泛滥而发为水肿。因风为阳邪，其性轻扬，且善行而数变，故其水肿首先见于眼睑及头面等人体之高处，随即迅速波及全身肢体。因外感风寒之邪，邪在肌表，卫阳被遏，正邪相搏，故可见恶寒、发热、肢体酸痛。因肺气郁闷，肃降失司，故可见咳嗽而喘。苔薄白、脉浮滑或浮紧是风水偏寒的表现。

治疗水肿先应辨别阳水与阴水。阳水的病因多为风邪、湿浊相搏而成；发病急速；水肿自上而下蔓延，多由头面部开始，而后遍及全身，以上半身肿较显著；按之凹陷，容易恢复；并常有身热、恶寒等表证。阴水的病因常为脾肾虚弱所致；发病较缓慢，水肿自下而上蔓延，多为下肢先肿，或单腹胀满，以下半身水肿较明显；按之凹陷，恢复较慢；一般无寒热表证。以上几点是阳水、阴水的鉴别要点，这是辨证施治中一个十分重要的问题。

风水泛滥型水肿应与水湿浸渍型水肿相鉴别。两型水肿虽都属于阳水范畴，且均有全身水肿和小便短少的特点。但风水泛滥型水肿具有发病急骤，水肿始发于眼睑及头面和病程较短的特点；而水湿浸渍型的水肿则发病相对较慢，且有包括头面在内的全身浮肿，肢体沉重和胸闷纳呆较明显，此外还有病程较长的特点。

治疗水肿的第一个要点，是分部论治、驱邪外出。《金匱要略》指出：“诸有水者，腰以下肿，当利小便，腰以上肿，当发汗乃愈。”这是因为腰以上肿势明显，责之肺卫失宣，宜发汗，宣通肺气，以达到通调水道的目的。腰以下肿势明显，责之膀胱气化不行，宜利小便，使水邪从小便而去。第二个要点是治水必兼治气，要顺气以导水，常用的顺气药为苏叶、陈皮、槟榔、沉香、腹皮、砂仁、木香等。

风水泛滥型的水肿当采用疏散风邪、宣肺行水的方法治疗。《素问·汤液醪醴》篇在论及水肿的治法时说过，水肿应“平治于权衡，去菀陈莖……开鬼门，洁净府”。所谓“鬼门”即魄门，也就是汗孔。开鬼门，就是发汗的治法。说明发汗的方法对治疗水肿，特别是风水泛滥型水肿具有重要意义。

风水泛滥型的水肿一般以越婢加术汤治疗，方由麻黄、石膏、生姜、大枣、白术、甘草等组成。方中麻黄散风宣肺，能利水消肿；白术健脾利水，两药相配，使肺气宣通，水湿下行，则风水自退；生姜、甘草、大枣，调和营卫。如感受风寒之邪，可去石膏，加羌活、防风以疏风散寒解表。如咳嗽较明显，可加杏仁、前胡，严重者甚至可加桑白皮、葶苈子以泻肺平喘行水；如兼有咽喉肿痛，可加银花、连翘、公英、牛蒡子、象贝、黄芩之类。

在治疗水肿病时，一定要正确运用攻逐水邪法。攻逐水邪的疗法是根据《内经》“去菀陈莖”的治则而确立的，它是治疗水肿的重要方法之一。攻逐水邪法可以使水邪从大小便而去，使肿势减轻。但在攻逐水邪时，一定要注意正气与邪气两方面的情况。只有在正气未伤，而邪气又盛，用其它治疗方法无效时，才可使用攻逐水邪法。不能不顾正气与邪气情况，图一时之快，在攻逐的同时，造成脾胃正气损伤。这样，即使能消退水邪，但不久肿势又起，病人经久难愈。因此水肿病人，仍以宣肺发汗，通阳利水、健脾温肾为主要治法。用这些方法治疗水肿，虽然水肿消退较慢，但一旦消退则疗效往往肯定，治疗往往彻底，水肿不易再复发。

水肿的调护也十分重要。首先，要注意饮食禁忌。凡盐、醋、醇酒、生冷、发物（如虾蟹、笋等）、腥、膻、厚味都要忌口。特别是盐（包括酱油和盐腌食物）要特别注意。元代有一位叫危亦林的医家对水肿忌盐的重要性十分重视，对于不肯忌盐的水肿病人，他从来不肯开方治疗。他在《得效方》中说：“凡水肿，惟忌盐。虽毫末许不得入口……不能忌盐，勿服药。果欲去病，切须忌盐。”忌盐期间，如饮食乏味，可用咸秋石研末代替食盐，或用忌盐酱油也可。其次，要调节寒温，防止感冒。临床的经验表明，病人每感冒一次，水肿就加重一次；有些病人水肿刚消，只因患感冒就再度发生水肿。如反复多次，阳水就会转为阴水，以致正虚邪实，造成治疗困难的局面。最后，还要指出，水肿的病人还要戒忿怒，远房事，避免劳倦过度。这些对于水肿病人的治疗也十分重要。

（六）自汗

汗证是不正常汗液外泄病证的总称。所谓不正常的汗液外泄是指不因厚衣、气温升高、剧烈运动或进食发汗剂而出现汗液外泄的病证。汗证包括自汗、盗汗、黄汗、战汗及绝汗等五种病证。自汗证是指白昼时时汗出，动则益甚，汗后身凉的病证。是汗证中较为常见的病证之一。古代医家虽有“自汗属阳虚，盗汗属阴虚”之说，但自汗的病因并不单纯是阳虚之病，还有外感风寒，营卫不和以及热淫于内，肺胃热感所致的。所以成无已在《伤寒明理论·自汗》中说：“自汗之证，又有表里之别焉，虚实之异焉。”

人之卫气有固护津液，不使汗液妄泄的功能。而卫气又为肺所主，所以当肺受风寒之邪侵袭，造成营卫不和、肺卫失调，以致肌表疏松、腠理开泄，汗液失固，最后引起自汗之证。此种自汗证，临床也称营卫不和型自汗证。

这种类型的自汗证常见于表虚而感受风寒之邪的病人。其主证为汗出恶风，周身酸楚，时寒时热，脉缓，苔薄白。这些证状的产生是由于表虚之人，感受风寒之邪后，致使营卫不和，肌表疏松，毛孔开放，汗液自泄；因外感风寒，所以除上述证候外尚有恶风，周身酸楚，时寒时热的表现。脉缓、苔薄白均属营卫不和之征。

营卫不和引起的自汗证应以调和营卫的方法治之。常用桂枝汤治疗，方由桂枝、芍药、生姜、炙甘草、大枣组成。方中桂枝散风寒以解肌发表，辅以白芍和营敛阴，使桂枝辛散不致伤阴，桂枝芍药合用，一散一收，调和营卫使腠理固密。生姜助桂枝以散表邪，大枣助白芍以和营卫，两药共为佐药；炙甘草调和诸药为使。若表虚汗多者可加生黄芪益气固表。若汗多苔白腻且体重者可加防风、白术以祛风化湿，

湿化则汗自止。有人会问，桂枝汤是发汗剂，为什么还用它治疗自汗之证呢？这是因为桂枝汤有主治外感风寒之表虚证的功效。根据张仲景创立桂枝汤的本义，这个方剂是治疗太阳中风证的方剂。由于外感风邪，邪正相搏，故见头痛、发热、脉浮；营卫不和，卫阳不能外固则肌表疏松而恶风；营阴不能内守故汗出、脉缓。所以太阳中风证可用解肌发表、调和营卫的桂枝汤治疗。外邪得出，营卫得和，自汗之证则可痊愈。另外如果临床治疗目的主要是发汗祛邪，则应加重桂枝用量，减少芍药的剂量，若主要用以止汗，桂枝用量宜减少，芍药的用量应相对增加。

治疗汗证时还应注意，由于汗为心之液，乃精气所化，出汗过多必伤正气阴血，使疾病难以治愈。故治疗汗证时应抓紧时机，及时调整机体的阴阳气血，以期早日达到汗止病愈的目的。

（七）小儿肺炎喘咳

肺炎喘咳的命名首先见于清代医家谢玉琼所著《麻科活人全书》。本病是小儿、特别是婴幼儿常见病、多发病之一，以冬春两季发病最多。典型的肺炎喘咳是以发热、咳嗽、气促、鼻翼煽动为特点。根据这一特征，历代文献中也有称之为外感咳喘、肺风痰喘、肺热咳喘、火热喘急和马脾风的。

外感所致肺炎喘咳的成因，在外为感受风寒之邪，或从皮毛、或由口鼻而入；在内则因为小儿形体未充，卫外未固，肺脏娇嫩，或因禀赋不足，后天失调，或因患及它病而造成正气虚弱，抗病能力低下而发病。其病理为风邪侵袭肺卫，肺被邪束引起肺气闭郁不宣，化热烁津，炼液成痰，阻

于气道，肃降无权，而产生肺炎喘咳的一系列证状。因风邪有挟寒、挟热的不同，故临床上可以分为风寒与风热两大类型。但应注意，一方面小儿具有“稚阴未长”和“六气之邪，易从火化”的生理病理特点，故虽初感风寒，也极易化热，风寒证状比较少见，且显时短暂。另一方面，小儿“稚阳未充”，故常常可迅速转变为邪陷正虚危急状态。总之，肺炎喘咳的病因病理是外因责之于风邪，内因责之于皮毛不固，肌肤不实、肺脏娇嫩。病位主要在肺，常累及于脾，也可内窜心肝。痰是主要病理产物，肺气闭塞是主要病理演变结局。

风寒束肺型肺炎喘咳的主证是恶寒发热、无汗、不渴、咳嗽不畅而气短，痰白且稀，舌苔薄白或白腻，舌质不红，指纹青红，多在风关，脉浮紧。

由于肺职司呼吸而主清肃，外合皮毛，开窍于鼻。风邪外袭，内犯于肺，肺为邪气所阻，不能宣达；加之肺不化津，津液转为痰液，阻于气道，以致肃降无权。所以病儿不但有恶寒、发热、无汗等表证，而且还有肺气闭塞失降上逆所致的一系列证候。如：咳嗽、鼻煽，喉中痰鸣，喘促，气短的表现。因外感寒邪，所以口不渴、痰白且稀。舌质不红，指纹青红、多在风关、以及脉浮紧均为外感寒邪的表现。

本证型的治疗方法为辛温解表、宣肺化痰。方用华盖散加减，本方由麻黄、杏仁、苏子、陈皮、半夏、紫菀、款冬花、生姜、大枣组成。方中麻黄辛温解表、止咳平喘；杏仁、苏子降气平喘；陈皮、半夏化痰止咳；紫菀、款冬花止咳宣肺。如痰多者，可加莱菔子、白芥子；表里俱寒者可加细辛、熟附子，也可以用三拗汤（麻黄、杏仁、甘草）合葱

鼓汤（见风寒感冒一节）治疗。

外感风寒所致肺炎喘咳的重要变证之一是肺气闭塞，心阳虚衰。此时病儿可见面色苍白，口唇紫绀，呼吸浅促，四肢欠温，虚烦不安，舌质暗紫、脉虚弱或微弱，指纹沉而色青，可达命关。此时应以开宣肺气，温补心阳治之。用麻黄汤合参附汤加减治疗，方由麻黄、桂枝、杏仁、甘草、人参、附子、细辛、干姜等组成。如呼吸微弱，呼多吸少，脉微细欲绝，可加麝香、樟脑（冲服），还可以用上两味药外用闻鼻，或隔姜灸人中、百会、神厥、气海等穴位；如面色青灰，大汗淋漓、四肢厥冷，此为阳气虚脱。这时急宜回阳固脱。选用参附龙牡汤治疗，方由人参、附子、龙骨、牡蛎组成，同时加用肉桂、五味子、山萸肉、干姜、炙草等助阳敛阴之品。如心阳不振，血脉不得温运，以致引起血瘀并加重了肺气闭塞之证，此时应加入丹参、红花、当归等活血化瘀之品。

（八）顿咳

顿咳是儿童感受时邪，痰浊阻滞气道，肺气不畅所引起的一种病证。该证咳嗽具有明显的阵发性、痉挛性，咳嗽后伴有吼声以及病程长的特点。因本病有传染性，易引起流行，故又称“疫咳”、“时行咳嗽”；因其咳嗽的状态和咳嗽具有连续性，故又称“鹭鸶咳”；因本病发作一阵后，停顿缓解片刻，又再次发作，每天可发作数次、数十次，故又称“顿咳”；因其咳嗽时带特殊的哮喘声，类似母鸡下蛋后的啼声，所以又称“鸡咳”；因其病程较长，缠绵难愈，故又称“百日咳”。

本病的发生虽然与感受时行风邪有关，但时行风邪有偏

热、偏寒之不同。通常是在素体正气不足、调护失宜、内蕴伏痰的基础上，时行风邪从肺卫或口鼻而入，侵袭人体，外邪与伏痰搏结，郁而化热，热邪更加煎灼津液，使痰浊更壅盛。痰浊之邪阻塞气道，肺失清肃，壅塞不得宣降，以致肺气上逆而致痉咳阵作。只有当粘稠痰液咳出，气道得以畅通时，痉咳才得以暂时缓解。风寒型顿咳为感受偏风寒之时邪引起。

顿咳患儿往往有接触顿咳病人史。初咳期的偏于风寒者，颇似外感风寒之表现。临床常见有鼻流清涕、喷嚏、咳嗽、痰白而稀，多泡沫，舌苔薄白、脉浮、指纹淡红的表现。其中以咳声重浊，恶寒无汗为其特点。因外感风寒时邪，内传于肺，肺气不宣，肺金不鸣故咳声重浊；风寒闭窍，卫阳被遏，故无汗恶寒。因外感风寒之邪故咳嗽，咳痰白而稀薄，且有喷嚏、鼻流清涕之证。本证应以疏风散寒、宣肺化痰之法治疗。可选用加减金沸草散治疗，方由旋复花、前胡、荆芥、细辛、百部、川贝、半夏组成。方中荆芥、细辛温解表、疏风散寒；旋复花宣肺降气止咳；前胡、百部宣肺理气止咳，川贝、半夏化痰止咳。方中还可加入麻黄、杏仁以增加疏风散寒止咳之力。也可选用止嗽散（桔梗、荆芥、紫菀、百部、白前、甘草、陈皮）治疗。方中紫菀、白前、百部、陈皮理气化痰止咳；荆芥、桔梗疏风宣肺；甘草调和诸药，与桔梗同用可达到兼利咽喉的目的。

临床治疗顿咳也可选用猪、牛、羊、鸡的胆汁治疗，鲜用及干燥制粉均可。但以猪、鸡胆汁为最好。以新鲜鸡胆为例，其用量按每岁半个鸡胆，最多不超过三个，一日两次服用。干粉每次服用0.3~0.5克，一日两次，效果很好。

（九）急惊风

惊风是一种以抽搐或伴有神昏为主证的儿科疾病。本病又称“惊厥”，俗称“抽风”。常以起病急，神志昏迷，两目凝视，牙关紧闭，颈项强直，四肢抽搐为特点。一般以1～5岁婴幼儿为多见。其病来急暴，实证突出者为急惊风；病来缓慢虚证明显者称为慢惊风。急惊风因其病势突然、来势凶险，变化迅速，往往威胁病儿生命。慢惊风中的慢脾风预后也差。惊风和麻疹、痘疹、疳证合称儿科四大证。宋代以前并无本病病名记载，直至北宋·钱乙才在《小儿药证直诀》中首创“惊风”病名，并把惊风分为急惊风与慢惊风两类。由于惊风的主要证状是项背强直和痉挛，因此某些医家把“痉”和“惊”作为通用名称而不加区别。如《温病条辨》中就有“痉为惊风”的记载。即使现在也有人习惯地把小儿时期抽搐、痉挛的证状称为惊风的，把成人出现惊厥的称为痉病的。

急惊风的病因之一为外感风寒，尤其在寒暖不调季节最易发生。由于小儿肌腠不密，极易感受风寒邪毒，侵犯肌腠，内传于肺。况且小儿脏腑娇嫩，真阴不足，形气未充，又为纯阳之体，感邪之后，易从热化。故初期虽有风寒见证，继则引动肝木，内风蠢动或逆传心包，火助风威，或热甚炼液成痰，蒙蔽清窍以致引起神昏痉厥等证。

急惊风来势急骤，但其发作前常有发热、呕吐、烦躁不宁、摇头弄舌、睡卧惊惕、时发惊啼、或摇头弄舌、咬牙齟齿以及昏沉嗜睡等先兆。其发病主证为身有壮热，痰涎壅盛，四肢拘急，筋脉牵掣，项背强直，目睛上视，牙关紧急，唇口焦干，抽搐昏迷。所以急惊风常以“惊、风、痰、热”四

证并出为其特有症状。因于风寒发病的较大儿童可诉头痛、恶寒及背脊颈项牵引酸痛等感觉；幼小儿童常呈神情不宁，呕吐乳食，壮热无汗，继则颈项强直；神志昏迷，四肢抽搐，舌苔薄白或白腻，脉象浮紧，指纹浮而青紫。但上述表寒证，均在初期出现，持续时间较短，继则化热化火，而出现里热证候。

之所以产生上述证候是因外感风寒，侵袭太阳肌表故可见头痛恶寒、项强拘急、壮热无汗、舌苔白腻等证状。如寒邪化火，内传心包，则神志昏迷。脉浮紧、指纹浮而青紫，是属风寒外感之证。

本型的急惊风之证应用疏风解肌、佐以开窍镇痉之法。方用葛根汤治疗，本方由葛根、麻黄、生姜、桂枝、芍药、甘草、大枣组成。可佐以石菖蒲、天麻、钩藤等品以开窍镇痉。方中麻黄、桂枝辛温散寒解表，葛根解肌退热，芍药和营敛阴，防止麻、桂辛散太过；生姜助麻黄、桂枝解表邪，甘草调和诸药。如证见汗出、发热、恶风者则宜用瓜蒌桂枝汤治疗，方由瓜蒌根、桂枝、芍药、生姜、甘草、大枣等组成。本方重在解肌，方中瓜蒌根具有滋养津液的作用。

(十) 产后发热

产后一、二日阴血骤虚，不能敛阳，阳气浮越于外，常有轻微发热现象，一般不作病论。但如果持续发热不减，或突然高热，伴有其它证状者，则称之为“产后发热”证。

外感风寒是产后发热的重要原因之一。这是由于产后失血伤气，百脉空虚，腠理不密，卫外之气不固，以致风寒之邪易于乘虚而入造成营卫不和而发热。故《医宗金鉴》说：“产后发热之故非止一端……感受风寒，则为外感发热。”

本证型产后发热的主证为发热、恶寒，头痛，肢体疼痛，无汗或见咳嗽，流涕，舌苔薄白，脉浮。由此可见，其主要表现与外感风寒型感冒相似，这里不再赘述其产生机理。本证的发生，虽与外感风寒型感冒有相同的外因，但本证却是在产后气血大虚、卫外不固的基础上感受风寒之邪引起的。

有鉴于此，对外感风寒型产后发热的治法与外感风寒型感冒治法有所不同。本证只宜用养血疏风之法，方用四物汤（当归、白芍、川芎、熟地黄）加苏叶、防风、荆芥、甘草。方中四物汤养血调血，荆芥、防风、苏叶疏风解表，甘草和中，上药共同达到养血扶正，疏散风寒的作用。

治疗产后发热应以调气血和营卫为主。因为虚多实少，虽有外感风寒表证，但也不宜过于发表，强行发汗。虽有气血不足的表现，又不可以强调甘温除热，而忽视其外感之证，以致犯虚虚实实之误。正如《沈氏女科辑要笺正》说的那样：“新产发热……感冒者，必有表证可辨，然也不当妄事疏散。诸亡血虚家不可发汗……则惟和其营卫，慎其起居，而感邪亦能自解。”

二、风热袭肺

风热袭肺证是指由于风热侵犯，内袭于肺，外邪壅滞，肺失宣降肃而引起以发热恶风，头痛身痛，鼻流浊涕，咳嗽声急，痰黄而稠粘不易咳出，口渴咽痛，喘促息粗，舌红苔薄黄，脉浮数为主证的一种病证。

由于外感风热、肺卫被遏，正邪相搏，故可见发热恶风，头痛身痛等表证；肺开窍于鼻，肺为风热所束，故鼻流浊涕；

肺气失其宣发肃降功能而上逆，故咳嗽声急，甚至喘促息粗；风热之邪煎灼津液成痰，所以痰黄稠粘而不易咳出；口渴咽痛也是风热袭肺，耗伤津液的结果；由于肺居胸中，风热袭肺，肺的气机不利故胸痛。舌红、苔薄黄、脉浮数均为外感风热之征。风热袭肺的常见病证是内科的感冒、咳嗽、喘证、肺痈，咳血，儿科的肺炎喘咳、风疹、急惊风、流脑、顿咳以及妇科的妊娠咳嗽和产后发热等。

（一）感冒

外感风热型的感冒的病因为风热之邪乘人体正气虚弱、肺卫调节功能失常之时，侵袭人之肌表，内传于肺而发生。风热袭肺引起的感冒好发于春季。

外感风热型的感冒，除了有感冒的头痛、鼻塞、流涕、喷嚏、发热等共有症状外，还有自己的特点。这些特点是发热而兼微恶风寒，或有汗出，鼻流浊涕，咽喉红肿疼痛，咳嗽痰黄稠粘，苔薄黄、脉浮数等。

上述症状之所以产生是由于风热上受，首先犯肺，肺主气属卫，卫气失于宣畅所致。因外感风热而非风寒故以发热为主，其畏恶风寒程度较轻；风热为阳邪，热蒸肌表，肌腠疏懈，故可见汗出而病邪不解；风热为阳邪，阳从火化，易伤阴津，故口干而渴；风热上扰则头痛，鼻流浊涕、咽喉红肿疼痛；风热袭肺，肺失清肃，煎灼津液则咳嗽且咳痰黄稠，苔薄黄，脉浮数为风热侵于肺卫之象。

风热感冒的治法为辛凉解表，清肺透热。方用银翘散治疗，本方由金银花、连翘、豆豉、牛蒡子、薄荷、荆芥穗、桔梗、甘草、竹叶鲜芦根等组成。方中金银花、连翘辛凉解表，清热解毒为主药；薄荷、荆芥、淡豆豉疏风解表、透热外出

为辅药；其中荆芥穗虽属辛温之品，但温而不燥，且与金银花、连翘、竹叶、芦根配合，温性被制，可增强本方辛散解表之功；桔梗、牛蒡子、甘草宣肺祛痰、利咽散结；竹叶、芦根甘凉清热、生津止渴。如头痛较重者加桑叶、菊花以清利头目。咳嗽痰多者加杏仁、浙贝母、瓜蒌皮以止咳化痰。咽喉红肿疼痛者去荆芥加板蓝根、马勃、玄参之类以清热解毒利咽。兼有鼻衄者加茅根、竹茹等。若见高热、恶寒、头痛、鼻干、口渴、心烦、舌红苔黄者为风热重证；可加葛根解肌、加黄芩、石膏清热，加知母、花粉生津，以使热退津回，感冒得愈。

风热感冒常挟有湿邪。此时病人多兼有头重体倦，胸闷泛恶，小便黄，舌苔黄腻。此时可于银翘散内加藿香、佩兰以清风热化湿浊。

如夏季患感冒，则多挟暑湿。此时临床表现为高热，有汗而热不解，身重倦怠，口渴，小便短赤，舌苔黄腻，脉多濡数。此时治宜清暑利湿，可用新加香薷散（香薷、鲜扁豆花、厚朴、金银花、连翘）再加鲜荷叶，荷梗、鲜藿香、泽兰、西瓜皮等清化暑湿。

秋季感冒多挟燥邪。证见发热而微恶风寒，头痛干咳，咽干口燥，烦热口渴，舌红少津，脉略数。可用桑杏汤（桑叶、杏仁、沙参、浙贝母、豆豉、山栀、梨皮）以疏风清燥，肃肺养阴。

风热感冒需与风寒感冒相鉴别。一般说来，风寒感冒的恶寒重于发热，口不渴，咽喉不肿痛，头痛连及项背，常兼有骨节烦痛，舌苔薄白，脉浮紧不数之证；风热感冒的发热重而恶寒轻，或仅有恶风的感觉，常有口干渴，咽喉红肿，

头痛较剧烈，舌质红，苔薄黄，脉浮数等证。掌握以上各点，鉴别不难。

临床上治疗风热感冒要注意两点：其一是发汗不宜太过。因风热之邪最易伤津，服药后以微出其汗为度，汗出过多会重伤其阴津而导致变证；其二是在辛凉解表的处方中可加入适量的清热药，但辛凉解表剂与清热药的比例要适当。一般说来，辛凉解表药应大于清热药。因为清热药过多，会影响辛凉解表药的效力，从而影响疏散风邪药物的作用；但是如果只用疏散风热之品，而不用清热药，就会造成风热虽去而里热不能尽除的结果，以致热邪伤津，引起多种变证。

（二）咳嗽

外感风热型咳嗽的病因是由于人体遭受风热之邪侵袭，邪气或从皮毛而入，或从口鼻而入，肺卫受邪，肺气不宣，清肃失常，肺气上逆而致咳嗽；同时由于肺布散津液的功能失常，痰液滋生，阻塞气道，影响肺气之出入，从而加重了病人的咳嗽。

本型咳嗽的特点是咳嗽，气粗，咳声嘶哑，咳痰不爽，痰稠而黄，口渴咽痛。同时伴有头痛、身热、恶风、汗出、舌苔薄黄、脉浮数等外感风热表证。

以上症状的产生是由于风热客肺，肺失清肃，故而咳嗽；火灼津液为痰，痰热壅塞气道，呼吸不利故气粗，咳声嘶哑。且风热之邪为阳邪，易于化火煎灼津液，故咳嗽痰黄而稠，咳而不爽，兼有口渴；肺系于咽喉，风热犯肺故可见咽痛证；邪客皮毛，正邪相搏，故有身热；因感受风热之邪，热为阳邪，常使腠理毛孔开泄，故见恶风一证；风热上扰清窍则头痛；风热之邪主疏泄，致使腠理开发，故汗出；

舌苔薄黄、脉浮数为风热在表之舌脉表现。

本证咳嗽应取疏风清热、宣肺化痰之法。以桑菊饮为代表方剂，方由桑叶、菊花、连翘、薄荷、桔梗、杏仁、芦根、甘草等组成。方中桑叶、菊花甘凉清轻，疏散上焦风热，且桑叶善走肺经，善清肺热止咳嗽，上二药均为主药；薄荷协助桑、菊疏散上焦风热；连翘辛凉解表而清风热；杏仁、桔梗宣肺止咳；芦根生津止渴。方中还可加入前胡、牛蒡子等以增强宣肺之力。肺热盛者加黄芩；口干津少者加麦冬、沙参；如见鼻衄可加茅根、藕节以凉血清肺。

风热咳嗽与风寒咳嗽的鉴别要点，一是全身症状不同：外感风热者发热较重，恶风而汗出，舌苔薄黄、脉浮数；外感风寒者恶寒重而发热轻，无汗，舌苔薄白、脉浮紧。二是咳痰的性质也不相同：外感风热咳痰黄稠不易咳出；外感风寒咳痰稀薄，咳之较易。三是外感风热咳嗽常兼咳声嘶哑，而外感风寒咳嗽常以咳声重浊为特点。

（三）喘证

风热袭肺型喘证为实喘证型之一。常因风热之邪侵袭肺脏，肺气壅实，肃降失司，肺气不降，上逆为喘。风热喘证常由风热咳嗽未加治疗或失治发展而来。所以《景岳全书·喘促》篇说：“实喘之证，以邪实在肺也，肺之实邪，非风寒则火邪耳。”

本型喘证的主证为喘促气急，甚则鼻翼煽动，伴有咳嗽，痰稠色黄，难以咳出，或有胸痛，烦闷口渴，身热，汗出，恶风，苔薄黄，脉浮数。由于外感风热之邪故可见恶风、汗出；热感气壅，肺气奔迫，而肺又开窍于鼻，故喘促气急，甚则鼻煽；热感伤津则口渴；津液被灼为痰，则痰稠粘难以

咳出；痰热交阻胸中则胸中烦闷；苔薄黄、脉浮数是风热在表之征。

本证的治疗方法为清热解表、宣肺平喘。方剂为麻杏石甘汤（见风寒束肺型咳嗽一节）本方重用石膏，因石膏味辛其性寒，有清泻肺之热邪而生津的作用；麻黄辛苦温，清里达表，宣肺平喘。二药相制为用，既能宣肺，又能泄热，虽一辛温，一辛寒，但辛寒大于辛温，使本方不失辛凉之意；方中又用杏仁、甘草化痰止咳平喘为助。本方还可以加桑叶、菊花、黄芩、瓜蒌等疏风、清热、化痰之品。如咳甚者可加前胡、枇杷叶；口渴甚者可加知母、花粉；痰壅气喘者可加葶苈子、桑皮；身热苔黄甚者可加黄连、山栀；吐痰带血或铁锈色痰者加黛蛤散、生地、柏叶炭；舌红少津者加生地、玄参；大便秘结者加大黄、火麻仁；胸痛者加桃仁、郁金。

风热束肺型喘证需与风寒束肺型喘证相鉴别。外感风寒型喘证的咳痰常稀薄色白多泡沫，并有口不渴，无汗、恶寒重，发热轻，苔薄白，脉浮紧的表现；风热束肺型喘证常有咳嗽、咳痰黄稠，难以咳出以及胸痛、胸闷，心烦、口渴，汗出，发热重，微恶风，舌苔薄黄，脉浮数等特点。以上各要点，可供临床鉴别之用。

（四）肺病

肺病是肺部生脓疡的一种病证。是以咳嗽、胸痛、发热和吐痰腥臭，甚则咳吐脓血为主证的疾病。本病最早记载见于《金匱要略·肺痿肺病咳逆上气病》篇。张仲景在论述肺病一证时说：“咳而胸闷振寒，脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥样，为肺病。”

本病的产生有内外两大因素。内在因素为正气素虚或痰

热素盛，或嗜酒不节，过食辛热厚味致使湿热内蕴，上蒸于肺；外因则为感受风热之邪或风寒化热。内外之邪交炽，热毒壅肺，蓄热内蒸，热壅血瘀，热盛则肉腐血败，形成脓病。

肺痛的初期为风热外袭，热伤肺气，邪束卫表，病在肺卫；继则邪热内郁于肺，气分之热毒浸淫及血，热伤血脉，热壅血瘀，蕴酿成脓；终则血脉阻滞，热盛肉腐，血败成脓，咳吐脓血。所以《金匱要略·肺痿肺痛咳嗽上气》篇说：

“风伤皮毛，热伤血脉，风舍于肺……热之所过，血为之凝滞，蓄结痈脓，吐如米粥。”

肺痛证的初期症状常与感受风热之邪有关，因此出现发热恶风，咳嗽痰少而稠粘，胸痛，咳时尤甚，呼吸不利，口干鼻燥，舌苔薄黄，脉浮滑而数等症状。

由于外感风热，表卫受邪，正邪相争故见发热恶风之证。邪犯于肺，肺为热毒熏灼，肺失清肃，气机不畅，故可见咳嗽胸痛，呼吸不利等证。热灼津液故痰粘而少，口干鼻燥。舌苔薄黄、脉浮滑而数皆是风热之邪作祟之证。

肺痛初期应采用疏散风热、清肺化痰之法治疗。方用银翘散（见风热感冒一节）加鱼腥草治疗。方中银花、连翘、芦根、竹叶疏散风热、清热解毒；薄荷、荆芥、豆豉、牛蒡子、桂枝疏风宣肺。鱼腥草有较强的清热解毒之力，应加重剂量。若头痛可加菊花、桑叶、蔓荆子以疏风热、清头目；咳甚痰多者加瓜蒌仁、贝母、杏仁以润肺化痰、化痰止痛；喘甚者可合用麻杏石甘汤（见风寒袭肺型咳嗽一节）以清肺平喘，或合用桑菊饮（见风热袭肺型咳嗽一节）。

肺痛成痈期可按清热解毒、化瘀散结之法治疗，方用《千

金》苇茎汤（鲜芦根、薏苡仁、冬瓜仁、桃仁）。溃脓期用排脓、清热、解毒之法，方用《千金》苇茎汤合桔梗汤（桔梗、生甘草）。因成脓期为热毒壅肺，热壅血瘀所致；溃脓期为热毒炽盛、血败肉腐所致。这些并非为风热袭肺讨论的范围，故简述如上。

肺痈初期为风热袭肺，应使用疏风清热之法治疗，故初期应用银翘散之类药物治疗。清·喻昌在《医门法律·肺痈肺痿门》中说：“凡治肺痈病，以清肺热，救肺气，俾使肺叶不致焦腐，其金乃生，故清一分肺热，即有一分肺气。”所以其用药应以金银花、连翘、鱼腥草为主；成痈期和溃脓期应用大青叶、败酱草、鸭跖草、虎杖草、野荞麦根为主。另外，因肺与大肠相表里，大肠的传导有助肺气宣降的功能，所以治疗肺痈时应注意大便通畅，以使热邪有出路。

（五）咳血、鼻衄

咳血、鼻衄均属中医急证之一的血证的范畴。咳血是指肺络受伤所引起的一种随咳嗽而咳出血液，或痰血相兼，或痰中带血的一种病证。也有不经咳而咯出血者，临床上称为“咯血”，咳血与咯血治法相同。鼻衄是指血液不循常道，上溢于鼻窍的病证。

总的说来，包括咳血、鼻衄在内的血证形成原因，是与“火”和“气”有关。因火热为阳邪，能迫血妄行而使血溢于经脉之外；而气为血帅，血随气行，气行则血行，气脱则血脱。所以张景岳在《景岳全书·血证》中说：“而血动之由，惟火惟气耳。”“动者多由于火，火盛则逼血妄行；损者多由于气，气伤则血无以存。”风热袭肺引起的血证属实证。而这种证型的咳血多由于外感风热之邪，由皮表而入于肺脏，火热之

邪损伤肺络，迫血妄行而致咳血。除此之外因肺开窍于鼻，如风热袭肺，上冲其窍，损伤肺窍的络脉也可致鼻衄。所以在《临证指南医案·吐血·邵新甫按》中说：“若夫外因起见，阳邪为多。盖犯是证者，阴分先虚，多受天之风热燥火也。”说明外感风热或火热之邪，在血证的病因中是起着重要作用的。

无论是外感风热引起的咳血还是鼻中衄血，其共有证状为身热，咳嗽，口干鼻燥，舌红，苔薄黄，脉浮数。因外感风热之邪，客于肺卫，卫气郁闭故可见身热之证，肺失宣发肃降，其气上逆故见咳嗽；口干鼻燥为风热伤津之象。舌红、苔薄黄、脉浮数均为外感风热之征。

咳血一证要首辨内伤与外感，这可从临证出现的症状、舌象和脉象中加以分辨。其次，咳血一证当与吐血证相鉴别。咳血常随咳嗽或咳痰而出，咳血前常喉部发痒，血色鲜红或带泡沫，血液常与痰液或唾液相混，大便颜色正常。而吐血一证，血常随呕吐而出，并伴有上腹部不适或疼痛感，大多数的病人有恶心呕吐的自觉症状，吐出血的颜色多为深红或咖啡色，常伴有食物残渣及胃液，大便多呈紫黯粘稠状。

风热袭肺引起的咳血和鼻衄两证均可以用清肺泄热、凉血止血的方法治疗。风热袭肺型咳血常用桑杏汤（见风热感冒一节），方中以桑叶、杏仁、贝母疏风宣肺止咳；沙参、梨皮润肺生津；山栀清热凉血。方中还可加银花、连翘、菊花以清热解表。为了加强止血作用可加入茅根、藕节、茜草根、白芨、侧柏叶。如咽痛可加元参、山豆根；咳嗽明显者可加枇杷叶、知母。

风热袭肺引起的鼻衄可使用桑菊饮（见风热袭肺型咳嗽一节）治疗。本方可加丹皮、茅根、旱莲草等凉血止血之品。如肺热盛而表证已去者，可去薄荷、桔梗，加入黄芩、山梔以清肺热，或加玄参、麦冬之类以养阴清肺。

因肺为娇脏，喜润恶燥，故无论是风热袭肺引起咳血还是鼻衄，均应加入甘寒滋润之品，切忌性温动血之品。此外，因外感风热所致咳血和鼻衄均为属实的血证，应以治标止血为当务之急，待血止后再祛除病因，最后才用养血、补血、扶正之法。在治疗过程中，还要注意凉血散血法的应用。所谓“散血法”即是活血化瘀法。因离经之血，不仅阻碍新血之化生，且会加重经络阻滞而使血不易止住。所以清·唐容川在《血证论》中说：“凡吐衄，无论清凝鲜黑，总以祛瘀为先。”

叶熙春老先生曾治疗一鼻衄病人。该患者鼻血外溢，量多色鲜，脉象浮数，舌红苔黄，同时伴有头痛身热，咳嗽不爽，咽干口渴之证。叶老先生认为该患者为风热外袭，热郁于肺，当用疏风清热法治疗。初诊处方为冬桑叶三钱、白杏仁三钱、薄荷叶一钱、连翘三钱、黑山梔三钱、甘菊花一钱半、鲜芦根一尺（去节）、淡子芩一钱半、炙前胡二钱、白茅根五钱、象贝三钱。一付水煎服。二诊时病人述昨进辛凉泄热之品，身热已解，鼻血未见复来，头痛口渴亦除，唯咳嗽未平，脉象弦滑，舌苔薄黄。再拟清宣气分之剂。冬桑叶三钱、白杏仁三钱、竹茹三钱、川贝一钱半、甘菊花二钱、淡子芩一钱半、瓜蒌皮四钱、炙前胡二钱、冬瓜子四钱、鲜芦根一尺（去节）、清炙枇杷叶三钱。服药后病人症状完全解除，霍然而愈。我们认为此例病人是风热之邪不能从表而

解，内郁于肺，邪无出路，所以经肺之窍由血分发泄而出，成为鼻衄之证。故治用清肺泄热之法，表解热退，衄血自止。

（六）小儿肺炎喘咳

风热袭表型肺炎喘咳的成因是由风热之邪侵犯肺卫，肺气闭塞引起。因肺为娇脏，外合皮毛，开窍于鼻，职司呼吸而主清肃。风热之邪由皮毛或口鼻而入，外束肌表，内犯于肺，肺气为邪气阻遏，不能宣畅。同时，由于肺中津液化为痰涎，阻于气道，以致肃降无权，故可出现发热咳嗽、气促、鼻煽、喉中痰鸣等一系列肺气上逆，肺气闭塞壅滞的证状。

风热袭肺型肺炎喘咳的轻证表现为发热恶风，微有汗出，咳嗽气促，面赤唇红，口渴咽红，小便黄，大便不畅，指纹青紫多在气关，舌苔薄白微黄，脉浮数。重证则见高热不退，咳嗽频频，气急鼻煽，涕泪俱无，鼻孔如烟霉之状，喉中痰鸣，口渴烦躁，面色红赤，舌苔黄、舌质红而干，脉浮滑数。

风热袭肺型肺炎喘咳的轻证常因肺受邪较轻，故临床症状也不重。仅出现发热恶风，微有汗出，咳嗽气促，面赤唇红，口渴咽红，小便黄，大便不畅，指纹青紫，且在气关，舌苔薄白微黄，脉浮数等风热袭肺之证。而重证肺炎喘咳，邪毒炽盛，肺受邪迫，故可见烦躁口渴，高热不退之证；如肺为邪热蒸郁，化源欲绝，津液不得上承清窍，所以啼哭不见眼泪，鼻孔出现烟霉，热烁肺津，炼液为痰，气道受阻，故气急鼻煽，咳喘时喉间伴有痰声。面赤唇红、舌苔黄、舌质红而干、脉象浮滑而数，皆属风热挟痰之表现。

本证型肺炎喘咳的轻证治以辛凉解表，宣肺化痰。临床

常用方剂为银翘散（见风热袭肺型感冒一节）合麻杏石甘汤（见风寒袭肺型咳嗽一节），重证肺炎喘咳用清热解毒、化痰定喘之法。常用方剂为五虎汤（麻黄、杏仁、石膏、甘草、细茶叶）合葶苈大枣泻肺汤（甜葶苈、大枣）加天竺黄、胆南星、黄芩、鱼腥草，鲜竹汤（冲）治疗。五虎汤是由麻杏石甘汤加细茶叶组成，具有辛凉宣泄，清肺平喘的作用；葶苈大枣泻肺汤有下气平喘的作用；天竺黄、胆南星、鲜竹沥清热化痰；黄芩、鱼腥草清热泄肺。邪热伤阴者可用黄连解毒汤治疗，方由黄连、黄芩、黄柏、栀子组成。方中可加鲜沙参、鲜石斛、鲜生地，并佐以莱菔子或荸荠汁等以化痰热；浊邪壅闭的可加用玉枢丹（山慈菇、五倍子、千金子、红芽大戟、麝香）以辟秽化浊。

（七）风疹

风疹是一种较轻的发疹性传染病。多见于五岁以内的婴幼儿。其证初起类似伤风感冒的表现。发热一、二天后，即在全身出现淡红疹点。并有痒感，再经二、三天后隐退。常伴有耳后及枕部瘰癧（淋巴结肿大）的症状，因其皮疹细小如沙，故又称“风痧”。古代医书还有称之为“瘾疹”的。如《金匱要略》中就有“风气相搏，风强则为瘾疹”和“邪气中经，则身痒而瘾疹”的记载。该书对本证病因病机均有记载。清代的《麻科活人全书》则称之为“风瘾”。

本证的发生常因外感风热时邪，邪毒自口鼻而入，郁于肺卫，蕴于肌肤，与气血相搏，使邪毒外泄于肌肤所致。一般邪毒较轻者，只伤及肺卫，临床上仅可见到恶风、发热、喷嚏、疹色浅红而分布均匀之证；若邪毒炽盛影响营分，邪毒从血络而出，外发于肌肤，所以可见高热口渴，疹色鲜红

或红紫，融合成片等证状。

本病的诊断主要依据症状及皮疹的特点。一般来说，风疹的前驱期较短，发热 1～2 天后全身就出现浅红色细小斑丘疹。这种斑丘疹先见于头面部，随即遍及躯干、四肢、耳后。枕部可触及瘰癧（淋巴结肿大）。另外，皮疹未出现以前，咽部附近有出血性的红疹点，这种红疹点对本病的早期诊断有一定价值。

风热袭肺型风疹有恶风发热、咳嗽、目赤、流涕等全身证状。一、二天后，即可全身出现疹点，首先见于头面躯干，随即遍及四肢，大都在一天内疹点遍及全身。风疹发疹的特点是手足心处无疹点，疹色浅红，疹点细小稀疏，并有痒感。此外，还有指纹青紫，脉象浮数，多在风关等证。

之所以产生以上诸证，是外感风热时邪，肺卫受伤，故见恶风发热、喷嚏、流涕、咳嗽等证；全身疹点是风热与气血相搏，邪毒外透的表现；疹点色红、指纹色紫、目赤、脉数，均为有热之征；皮肤瘙痒、脉浮、指纹在风关，则为外感风邪的表现。

本证的治疗方法为疏风、清热、佐以解毒之法。临床常用方剂为银翘散（见风热袭肺型感冒一节）。方中银花、连翘、竹叶清热宣解；薄荷、牛蒡子疏风清热。另外，牛蒡子与桔梗、甘草配合能清利咽喉，蝉衣祛风止痒。风疹之邪热得以疏散清解，则病渐愈。如见证较重者，还可使用透疹凉解汤治疗，本方由薄荷、桑叶、甘菊、连翘、银花、蝉衣、牛蒡子、赤芍、紫花地丁、西藏红花、黄连等组成。

风疹与麻疹都有发热、出疹等相同症状，因此两者需要鉴别。麻疹与风疹的鉴别要点是麻疹的全身症状较重，疹点

逐渐出现，通常三日出齐。疹色呈暗红色，疹色稍隆起于皮肤之上，形状大小不一，无痒感。其分布除了头面、四肢、躯干外，手足心也可出现疹点，疹退后常有糠秕样脱屑及棕色斑痕。而风疹全身症状较轻，发疹较快，通常在二十四小时内出齐。疹色呈淡红色，疹形细小，皮肤有瘙痒感，其分布常在面部躯干及四肢，但唯独手足心无疹，疹退后一般无脱屑及斑痕。

（八）急惊风

风热或疫毒之邪为导致急惊风的重要原因之一。当冬春之交，寒暖不调，气候骤变，风热疫毒之邪侵及肌表，闭塞经络孔窍，故可见突然壮热、昏迷抽搐等证。风热之邪，其性属阳，化火最速，最易内陷厥阴，逆传心包。加之热盛炼液成痰，蒙闭清窍，临床常可出现神昏、痉厥等证。

外感风热之急惊风的主证为：病之初起可见发热、咳嗽，恶风、头痛等肺卫症状。继之皮肤灼热无汗，口渴饮水，舌苔薄黄、脉浮数。如风热之邪化火后，可迅即出现神昏抽搐，烦躁谵妄等证，舌苔转为黄黑或焦黑，舌质绛红生刺，呈津伤液劫的伤阴之象。

这些症状的产生是由于外感风热，肺卫受邪故见发热、咳嗽、恶风、口渴喜饮、舌苔薄黄、脉浮数等证。由于风热之邪为阳邪，化火最速，如火动风煽，内扰厥阴，热蒙心包，即见神识不清、烦躁谵狂之证。叶天士所说的“温邪上受，首先犯肺，逆传心包”指的就是这种病理变化。由于热盛生风，故可见抽搐惊厥，热盛伤阴，津液被劫，故常伴有明显伤阴证候。

本证初起应以疏风清热，开窍镇惊之法治疗。方药用银

翹散（见风热感冒一节）加菊花、蝉衣、钩藤、僵蚕、菖蒲、竹茹治疗。银翹散加菊花、蝉衣可轻宣肺卫之风热；钩藤、僵蚕、菖蒲开窍镇痉；竹茹清泻痰热。如抽搐较频繁者加羚羊角以平肝息风。

（九）流脑

“流脑”为现代医学名词，它是流行性脑脊髓膜炎的简称。临床以起病急骤、发热、头痛、呕吐、颈项强直及皮肤瘀点为特点。本病属“温疫”、“春温”的范畴。

本证为外感风热温邪而发。病邪常经口鼻侵入人体，首先可见到肺卫症状：如发热、恶风、头痛等。由于邪犯太阳经脉，故见颈项强直。病情进一步发展，邪毒入里，则出现壮热、烦躁、口渴等风热伤阴的症状。邪火犯胃，热毒上冲，故呕吐频繁。除了上述所说发热、恶寒、出汗、头痛恶心、咽干口渴外，尚可见因邪阻太阳之经而导致的颈项发硬的证候；邪热扰乱心神故烦躁不安；或有痰蒙心窍之嗜睡，精神不振等表现；邪热伤血络，迫血妄行，则可见皮肤出血点。舌苔薄黄、脉浮数为外感风热、温毒的舌脉之象。但大多数病人外感风热阶段症状短暂，或不甚明显，起病即见风热伤阴的表现，因此初期要仔细询问病情，才能正确诊断。

本证常以疏风解表、清热解毒的方法治疗。常用银翹散（见风热袭肺型感冒一节）合白虎汤（石膏、知母、甘草、粳米）再加板蓝根、黄芩、黄连、葛根治疗。银翹散加板蓝根主疏散风热解毒；葛根辛凉散邪、解肌止痉；石膏、知母、黄芩、黄连清热解毒。如头痛剧烈者当加菊花、龙胆草、钩藤；呕吐频繁者加玉枢丹（见风热袭肺型肺炎喘咳一节）冲服；嗜睡者加郁金、菖蒲；皮肤出血者可加丹皮、赤芍等。

据河北中医学院报道，该院用双解素注射液治疗流脑颇为有效。其配方为银花45克，连翘15克，生石膏30克，知母15克，黄连、贯众、板蓝根各30克，龙胆草15克，钩藤30克，生甘草9克，制成灭菌水溶液注射治疗。

（十）白喉

白喉又称“白缠喉”，是一种传染性急证。临床上以鼻、咽、喉部有白色假膜，咳如犬吠，喘鸣等为特点。本证多见于八岁以下小儿，好发于晚秋及初春季节，由于肺开窍于鼻，而咽喉又为肺所主，所以本证与肺的关系密切。

风热型白喉的发病初期，即出现外感风热的表证。如发热恶风，微汗出，头痛身痛，口干渴，舌红，苔薄黄，脉浮数等，但其特点为咽喉红肿有白点或片状假膜。治法为疏风清热解毒，方用银翘散（见风热袭肺型感冒一节）加土牛膝根、桑叶、蝉衣、玄参、山豆根等。

（十一）产后发热

风热袭肺引起的产后发热是产后外感发热的一种。是在妇女生产以后，风热之邪乘虚侵入，肺气被遏所引起。以突然发热或发热不减为主证。其表现除发热外，还有微恶风寒、头痛、咳嗽、口渴、微汗出以及舌边尖红、苔薄黄、脉浮数的证候。此型产后发热应治以养血补血、辛凉解表之法。方用银翘散（见风热袭肺型感冒一节）加养血补血之品如熟地、首乌、白芍、当归、麦冬等。

三、燥邪伤肺

燥邪伤肺的病因多由秋令感受燥邪耗伤肺津或风温诸邪

伤津化燥而成。其临床表现常为干咳少痰，痰粘难咳，或痰中带血，皮肤干燥，鼻燥咽干，音哑失音，咳甚则胸痛，发热微恶寒，舌干苔薄黄而少津，脉象小数。因燥邪伤肺，津液受伤，肺失其滋润肃降之功能，故可见咳喘，无痰或痰少而粘以及口鼻咽喉和皮肤干燥，燥热灼伤肺络，络破血溢，故痰中带血；由于津被液灼，肺失濡养，以致声道燥涩，故发音嘶哑，甚至失音；肺居胸中，燥邪伤肺故见胸痛。如燥邪初犯，伤于肌表，可有发热微恶寒等表证。舌红苔黄、脉小数，皆为燥邪化热所致。燥邪伤肺的常见病证为咳嗽、失音等证。

（一）咳嗽

燥邪伤肺型的咳嗽常见于气候干燥之秋天。此时燥气当令，侵袭肺脏，燥邪伤津，肺失濡润，进而影响肺的宣发肃降功能，肺气不能肃降反而上逆则发生咳嗽一证。

燥邪伤肺引起的咳嗽其主证为干咳无痰，或痰少稠粘难出，或痰中带血伴鼻燥、口干、咽干、甚则可见胸痛，或有恶风发热。舌尖红，苔薄黄而干，脉细略数。前已说过，本证常见于秋季燥气当令之时，燥热伤肺，肺津受灼，肺气失宣，故干咳无痰，或痰少而粘，口鼻咽喉干燥；燥热灼伤肺之络脉，络破血溢，故痰中带血；肺居胸中，燥邪伤肺，肺的气机失和，故见胸痛。如果燥邪伤于肌表，故可见发热恶风等证。舌尖红、苔薄黄而干、脉细数皆为燥邪化热所致。

本证的治法为清肺润燥止咳。方用桑杏汤（见风热袭肺型感冒一节）。方中桑叶轻宣燥热，杏仁润肺止咳；沙参、桑皮、栀子生津润燥清热；辅以豆豉疏风宣肺，浙贝母清肺化痰止咳。方中可酌加瓜蒌、麦冬、苇茎等清润之品。

若咳嗽少痰或无痰，咽干鼻燥，兼见明显的恶寒发热，头痛无汗，舌苔薄白而干者，是为燥热与风寒合并为病，临床上将之称为“凉燥伤肺”。其治疗可在上方基础上加荆芥、防风、紫菀、款冬花以散寒宣肺与润燥化痰并进。

无论是风寒咳嗽、风热咳嗽，还是燥邪咳嗽，均属外感咳嗽的范畴。这些证型的咳嗽，如日久不愈，或愈而复发，喉痒咳嗽，咳痰不爽，咳甚则面红、呕吐，而表证不明显者，可用止嗽散（见风寒束肺型顿咳一节）治疗。方中紫菀、百部辛苦微温，二者均可疏利肺气，化痰止咳；百部温润，能润肺止咳；橘红、桔梗、甘草能宣肺利咽，顺气化痰；荆芥疏风祛邪。此方温凉并用，对余邪未清，肺气失于宣降，兼有痰浊者，用之最宜。

（二）失音

失音即声音不扬，嘶哑甚至不能发出声音的一种疾病。

《内经》称本病为“喑(yīn)。”明·楼英所撰的《医学纲目》则称本病为“喉喑”，以区别由于中风而引起的舌强不利、语言蹇涩的“舌喑”之证。本病主要为咽喉和声道的病变，但由于肺主气，声由肺气而发，肺系于喉，肺脉通会厌，所以本病与肺的关系甚为密切。此外，中医认为肾藏精，精足则能化气，精气充足则上承会厌鼓动声道而发出声音，所以失音一病与肾也有一定联系。

本病虽以声音嘶哑为特征，但临床常根据发病的急缓而分为“暴喑”、“久喑”。燥邪伤肺引起的失音属暴喑，此种失音乃因燥邪伤肺，津液被灼，声音燥涩以致发音不利。其表现为音哑、喉燥、咽痛，口干或兼咳呛气逆，舌红、苔黄、脉细数。上述症状的产生是由于肺为燥邪所伤，津液被

灼，咽喉及声道失于滋润，故见音哑、喉燥、口干、少津，肺属金，喜润恶燥，气失清肃，故兼咳呛气逆。舌红、脉小数乃津伤肺燥之象。

燥邪犯肺型失音的治疗方法为清肺润燥。常用方剂为桑杏汤（见风热袭肺型感冒一节）加桔梗、甘草、蝉衣、木蝴蝶等止咳利咽、宣肺开音之品，如咳呛气逆较甚者加川贝母、马兜铃。如肺燥而阴液大伤，舌红绛，唇燥裂者，可用清燥救肺汤治疗，方由桑叶、石膏、杏仁、甘草、麦冬、人参、阿胶、黑芝麻、枇杷叶等组成，使津液恢复，则音哑可愈。

燥邪伤肺型失音属外感实证失音。临证时应注意运用宣涩祛邪之法，使肺气得开，声音得复。切忌用收敛肺气之药，以免敛邪闭肺，使病情迁延不愈。

四、痰湿犯肺

痰湿犯肺又称痰浊阻肺或痰湿阻肺。无论外感、内伤，或是其它脏腑的病变均可导致本证发生。如外感风寒湿邪，内合于肺，则肺失宣降功能。由于肺为水的上源，有布敷津液的功能，水湿不得宣泄布敷则聚而为痰。再如脾气虚弱，运化失常，或由于饮食失节，过食肥甘，损伤脾胃，水湿不布而上渍，痰浊停积肺中，也可导致痰湿犯肺一证。这即是古人所说的“脾为生痰之源”，“肺为贮痰之器”的病理变化。本证的临床主证为咳嗽痰多，色白而稀，易于咳出，胸闷、恶逆甚至呕吐，或见气喘痰鸣，舌淡苔白膩，脉滑或濡缓。由于湿邪阻肺，不仅会导致肺失宣降，而且由于肺不布津，聚湿为痰，所以病人既有咳嗽，又有咳痰稀白而量多的

表现，因痰湿尚未化热，故痰色白而稀薄，易于咳出；痰阻肺中，气道不畅故胸闷，气喘甚则痰鸣；由于胃气以降为顺，如痰湿犯胃，胃气不降而上逆，轻则恶心，重则呕吐痰涎；痰湿为阴浊之邪，故可见舌淡苔白腻、脉滑或濡缓之证。痰湿犯肺所引起的主要病证为咳嗽、喘证、痰证等。

（一）咳嗽

痰湿犯肺所引起的咳嗽一证是脏腑功能失调引起的内伤咳嗽之一。常因脾脏健运失常，饮食不能化为津液，反而酿成痰浊，上犯于肺，进而引起肺失宣降，肺气上逆而发生咳嗽。

本证型咳嗽的主证为：咳嗽痰多，痰白而稀，胸脘作闷，或胃纳不佳，神疲乏力，大便溏薄，苔白腻、脉濡滑。以上诸证的产生，是由于脾失健运而聚湿生痰，上渍于肺，故咳嗽痰多，咳痰稀白，痰浊内停，肺失肃降，气机不畅，故胸脘作闷；“神”是以精与气为物质基础的，脾弱气虚，神失所养，故神疲乏力；脾之运化失司，则大便溏薄。舌苔白腻、脉象濡滑均为痰湿犯肺之象。

痰湿犯肺型咳嗽的治法为健脾燥湿，化痰止咳。方用二陈汤（半夏、陈皮、茯苓、甘草）加苍术、厚朴、紫菀、款冬花。方中苍术、茯苓健脾燥湿；陈皮、厚朴理气宽胸；半夏、紫菀、款冬花、甘草除痰止咳。也可使用六君子汤治疗，方由人参、炙甘草、茯苓、白术、陈皮、制半夏等组成。如痰多胸闷，咳逆气急，可加苏子、白芥子、莱菔子；如寒象较明显而见痰多涎沫，可酌加细辛、干姜以增强温肺化痰之功；痰湿化热者，可加黄芩、瓜蒌、贝母等。

痰湿犯肺型咳嗽当与风寒束肺型咳嗽相鉴别。痰浊犯肺

型咳嗽与风寒束肺型咳嗽虽然都有咳痰清稀而色白的特点，但是作为内伤咳嗽之一的痰湿犯肺型咳嗽往往有起病较慢，既往有较长时间的咳嗽病史，并且有脏腑失调的表现，如胸脘作闷，胃纳不佳，神疲乏力，大便时溏，苔白腻、脉滑等证，咳痰量也较多。而风寒束肺型咳嗽起病较急，临床上常有发热恶寒，无汗，鼻塞流涕，骨节酸痛等外感风寒的表证，咳痰量相对较少，但泡沫较多。此外舌苔常见薄白，脉浮或浮紧。掌握以上要点，鉴别不难。

（二）喘证

痰浊阻肺型喘证常因恣食肥甘、生冷，或嗜酒伤中，脾失健运而生痰湿。如痰浊日盛，由中焦上干于肺，肺气壅阻，不得宣畅、肃降，以致气逆于上，发生喘促之证。所以《仁斋直指方·咳嗽方论》指出：“惟夫邪气伏藏，痰涎浮涌，呼不得呼，吸不得吸，于是上气促急。”说明痰浊壅盛，阻塞肺中，是引起喘证的重要原因之一。

本证型喘证以咳嗽痰多，胸中窒闷，恶心，纳呆，口粘无味，舌苔白腻、脉滑为主证。这些证候产生的机理与痰湿犯肺型咳嗽相似。

痰浊壅盛型喘证当与风寒束肺型喘证鉴别。风寒束肺型咳嗽常有外感之表证，如发热恶寒，头痛、身痛，关节疼痛，咳痰清稀量较少，咳之较易，一般无粘稠之痰，舌苔薄白，脉浮紧。而痰湿犯肺型喘证一般无表证，但常有咳痰量多等证。此外还可见胸中窒闷，恶心，纳呆，口粘无味，舌苔白腻、脉滑等痰浊壅盛的相应表现。

本证型喘证应采用祛痰降气平喘之法治疗。以三子养亲汤（苏子、白芥子、莱菔子）合二陈汤（见痰湿犯肺型咳嗽

一节) 加减治疗。方中半夏、陈皮、茯苓化痰; 苏子、白芥子、莱菔子化痰下气平喘, 并可加苍术、厚朴等燥湿理脾行气之品治疗。咳嗽痰多加款冬花、紫菀; 若因痰湿久郁化热, 舌苔黄腻, 脉滑数者, 可加黄芩、栀子。如湿痰化热, 则咳嗽稠粘, 喘而面红, 烦热口干, 便秘溲赤, 苔黄腻, 脉滑数, 属痰热壅实之证。治宜涤痰清火, 用桑白皮汤(桑白皮、地骨皮、甘草、粳米)加贝母、瓜蒌治疗。如痰量较多, 喘而不得卧, 可加葶苈子、大黄, 使痰火得下, 肺气得降, 喘息得平。

(三) 痰证

痰证是指脏腑气血失和, 水湿、津液凝结成痰所产生的各种病证的总称。临床可分为有形与无形两大类: 有形之痰在咳吐时可见到, 无形之痰只能从症状中得知。

痰证与饮证在古代一些书籍中是互通的。如《金匱要略·痰饮咳嗽病》篇说: “膈上病痰, 满喘咳吐, 发则寒热, 背痛腰痛, 目泣自出, 其人振振身瞤剧, 必有伏饮。”可见在那时痰与饮是不加区别的。但两者确实为两类不同病证。如果水湿津液从阳而化则变成痰, 其质稠粘, 由于痰邪无处不到, 所以痰证的见证颇多; 如水湿津液从阴而化则变为饮, 其质清稀, 常见证如狭义痰饮、悬饮、溢饮、支饮等。痰证一般按虚实分为两大类。

正常人水谷精微可以化为津液精血, 以供人体五脏六腑、四肢百骸之用。而痰则是脏腑病理变化的产物。正如《景岳全书·痰饮》篇说的那样: “痰即人之津液, 无非水谷所化, 此痰亦既化之物, 而非不化之属也。但化得其正, 则形体强, 营卫充。而痰涎本皆血气。若化失其正, 则脏腑

病，津液败，而血气即成痰涎。”痰的产生与肺、脾、肾三脏关系密切。因肺主治节，脾主运化，肾主开阖，在正常情况下，水谷精微通过三焦之气化，或化为津，或化为血，以营养全身；无用之物有的变为汗，有的变为气，有的变为尿液排出体外，所以无痰可生。如果人体为外邪所侵或内伤七情、饮食劳倦、生活失宜等内外因素，导致肺、脾、肾三脏失其正常的生化输布功能，三焦气化不利，水谷不能化为精微，渐聚成痰，便可引起各种痰证的症状。

痰浊阻肺型痰证是属实痰的一种。其主证为胸闷，咳嗽喘促，喉中痰鸣，痰多而稀白，苔白腻，脉滑。

这些症状的产生是由于痰浊阻肺，肺失清肃，气机不利，故可见喘促咳嗽，因痰邪在肺，痰气交阻，故喉中痰鸣。因肺中无热，故痰白而稀，苔腻、脉滑则属痰浊内蕴之象。

本证型的痰证应使用祛痰肃肺之法治疗。临床常用方剂为杏苏散（见风寒束肺型咳嗽一节）加减。方中杏仁、桂枝、前胡宣肺止咳；半夏、陈皮、茯苓化痰理气；枳壳宽胸降气。若见表证而有寒热者加苏叶轻宣达表。若无表证而有胸闷者可用苏梗肃肺降气；痰多者加用苏子降气化痰；痰白而稀者为有寒，应加白芥子以增强温化之力；痰黄而稠者为有热，可加黄芩、瓜蒌皮、鱼腥草以清热化痰。

五、痰热郁肺

痰热郁肺也称痰热阻肺，痰热伏肺。多由外感热邪或外感风寒，郁而化热，热灼肺津，炼液成痰，痰与热结，壅阻肺络所致；少数病人也可因痰湿日久，郁而化热而导致痰热

郁肺的。主要症状为发热、咳嗽、喘促、痰鸣、胸膈满闷、咳痰色黄、稠粘量多或痰中带血，胸胁作痛，舌红、苔黄腻、脉滑数。由于外感热邪或风寒郁久化热，使热郁于肺中，影响肺的清肃宣降功能，故见发热、咳嗽、喘促之证；肺中有痰热壅滞故可见胸膈满闷，又可见咳痰色黄、稠粘量多之证；痰热灼伤肺络故可见痰中带血，甚至出现胸胁作痛之证。舌红、苔黄腻、脉滑数是肺中痰热的表现。

临床中应掌握痰热郁肺与痰湿阻肺证的异同点。两者虽皆有咳嗽、喘息，多痰之证。但痰湿阻肺为痰浊阻塞气道，气机不得升降，病由脾肺功能失常引起，其治法也应由脾肺着手；而痰热郁肺可兼见寒热之证，是内外合邪、表里同病的结果，治宜表里双解。常见的内科病证为肺痈、咳嗽、哮喘、胸痛以及儿科的肺炎喘咳等证。

（一）肺痈

痰热壅肺型肺痈的主要表现在肺痈的成痈期。其产生原因是由于初期失治或治疗不当，痰热之邪，郁积在肺，浸淫及血，热伤血脉，热壅血瘀，酿成肺痈。所以《金匱要略》指出：“热之所过，血为之凝滞，蓄结痈脓，吐如米粥。”

成痈期的主要症状为壮热汗出，寒战，胸闷作痛，转侧不利，咳嗽气急，咳吐脓痰，痰味腥臭，口干咽燥，烦躁不安，舌苔黄腻，脉象滑数。

由于痰热壅肺，热毒内盛，正邪相争激烈，故可见壮热寒战；肺热自内向外蒸散，毛孔开泄则汗出；肺气上逆故见咳嗽气急。痰热血瘀，内结成痈故见脓痰腥臭；热毒伤于肺络，气血壅滞而胸闷作痛，转侧不利；热入血分，热伤津液故口干咽燥；痰热扰心，故烦躁不安。舌苔黄腻、脉滑数为

痰热壅肺之象。

本证的治法为清热化痰，解毒散瘀。以《千金》苇茎汤（见风热袭肺型肺病一节）加味治疗。方中苇茎清宣肺热，薏苡仁、冬瓜仁、桃仁化痰行瘀散结。临床时可酌加金银花、连翘、大青叶、鱼腥草之类以增强清热解毒之力，也可加瓜蒌仁、桑白皮、葶苈子以增加化痰祛痰之力。热盛者，尚可加黄连、知母、栀子、石膏等品；便秘者，可加郁金、赤芍、瓜蒌、丹参；咳血者，可加丹皮、白芨或三七粉；如热毒瘀结、脓痰异常腥臭者，可合用犀黄丸治疗、方由牛黄、麝香、没药、乳香组成，以解毒化痰。

（二）胸痛

胸痛是病人自觉胸部疼痛的一种病证。因胸部为诸阳所聚，诸阳皆受气于胸中，故胸部又称清旷之区。胸部是包括了上焦心肺两脏所居的整个部位而言，所以一般胸痛多与心、肺两脏有关。与心有关的胸痛常称“心痛”、“真心痛”或“胸痹，”一般由气滞血瘀或胸阳痹阻而导致，《心病辨治》分册设专篇讨论，此处不再赘言。我们在这里要讨论的是与肺有关的胸痛。

痰热壅肺型胸痛是与肺脏有关的胸痛证型之一。其原因多为肺中蕴热，或外感风热，热灼津液为痰，致使痰热结于胸中，气机闭阻而引起胸部疼痛。

本证型的胸痛常有以下一些主证：胸痛咳喘，咳痰黄稠，或见咳血，或咳痰腥臭，烦闷发热，舌苔黄腻、脉滑数。其产生机理与上述痰热郁肺型肺病的机理相近。其治法为涤痰泻热、宽胸开结。方用小陷汤（黄连、半夏、瓜蒌）合《千金》苇茎汤（见风热袭肺型肺病一节）治疗。方中黄连、苇

茎清热泄肺；瓜蒌、半夏、冬瓜仁宽胸涤痰；薏苡仁、桃仁化浊行瘀。若咳痰带血较多者，可加梔子、黄芩、茅根、藕节等以清热凉血。

（三）咳嗽

痰热壅肺型咳嗽常由痰湿犯肺型咳嗽演变而来。其病理变化为痰湿久郁不化，蕴积化热所致。其见证以咳嗽、咳痰黄稠，舌苔黄腻、脉滑数等证为主。治以清热化痰为主。临床常用《千金》苇茎汤（见风热袭肺型肺病一节）加桑白皮、瓜蒌、黄芩、鱼腥草治疗。

（四）哮喘

前已说过，哮喘在临床上可分为冷哮与热哮两大类。和冷哮一样，热哮的病因也有其主因和诱因。其主因是饮食酸咸肥甘太过，伤及脾胃，内酿痰热，上干于肺，敛聚不散而致痰热胶固。但从临床上看，因寒痰内郁化热，以致转成痰热者较为多见，病后阴伤及素体阳盛之人容易患此病。所以清·林珮琴在《类证治裁》中指出，哮喘“由痰热内郁”而发。其发病诱因与冷哮大致相同，主要为饮食、外邪、劳倦、情志等因素。

热哮的主证为呼吸急促，喉中有哮鸣声，胸高气粗，咳呛阵作，痰稠黄胶粘，咳吐不利，烦闷不安，汗出，口渴喜饮，或兼头痛，发热微恶风热等证，舌质红、苔黄腻、脉滑数。

本证之喘息哮鸣的产生机理为痰气相击所致，与冷哮相同。但由于本证为痰热内蕴，复为风热之邪所束，两邪相搏，肺气壅滞较甚，故胸高气粗，而咳呛阵作，痰稠黄胶粘，咳吐不利，烦闷不舒，汗出等证均为痰热内伏于肺的见证，热

盛伤津则口渴喜饮。舌红苔黄腻、脉滑数也是痰热内盛的表现。如兼有外感风热之邪可见头痛、发热、微恶风等表证。

热哮当与冷哮鉴别。一般说来冷哮咳痰白而粘，或稀白多沫，并可见发热恶寒，口不渴，舌苔白滑，脉浮紧；而热哮喘咳痰黄稠或为脓痰，兼有口渴喜饮，发热恶风，舌苔黄腻、脉滑数等证。

热哮的治法以宣肺清热、化痰降逆为主。方药为越婢加半夏汤，本方由麻黄、石膏、生姜、大枣、甘草、半夏等组成。本方以麻黄、石膏开肺气、清邪热；半夏、生姜化痰降逆；甘草、大枣和中。可酌加黄芩、桑白皮以增加泻肺热之力。如表证已解，发热恶风、头痛等表证不明显而哮未止者，可用定喘汤治疗，本方由白果、麻黄、款冬花、半夏、桑皮、杏仁、苏子、黄芩、甘草组成。方中麻黄宣肺气、定哮喘，兼解表寒；白果敛肺止咳，化痰平喘。两药配伍，一散一收，既可加强止咳嗽平哮喘之功，又不致耗散肺气，所以两药共为主药；杏仁、苏子、半夏、款冬花降气化痰，加强平息哮喘作用，为辅药；黄芩配桑白皮可清泄肺热，以止咳嗽平哮喘，为佐药；甘草调和诸药兼以化痰，为使药。以上各药合用，共奏宣肺降气、化痰平哮及清热解表的功效，使外寒解而内热除，哮喘得平。以上两方均为寒热并用之剂。因热哮大抵多属寒包火证，也即外寒引动热痰所致，或由寒痰郁而化热所致，故不宜单用寒凉之品。

热哮也可外用复方马兜铃涂法敷涂治疗。其组成为马兜铃15克、生甘草30克、银杏30克、糯米75克、麻黄7.5克、栝骨叶150克，共研细末和匀。每次用药末的三分之一，以生理

盐水100毫升调成厚糊状，做成六个药饼，分别涂于百劳、肺俞、膏肓三对穴位之上。

一般来说，哮喘宿根顽固。如病见于儿童及年少之人，随着年龄的增长，肾气逐渐强盛，肺气也渐充旺，此时一方面应加强药物治疗，一方面注意避免各种诱发因素，往往可获痊愈。若见于成年患者，由于哮喘反复发作，久而久之，不但损伤肺气，而且肾气衰弱，造成本虚难复的结果。此时病患不易根除。如发作不已。胸高气粗，张口抬肩，汗出肢冷，面色青紫，极易发生喘脱之变，应予以高度重视。

（五）小儿肺炎喘咳

痰热郁肺型肺炎喘咳的病因也由于外感风热或外感风寒之邪，郁而化热，邪气外束肌表，内犯于肺，肺气被邪气阻遏，不能宣达所致；而且由于肺中津液化为痰液，阻于气道，以致肃降无权而出现发热、咳嗽、气促、鼻煽、喉中痰鸣等肺气上逆、气道闭塞的肺炎喘咳之证。如邪热炽盛，炼烁痰液，痰热壅阻于气道，会导致壮热烦渴，喉鸣痰涌，气促鼻煽诸证。

本证型肺炎喘咳主证为壮热烦躁，气急鼻煽，喉鸣痰涌，声如拉锯。严重者口唇指甲青紫，两胁煽动，胸高肩抬，小便黄赤，大便闭结，舌苔黄厚，脉洪数，此即古称为“马脾风”之证。

本证的发生因感受外邪，闭郁肺经，气机不通，聚液为痰，痰壅气道，故气上喘逆而喉鸣痰涌。如严重时由气闭而致血瘀，血流不畅，面色口唇指甲青紫；两胁为肺之分野，肺气闭塞故两胁煽动不已；胸高肩抬，为气急严重的证候，痰热内结可见溲黄、便闭、舌苔黄厚、脉滑数等证。

痰热型肺炎喘咳的治法为泻肺平喘、涤痰通腑。代表方剂为葶苈大枣泻肺汤（见风热袭肺型肺炎喘咳一节）合保赤散（巴豆霜、朱砂、神曲、胆星）治疗。葶苈大枣泻肺汤有泻肺热、平喘息、逐痰涎的作用，保赤散具有荡涤痰热而通腑气的作用。因实邪壅肺，肺气胀满，而肺又与大肠相表里，用通利大肠之法以疏通肺气壅突，是中医“上病取下”的独特治疗方法。如青紫严重，可加丹参、红花、赤芍、当归以活血化瘀；神昏谵语，涕泪俱无，热入营分者，宜清营解毒，宜肺平喘。临床可合用清营汤治疗，方由犀角、生地、玄参、竹叶心、麦冬、丹参、黄连、银花、连翘等组成。

痰热闭肺型肺炎喘咳证是发病急速而严重的证型。痰涌气急特别明显者，尤须及时处理。

（六）顿咳

痰热郁肺型顿咳常因初咳期治疗无效演变而来。因于风邪与伏痰搏结，郁而化热，煎津熬液，酿为痰浊，阻遏气道，肺失清肃，壅塞不宣以致顿咳不止。

本型顿咳的主证为咳嗽频频发作，咳后有回吼声，反复不愈，入夜尤甚。痰多而粘，呕吐后其咳可暂停，并见心烦面赤，大便干，小便黄，舌苔黄、脉数有力，指纹紫滞等证。

上述症状产生原因系由痰热郁肺，肺失清肃，故咳嗽发作频繁，反复不止；痰热壅盛故痰液粘稠，不易咳出；气机失调，肺气引动胃气上逆故可见呕吐之证；呕吐后肺气稍得宣通故咳可暂停；心烦面赤、大便干、小便黄、脉数有力、指纹紫滞均为痰热内盛之象。

本证型顿咳常用清热化痰、泻肺止咳的方法治疗。方用桑白皮汤加减治疗，方由桑白皮，川贝、黄芩、黄连、杏仁、

葶苈子、冬瓜仁、百部组成。方中桑白皮、黄芩、黄连、百部清泻肺热；川贝、杏仁、葶苈子、冬瓜仁涤痰止咳。如痰热伤阴，咳嗽咽干者，可加天冬、麦冬；呕逆频作而影响进食者，加枇杷叶、竹茹、代赭石；胸胁胀满者，加柴胡、瓜蒌、龙胆草；吐血衄血者，加白茅根、侧柏叶；痰粘不易咳出者加胆星；目胞浮肿者加车前、茯苓；咳而声哑者加木蝴蝶、挂金灯；大便秘结者加枳实、知母。

六、肺 热

肺热之证主要是因为热邪侵袭人体或风寒之邪郁久化热导致肺受热灼，临床上出现以面颊红赤、咳嗽喘促、鼻出热气、鼻翼煽动、或痰涕黄浊、烦渴咽干而痛，甚则胸痛、咳血、大便干结、小便赤涩，舌红、脉数为主的病证。由于热邪壅肺，肺失肃降之功，肺气上逆故见咳嗽、喘促、甚至鼻翼煽动；肺热煎熬津液为痰，故可见痰涕黄浊之证；肺中有热则烦渴、咽干而痛、面颊红赤；肺居胸中，邪热犯肺，肺的气机不得畅通故见胸痛；热伤血络，故见咳血，肺与大肠相表里，热遏肺气不能清肃下降，大肠气机不利，传导失常而便秘；热灼津液则小便短赤；舌红、脉数均为肺热之舌脉表现。

本证须与风热犯肺、痰热郁肺、燥邪伤肺等相鉴别。一般说来风热犯肺皆有发热、恶风等表证，而肺热之证一般无外感之证；痰热郁肺是痰浊与热邪相搏结，临证既有咳痰较多的痰浊之证，又有热邪偏盛的表现；而肺热则以热邪壅肺为主，痰浊的表现不多；至于燥邪伤肺则是在秋令之时，感受燥邪所致，临床上以肺燥伤阴为突出表现，而肺热则可见于

任何季节,且无外感燥邪之卫表证候。只要掌握好以上各点,肺热和上述病证的鉴别并不难。肺热的常见病证为消渴、癃闭、咳血、鼻衄、痿证及儿科咳嗽等证。

(一) 癃闭

癃闭是以排尿困难,甚则小便闭塞不通为主证的疾患。其中以小便不畅,一点一滴排出,排出量较少,病势较缓者为癃;小便闭塞,点滴不通,病势较急者为闭。

本证常兼有少腹胀闷,但尿道无痛感,可突然发作,也可逐渐发展而成。病情严重时可见头晕、心悸、喘促、浮肿、恶心、呕吐、视物模糊、甚至昏迷抽搐等尿毒内攻证状。

癃闭一证当与淋证相鉴别。两病虽都有小便困难之证,但癃闭单指小便困难不通;而淋证是指排尿淋漓涩痛的病证。此外癃闭的每日排尿量减少,甚至无尿;而淋证排出尿量是正常的。

《素问·灵兰秘奥》篇在论述膀胱的生理功能时说:“膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。”在谈到本病的病因病机时,《素问·宣明五气篇》指出:“膀胱不利为癃。”这些论述都说明癃闭的形成是与膀胱气化不利这一因素有关。但膀胱的气化功能又与三焦功能关系密切,而三焦的气化功能的正常,又依赖于分属上、中、下三焦的肺、脾、肾三脏功能正常。因为肺为水之上源,有通调水道、下输膀胱的功能;脾有运化津液精微的作用;肾主水,开窍于前后二阴,主司二便。因此,肺、脾、肾三脏功能失调,都可以导致膀胱气化不利,从而引起癃闭一证。

当热邪壅肺的时候,肺气失于肃降,津液输布失调,水

道通调不利，不能下输膀胱，或因肺热下移膀胱，以致上、下焦均为气热闭阻。这是癃闭常见的病变机理。

肺热壅盛型癃闭的主要表现为小便不畅，或点滴不通，咽干，烦渴欲饮，呼吸急促，或有咳嗽，舌苔薄黄，脉数。

以上所列症状的产生是由于肺热内盛，治节失调，水道通调之功能失常，水液不能输注膀胱，故小便不畅，甚则点滴不通；邪热壅肺，气逆不降，故呼吸急促或咳嗽阵作；苔薄黄、脉数等证是邪热壅肺的表现。

本证型的癃闭证的治疗法为清肺热、利水道。方用清肺饮治疗，方由茯苓、黄芩、桑白皮、麦冬、车前子、梔子、木通等组成。方中黄芩、桑白皮、麦冬既能清泄肺热，又能滋养肺阴；再以车前子、木通、茯苓、梔子等清热通利之品，使小便自通。如兼有心火旺而见心烦、舌尖红者，可加黄连、竹叶等药以清心泻火；肺阴不足，可加沙参、百合之类以滋肺阴；大便不通者加大黄、杏仁以宣肺通便。

治疗癃闭一证，其法重在通利。因为中医素有“腑以通为补”的说法。本病的发生虽与肺、脾、肾三脏有关，但此病变具体部位是在膀胱腑，故治疗时应使用通利之法。此外，根据中医的“上窍闭则下窍塞，清能升而浊得降”的理论，在利尿剂中如加入提升药，往往能提高本病的治疗效果，这就是“欲导其下者，必开其上也”的道理。古代曾有用呕吐开上窍治疗癃闭的办法（称为“提壶揭盖”法），也是这个意思。不过，目前不太使用催吐这种方法治疗癃闭证了。

（二）消渴

消渴一证是以多饮、多尿、多食（即“三多”）而身体

消瘦（即“一少”）或尿有甜味为特征的病证。本病古称颇多，如“消瘴”、“食佚”、“膈消”、“肺消”、“风消”、“消中”等。后代医家根据消渴的三多症状的轻重主次，还常把多饮症状较突出的称为“上消”，多食症状较突出的称为“中消”，多尿症状较突出的称为“下消”。由于本病是以阴虚为本，燥热为标，因此无论上、中、下三消之证均应从养阴着眼，热邪较甚时，可佐以清热之法。

消渴一证的发生虽与饮食不节，情志失调和素体阴虚有关，但其病变脏腑主要在肺、胃、肾三脏。因肺主治节为水之上源，肺受热邪所灼，治节失职，不能通调水道，以致水液直趋下行而经膀胱排出体外，故小便频数；肺不布津，故口渴喜饮。胃为水谷之海，如为热邪所伤，胃肠炽热，故消渴善饥，大便干结。肾主水，又主藏精。热邪伤肾，气化失常，不能主水，故小溲量多；肾失固摄，精微下注，故小便混浊而味甜。可见肺、胃、肾三脏在上、中、下三消发病中至关重要。虽发病时三脏病变各有轻重，但往往又相互影响。如肺热阴虚，津液失于敷布，则胃失濡润，肾失滋源；胃热偏盛，则可灼伤肺津，耗损肾阴；而肾阴不足，阴虚火旺，也可上炎肺胃。最终导致肺燥、胃热、肾虚等变化同时存在；多饮、多食、多尿常可互见。所以《临证指南医案·三消》篇指出：“三消一证，虽有上、中、下之分，其实不越阴亏阳亢，津涸热淫而已。”

肺热导致消渴病的病理是肺脏热盛，灼伤肺阴，肺阴不足，则其敷布功能失常，水谷精微不能布散于周身，而直入膀胱，致肾阴亏虚，津液不但不能上承肺胃，精微反而下注膀胱而发为消渴之证。

肺热偏盛引起的消渴称为“上消”。其症状以烦渴多饮为主要见证，同时可见口舌干燥，尿量频多，舌边尖红、苔薄黄，脉洪数等表现。

上述症状的产生是由于肺热炽盛，耗液伤津，加上肺敷布津液失司，故烦渴多饮，口舌干燥；肺主治节为水之上源，热邪伤肺，水不化津反而直趋于下，故尿频量多，舌边尖红、苔薄黄、脉洪数是内热炽盛之象。

上消的治法为清热润肺、生津止渴。常用方剂为消渴方，方由黄连末、天花粉末、生地汁、藕汁、人乳汁、姜汁、蜂蜜组成。方中重用天花粉以生津清热，佐黄连清热降火；生地黄、藕汁、人乳汁、蜂蜜养阴增液。若脉来无力，烦渴不止，小便频数是肺肾气阴两虚，可用补肺肾之二冬汤治疗，方由天冬、麦冬、天花粉、黄芩、知母、甘草、人参、荷叶等组成。方中人参益气生津；二冬、花粉、黄芩、知母清热止渴。如舌苔黄燥，烦渴引饮，脉洪大，乃肺胃热炽，耗损气阴，此时可用清肃肺胃、生津止渴之白虎加人参汤治疗，方由知母、石膏、甘草、粳米、人参等组成。

如前所述，由于消渴一证的病机是阴津亏耗、燥热偏盛，其中又以阴虚为本，燥热为标，因此治疗上以养阴生津、润燥清热为基本法则。但应结合“三多”症状偏轻偏重及阴虚和燥热的主次，在治疗处方上有所侧重。如口渴多饮者，治宜润肺，兼清胃热；多食善饥为主者，治宜清胃热为主，兼以滋补肾阴。多尿明显者，治宜补肾为主，兼养肺阴。因本病病情属燥热偏盛，故用药禁忌辛燥之品，以免加重耗阴伤津之弊。

治疗消渴一证，除了药物外，还要避免过度精神紧张，

节制性欲，而饮食的调护又是最为重要的。一般说来，饮食不宜过饱，以适量的米类，配以蔬菜、豆类、瘦肉、鸡蛋为宜，禁忌辛辣刺激之品。隋代医家巢元方把气功、运动和饮食治疗结合起来，称为“谷药”，颇有道理。唐代医家孙思邈在《备急千金要方·消渴》篇中也说：“治之愈否，属在病者……其所慎有三，一饮酒，二房室，三咸食及面。”

（三）咳血

肺热咳血常因热邪袭肺或外邪郁久化热，致使热留肺中，邪热灼伤肺之络脉，血溢于外，随咳或随痰而出，发为咳血之证。

肺热咳血的主要表现是咳嗽、咳痰黄稠，痰中带血或纯血鲜红，兼有大便干燥，小便黄赤，舌红、苔薄黄、脉数等证。这些症状的产生是由于热邪稽留在肺中，肺失宣降功能，肺气逆之于上而见咳嗽、咳痰黄稠之证；热伤肺络则迫血妄行，故见咳痰带血或纯血鲜红；由于火盛伤津，加上肺气不降，大肠传导失职故可见便秘一证；小便黄赤、舌红、苔薄黄、脉数等均为肺热之征。

本证的治疗方法为清肺泻火、凉血止血。常用方剂为泻白散（地骨皮、桑白皮、炙甘草、粳米）合十灰散（大蓟、小蓟、荷叶、侧柏叶、茅根、茜草根、山梔、大黄、牡丹皮、棕榈皮）治疗。泻白散中桑白皮清泻肺热，止咳平喘为主药；地骨皮协助桑白皮泻肺中伏火，以复其顺降；炙甘草、粳米养胃和中，并防伤损肺气。十灰散方中的大蓟、小蓟、荷叶、茜草根、侧柏叶、白茅根凉血止血，棕榈皮收涩止血，梔子清泻火邪，大黄导热下行，折其上逆之势；丹皮配大黄凉血祛瘀，使血止而不留瘀。本方炒炭存性用，可以加强收涩止血的作用。

如热盛者可加连翘、双花；口鼻干燥、舌红少津者可加生地、元参。

（四）痿证

痿证是指肢体筋脉弦缓，软弱无力，日久不能随意运动而致肌肉痿缩的一种病证。由于临床之中以下肢痿弱较为多见，故本病有“痿躄”之称，“痿”是指肢体痿弱不用，“躄”是指下肢软弱无力，不能步履之意。《素问·痿论》篇对本病早有详细记载，并且指出本病的主要病因病理为“肺热叶焦”，是由肺热不能输精于五脏，下肢肌肉筋骨失养，而出现肢体痿躄之证。

因痹证后期，肢体关节疼痛，不能运动，肢体长期废用，也有类似痿证之瘦削枯萎的表现。所以痿证须与痹证作鉴别，一般说来，痿证肢体关节不痛，痹证则肢体关节均有疼痛，其肢体瘦削是由于关节疼痛不能运动，日久而成。病因多为风、寒、湿三气夹杂侵入人体，痹阻经络气血而成，因此治法与痿证也异。

肺热津伤所引起痿证常因正气不足，感受温毒热邪，高热不退；或病后余邪未尽，低热缠绵，肺受热灼，津液耗伤，筋脉失于濡养，导致手足痿弱不用。所以《素问·痿论》篇说：“肺热叶焦，则皮毛虚弱急薄著，则生痿躄也。”

肺热型痿证的主要表现为病之初起发热，或热退后突然出现肢体软弱无力，口渴咽干，咳呛，心烦，小便黄少，大便干燥，舌质红、苔黄，脉细数。

这些症状的产生是由于湿热之邪犯肺，肺热津伤，津液不足以敷布全身，筋脉肌骨失养，故肢体痿弱不用；热盛伤津，故咽干口渴；热扰心神，则心烦不安；肺失润降则气逆

而咳；小便黄少、大便干燥、舌质红、苔黄、脉细数等均为阴伤津涸、虚热内炽的表现。

此证型痿证治法为清热润燥、养肺生津。方用清燥救肺汤（见燥热伤肺型失音一节）。方中人参、麦冬养阴生津；石膏、桑叶、杏仁、麻仁清热润燥。若高热、口渴、有汗者可重用石膏、并加知母、银花、连翘等清热祛邪；若咳呛少痰，酌加瓜蒌、桑白皮等清润肃肺之品；若见身热退净，食欲减退，口燥咽干较甚者，证属肺胃阴伤。宜用益胃汤（沙参、麦冬、生地黄、玉竹、冰糖）加薏米、山药、谷芽之类益胃生津，以从阳明论治。

关于痿证的治疗，《素问·痿论》篇有“治痿独取阳明”之说。因为“阳明者，五脏六腑之海，主润宗筋，宗筋主束骨而利机关也”。上面所说的“独取阳明”，系指一般采用补益后天的治疗原则，因为肺之津液来源于脾胃，而且肝肾的精血也有赖于脾胃的生化。若脾胃虚弱，受纳运化功能失常，津液精血生化之源不足，肌肉筋脉失养，则肢体痿软，不易恢复，所以不仅胃津不足和脾胃虚寒的痿证要用补脾益气方法治疗，而且其它各证型（包括肺热型）的痿证均应重视调理脾胃这一原则。这就是“治痿独取阳明”的真正涵义。

（五）小儿咳嗽

肺热型的小儿咳嗽不属外感咳嗽范畴，而为内伤咳嗽的一种。其产生原因初虽为外感风热或风寒化热，但若表邪已解，热留不去，肺气不得肃降反而上逆，则可引起肺热型小儿咳嗽。

本证型小儿咳嗽主证为咳嗽，伴有痰稠难咳，咽喉干燥，发热口渴，面赤唇红，甚至鼻衄，小便短赤，大便干燥，

舌红少津、苔黄、脉滑数等症状。

因热壅于肺，肺气不降，故发热且咳嗽阵作；热伤肺津，故粘稠难咳、咽喉干燥，口渴、面赤唇红；肺并窍于鼻，热伤鼻之血络故可见鼻衄；小便黄赤、大便干燥均为有热之象。舌红少津、苔黄、脉滑数为肺热之表现。

本证型小儿咳嗽之治法以清热泻肺、止咳化痰为主。代表方剂为清宁散加减，本方由桑白皮、甜葶苈、赤茯苓、车前子、黄芩、瓜蒌、甘草组成。方中桑皮、葶苈、黄芩、瓜蒌、清热化痰止咳；赤苓、车前利湿清热，如无痰浊壅盛之象上两药可去掉。若痰多者可加竹沥、胆南星、天竺黄，咳引胸胁胀痛者加枳壳、川楝子。

（六）小儿肺癆

小儿肺癆是小儿时期一种常见的慢性传染病，其临床特点也和成年人一样，以咳嗽、咳血、潮热、盗汗为其特征。中医古代医书也有称其为“疳癆”、“童子癆”的。由于小儿形体稚嫩，藩离疏薄，故患肺癆者较成人多，病情也重。

本病发病原因，虽然与成人肺癆患者一样，与素体阴虚、感染癆虫有关（详见肺阴虚型肺癆一节），但由于小儿年龄幼小，加上肺脏娇嫩，气血未充，邪盛正虚时则更易化火，从而导致肺火炽盛、肺失清肃、肺气上逆的证候。

肺火炽盛型的小儿肺癆以高热，咳嗽汗多，呼吸急促，颧赤，烦躁不安，大便秘结，小便短赤，舌苔黄厚，舌质红，脉数有力为特点。这些证候的产生是由于小儿气血不足，肺脏娇嫩，感染癆虫后，易从火化，所以可见高热、颧赤之证；肺失宣降，故可见咳嗽、呼吸急促之证；肺热蒸腾，腠理开泄则多汗；热扰心神故见烦躁不安；肺与大肠相表里，

肺热伤津则大便燥结；小便短赤、舌红、苔黄、脉数有力均为肺热内炽的表现。

肺热炽盛型小儿肺癆应以清肺泻火之法治疗。方用清骨散（银柴胡、胡黄连、地骨皮、秦艽、知母、青蒿）加沙参、白芨、黄芩治疗。方中银柴胡清肺热为主药；知母、胡黄连、地骨皮善消骨蒸、汗多之证，也能清肺热；青蒿、秦艽使肺热透之于外。也可加鳖甲，以滋阴退热、引药入里。沙参滋阴清热；黄芩清肺热；白芨可止癆嗽吐血之证。如患儿口渴烦躁者，加鲜生地、石膏；痰壅胸满者，加瓜蒌、葶苈；面色苍白、口唇紫暗者，加郁金、丹参等。

七、饮 停 胸 肺

“饮”即饮证。是指水液在体内运化输布失常，停积于人体的某些部位的一类病证。《内经》早有“积饮”和“水饮”等病名的记载，对饮证的发病机理也作了较详细的论述。张仲景在《金匱要略》中将饮证称之为“痰饮”。而痰饮的含义又有广义与狭义之分。广义的痰饮是诸饮的总称，狭义之痰饮是饮证中的一种。由于饮停人体中的部位不同，因之临床上将广义痰饮证分为痰饮、悬饮、溢饮、支饮四种。

水肿、痰证、饮证都是水液停积而引起的病证，三者应予鉴别。从外形上看，稠浊者为痰，清稀者为饮，更清者为水。关于饮证与痰证的鉴别要点，张景岳在《景岳全书·痰饮》篇中就指出：“痰之与饮，虽日同类，而实有不同也……饮清彻而痰稠浊，饮惟停积肠胃，而痰则无处不到。”这说明痰与饮虽属同类，但形态和停留部位是不同的。另外，由于

人体阴阳有偏盛偏衰的不同，所以从阳化则成痰，而从阴化则为饮。至于饮证与水肿的区别，两者虽同属津液病变，发病机理也有相同之处。但两者证候表现差异较大。饮证为停积在人体的局部的疾患，水肿则为水液泛滥于全身的疾患，因之临床鉴别不难。

水液的输化与排泄在正常情况下是依靠脾、肺、肾三脏气化功能的正常来完成的。《素问·经脉别论》篇指出：“饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行。”可见体内水液的运化包括了脾的转输上行，肺的通调下降，肾的蒸化开阖等三个不可分割的重要环节。除此之外，由于三焦乃水液运行的通道，如三焦的气化功能失常也可导致饮证发生。

饮证的形成有内外两方面的原因。外因寒湿浸渍或水饮所伤，致使脾的运化水湿功能失常；内因阳气虚弱，水液运化无力所致。至于其具体病因病机，一是湿邪偏盛，或经常冒雨、涉水、坐卧湿地，久而久之，水湿浸渍肌肉，由表及里，阻遏脾胃之气化功能，于是水津失运，蓄积而成为饮。致病的第二个原因为暴饮过量之水，或夏暑劳倦及饮酒之后，恣饮冷水及进食生冷之物，因热伤冷，中阳暴遏，脾不能运，停留为饮。第二个原因是阳气虚弱。由于人体的水液属阴，全赖阳气的转输蒸化。久病体虚或年高气弱之人，肺肾之阳不足，水液难于输化，一旦伤于湿邪，更易于停蓄而形成饮证。饮证就是在上述内外因素的作用之下，导致肺、脾、肾三脏气化功能失调，三焦水道壅闭，不得宣行，蓄而成饮。导致饮停胸肺，饮停胸胁等病变。

由于饮为阴邪，遇寒则凝，得热则行，故治疗饮证的大

法为“以温药和之”。

饮证中有两个与肺有关系的病证，即属实的支饮和悬饮证。

（一）支饮

支饮的主要症状为咳喘胸满，甚则不能平卧，痰如白沫量多，久咳则面目浮肿，舌苔白腻，脉弦紧。本证往往经年不愈，遇寒即发，产生这些症状的原因是由于饮犯胸肺，肺失肃降而上逆，故咳喘胸满，不能平卧，痰多白沫；久咳饮邪随气上泛，故面目浮肿；苔白腻、脉弦紧为寒饮内盛之征。因本证为饮伏于内，往往遇寒诱发，故经久不愈。

支饮的治法为温肺化饮，以小青龙汤（见风寒来肺型哮喘一节）为代表方剂。方中干姜、细辛、半夏温肺化饮为主，合麻黄、桂枝发散风寒，佐五味子以防气之耗散。本方适于外寒引动内饮之证。如若表证已解或素体阳虚者需慎用麻黄，以防其疏散太过，损伤其阳气。此时宜使用苓甘五味姜辛汤（茯苓、甘草、五味子、干姜、细辛），本方专治寒饮内停之证。方中以干姜为主，既温肺散寒化饮，又有温运脾阳化湿的作用；细辛温肺化痰；茯苓健脾渗湿；五味子收敛肺气以止咳，以上诸药共同达到温肺化饮的作用。若喘咳痰涎壅盛，胸中窒闷，应改其标以挫其邪势。可先用葶苈大枣泻肺汤（见风热袭肺型肺炎喘咳一节）泻肺逐饮，待病情缓解后，继用前方。如病久饮郁化热，证见喘满胸闷，脘腹痞坚，面色黧黑、烦渴，苔腻而黄，可用利水清热、益气散结之法。常使用木防己汤（木防己、石膏、桂枝、人参）治疗。

（二）悬饮

悬饮的主要症状为胸胁胀痛，咳唾，转侧和呼吸时则疼

痛加重，脘闷饱满，气短息促，苔白，脉沉弦。由于肺主气，居于胸中，胸胁为气机升降之通路，饮停胸胁，脉络受阻，气机不利，故有胸胁胀痛的症状；当咳唾、转侧或呼吸时皆能牵引胸胁故使疼痛加重；若水饮上迫于肺，肺气下行受阻故气短、息促。苔白、脉沉弦，为水结于里之候。

悬饮的治法为攻逐水饮。方用十枣汤（大戟、芫花、甘遂、大枣）或葶苈大枣泻肺汤（见风热袭肺型肺炎喘咳一节）前方用甘遂、芫花、大戟研末配方，均为峻下逐饮之品，故方中合用大枣煎汤送服，以扶正祛邪。本方剂量宜从小量递增，利下水饮后即减量或停服，本方仅用于饮邪壅实而正气未衰之时。若体质偏弱，不耐峻下，可改为葶苈大枣泻肺汤治疗。

饮证系内外因相合而成，为阳虚阴盛、本虚标实之候，故治疗大法不离温通助阳与去饮逐饮两方面。另外，饮证多由伤饮而来，而脾胃阳虚者更易伤饮，所以治饮方中每多兼顾脾胃，佐以甘温之品，以顾护胃气。

八、肺 气 虚

肺气虚是由于劳倦过度，病后体虚未复，气之生化不足，或因久咳久喘伤气，致肺气亏虚。临床上可见咳喘无力，动则短气，痰液清稀，倦怠懒言，声音低怯，畏寒自汗，形冷，易于感冒，舌淡苔薄白，脉虚弱等证。由于肺气不足，气机失畅而咳喘，见咳声无力，喘息气短，语声低微；动则耗气，所以活动或运动之后气短加重；气虚津液失布，湿聚为痰，痰多清稀；肺气不能宣发卫气于肌表，腠理不固，故自汗怕

冷而易于感冒；肺总摄一身元气，肺气虚则不发声声低怯、懒言，而且五脏六腑、四肢百骸之气也不足，故周身倦怠乏力。舌淡、苔薄白、脉虚弱为气虚不足之舌象与脉象。常见的病证为感冒、喘证、哮证、虚劳、自汗证以及妇科产后自汗证等。

（一）感冒

肺气虚型感冒常见于年老体弱或大病后正气未复之人。由于肺主皮毛，肺气不足之人，卫外不固，外邪易于侵袭人体而患感冒。同时由于肺气虚弱，病人感冒往往反复发作，常缠绵难愈。

肺气虚型感冒除恶寒发热、头痛鼻塞等感冒共有症状外，尚有咳嗽痰白，倦怠无力，气短懒言，舌淡苔白、脉浮无力的特点。由于素体气虚，卫外不固，风寒束表，肺气不宣，所以有恶寒发热，头痛鼻塞，咳嗽痰白，脉浮等证。体虚气弱，故倦怠无力，气短懒言。舌淡苔白、脉浮无力都是肺气虚的舌象脉象的表现。

本型感冒应以益气解表的方法治疗。常用方剂为参苏饮，其方由人参、苏叶、葛根、前胡、法半夏、茯苓、橘红、甘草、桔梗、枳壳、木香、姜、枣组成。本方为治疗肺气虚之人外感风寒、内有痰湿之方剂。方中以人参、茯苓、甘草益气扶正以祛邪；苏叶、葛根疏风解表；前胡、桔梗、陈皮、枳壳、半夏宣肺理气、化痰止咳。如果气虚较严重者，也可用补中益气汤（人参、黄芪、白术、甘草、当归、陈皮、升麻、柴胡）以益气升阳，兼解表邪。如果表虚自汗，可用玉屏风散（防风、白术、黄芪）益气祛风、固表止汗，以防感冒复发。

体虚感冒（包括肺气虚型）患者，大都抵抗力薄弱，卫外不固而患此证。治疗时当以扶正驱邪、标本共治为大法。如只用发散之法，易重伤正气，引起变证。

（二）喘证

肺气虚型喘证属虚喘证型之一。它的病因多为久咳伤肺，肺气日弱，气失所主，故上气喘促。所以明·王肯堂在《证治准绳》中说：“肺虚则少气而喘。”

由于喘证在临床上可分为实、热两大类。而实喘与虚喘又应分别采用不同的治疗原则治疗。即实喘治肺，虚喘治肺肾两脏。因此两类喘证，应予鉴别（其鉴别要点见风寒束肺型喘证一节）。

肺气虚型喘证。临床上常有喘促气短，语声无力，咳声低微，自汗畏风，或咽喉不利，口干面红，舌质淡红，脉象软弱等证。因为肺气不足，所以气短而喘，语声无力，咳声低微；肺虚则导致卫外不固，腠理不实，所以可见自汗畏风之证。如兼见气阴两虚之候，就会出现咽喉不利、口干面红、舌质淡红、脉弱之证。

在治疗上应采用益肺定喘之法。生脉散（人参、麦冬、五味子）加黄芪、甘草是有效的方剂。方中用人参、黄芪、甘草益气补肺；麦冬补肺养阴；五味子收敛耗散之气。如咳痰稠粘，应加用沙参、玉竹、贝母之类以滋阴化痰；如肺虚有寒，可兼见吐痰稀薄，时觉形寒，口不渴，可于上方中去麦冬加吴茱萸、干姜、桂枝以温肺益气。如肺脾同病，兼见食少、便溏等证，可合用补中益气汤（见肺气虚型感冒一节）以补益肺脾。

（三）哮证

哮喘证的缓解期常有各种虚证出现，肺气虚是常见证之一。由于哮喘日久，耗伤肺气，肺气不足，卫外不固，腠理不实。故常易遭到外邪侵袭，这些外来因素常成为诱发哮喘发作和导致哮喘持续不缓解的原因。

肺气虚型哮喘病人，平素有怯寒自汗等肺气不足的表现。发作前有喷嚏、鼻塞流涕等先兆证。常常由于气候变化而诱发哮喘。怯寒自汗是由于肺气虚损，卫外不固所引起；由于腠理不密，外邪易侵，所以每因气候变化而诱发哮喘。

本证当用玉屏风散（见肺气虚型感冒一节）治疗，以补肺固卫。本方虽为益气固表止汗之方，但对肺气虚引起的其它病证也有良效。方中黄芪益气固表，白术、甘草补中益气，使病人气充血旺，卫外之力增强；芪术与防风相配，使药力走表，以益气散邪，且能增加其固表之功。如汗多恶风明显者，可加桂枝、芍药以调和营卫。也可用桂枝加黄芪汤（桂枝、黄芪、芍药、甘草、生姜、大枣）治疗，以调和营卫，固表止汗。

在哮喘证的缓解期中，治疗上当扶正以固其本。如在哮喘未发之时，并无明显不适，一般可用平补肺肾两脏之药，如党参、黄芪、胡桃仁、紫河车；如果哮喘病程较长，正气大亏，可加用人参、蛤蚧等。

（四）虚劳

虚劳是虚损劳伤的简称，也称“虚损”。它是由脏腑亏损、元气虚弱而致多种慢性病证的总称。凡是禀赋不足，后天失调，病久失养，积劳内伤，久虚不复，而表现为多种亏损证候者，都属于本病的范畴。古代医家曾把本病冠以“五劳”、“六极”、“七伤”等多种名称。

肺气虚型的虚劳致病原因多与久咳久喘伤气，或劳伤过度以及气之生化不足有关。隋·巢元方在《诸病源候论》中说，“形寒寒饮伤肺”；《素问·宣明五气篇》也认为“久卧伤气”，这些论述对我们理解肺气虚损的发生原因有一定参考价值。

肺气虚型的虚劳的特点是短气自汗，时寒时热，声音低怯，或兼咳嗽，平时易于感冒，面白、舌淡、脉弱。因为肺主气，肺与皮毛相表里，所以肺气不足时，则皮毛不固，此时，临床上不仅有气短、声音低怯等症状，而且有自汗的表现；由于腠理不密，故易感外邪，导致肺气不降，所以还可见寒热、咳嗽等证。气虚则不帅血，致使血不荣于面，不充于脉，故面色苍白、舌淡而脉弱。

治疗上应用补益肺气的方法，可选用补肺汤治疗，方由人参、黄芪、熟地、五味子、紫菀、桑白皮等组成。方中用人参、黄芪补养肺气，桑白皮、紫菀润肺止咳，由于肺气根于肾，所以用熟地、五味子益肾固元。如果自汗不止者，可合用牡蛎散（煅牡蛎、黄芪、麻黄根、浮小麦）以益气固表敛汗。如气阴两虚，证见潮热自汗出者，可用黄芪鳖甲散治疗，方由黄芪、鳖甲、天冬、地骨皮、秦艽、柴胡、紫菀、半夏、茯苓、知母、生地、白芍、桑白皮、人参、肉桂、桔梗等组成，以益气 and 营而除虚热。肺气虚甚者，可加冬虫夏草、蛤蚧等。

肺气虚型虚劳是气虚证型之一。古人治虚劳着重治肺、脾、肾三脏，这说明肺脏在本病发病和治疗中有重要意义。在辨证治疗上应遵守“损者益之”、“劳者温之”和“形不足者，温之以气，精不足者，补之以味”的基本法则。另外，

气虚（特别是肺气虚）常兼有外感证，因此有时要补气兼以祛邪。由于气虚与血虚常同时出现，因此气血双补又常为治疗虚劳的一项原则。

最后还要注意治疗久病虚劳者常有“虚不受补”的现象。故用药宜平补，不宜峻补，方能收到补虚祛邪的功效。

（五）自汗

肺气虚是引起自汗证的常见原因之一。卫气有固护汗液，不令妄泄的作用，为肺所主。如肺气不足，卫外失固，肌表疏松，腠理开泄而导致自汗不止。

本证以汗出畏风，动则汗出增多的特点。病人平素常有不耐寒热之邪侵袭，极易感冒的表现，并有面色㿔白，苔薄白，脉细弱等证。这些症状的产生是由于病久体虚，伤及肺气，皮毛不固，所以可见汗出畏寒；过劳易伤肺气，气不摄汗，所以汗出加重；脉细弱、苔薄白是肺气不足的表现。

本证的治疗方法是益气固表。方用玉屏风散（见肺气虚型感冒一节），方中黄芪宜生用，有补气固表止汗的作用；白术健脾化湿以实表；少佐防风走表而助黄芪固表之功。汗出过多加麻黄根、糯稻根、煅牡蛎止汗敛阴。

自汗之证虽以肺气虚损，卫表不固为多见，但要注意临床上的自汗证尚有营卫不和、热淫于内等证型，因此临床应鉴别虚实寒热，不能以玉屏风散一个方剂治疗多种证型的自汗证。

（六）产后自汗

产后气血较虚，腠理不密，常有汗出较多的表现，一般可在数日内自行好转乃至痊愈。如果汗出特别多而持续时间又长，则称为“产后自汗”。

本证的产生为平素身体虚弱，又因产时气血耗伤，肺气更加虚弱，以致卫气不固，腠理不实而致，故引起自汗不止之证。

肺气虚型产后自汗的常见症状与内科中自汗症状相似，即汗出较多，不能自止，动则加剧，有时恶风，面色㿔白，气短懒言，语声低微，倦怠乏力，舌淡苔薄白、脉虚弱等。由于生产之时，伤损阴血，气随血耗，所以卫气失固，故自汗恶风，气虚则面色㿔白，气短懒言，语声低怯，倦怠乏力，舌淡苔薄，脉虚弱均为气虚之征。

本证当以补气固表，和营止汗之法治疗。方用玉屏风散。方剂组成及方义见自汗一节。

九、肺 阴 虚

本证主要由于外感燥邪，或癆虫袭肺日久，或久咳伤肺，气血亏损，以致引起肺阴不足，阴虚火旺，虚热内生的病理变化。其主要见证是咳嗽气逆，干咳无痰或痰少质稠粘，咳吐困难。咳嗽痰中带血，或为血丝，或见血块，潮热盗汗，五心烦热、颧红失眠，口干咽燥，或发音嘶哑，舌红少苔，脉细数。由于肺的阴津不足，失其清润肃降之机，故咳嗽气逆，干咳无痰或痰少质稠，津亏不能上承故口干咽燥、声音嘶哑；阴虚失养，虚热内蒸故潮热盗汗、五心烦热、颧红失眠；热伤肺络故咳血，舌红少苔脉细数为阴虚内热之象。常见病证为感冒、咳嗽、肺癆、肺痿、虚劳、咳血。儿科常见病证为小儿肺癆、白喉、顿咳等。

（一）感冒

肺阴虚型感冒常见于素体阴虚或大病后阴津耗损未复，抵抗力较弱之人。由于肺阴虚损，阴血不足，汗的来源减少，因此感冒后不能作汗达邪，故缠绵难愈。

本证型的感冒除头痛、身热、微恶风寒之外，尚见无汗，头晕，心烦、口渴咽干，手足心热，干咳少痰，舌红，脉细数等证。由于阴虚津少，不能化为汗液，所以常见无汗之证；肺阴不足，津液亏少，所以干咳少痰，阴虚则阴血不足，脑失所养，因此可见头晕；阴虚生内热故见心烦，手足心热，口渴咽干；因复感外邪，故可见寒热头痛。舌红、脉细数，为阴虚内热之象。

本证型感冒的治疗方法为滋阴解表。临床用加减葳蕤汤化裁治疗，本方由玉竹、葱白、豆豉、桔梗、薄荷、白薇、甘草、大枣组成。方中玉竹（即葳蕤）滋阴生津，以助汗源为主药；葱白、豆豉、薄荷解表散邪；桔梗宣肺止咳祛痰；白薇清热和阴，且能透表；甘草、大枣甘润和中，可助玉竹以增液。如表证较重，酌加荆芥、薄荷以祛风解表；咳嗽、咽干、咳嗽不爽可加半蒴子，瓜蒌皮以利咽化痰；心烦口渴较重者加竹叶、天花粉以清热除烦、生津止渴。

（二）咳嗽

肺阴虚咳嗽属脏腑功能失调的内伤咳嗽范畴。其病因病机为肺阴亏耗失于清润，气逆于上而致咳嗽不止。

本证型咳嗽具有起病缓慢，干咳少痰，或痰中带血、或咳血的特点，兼有口燥咽干，两颧红赤，手足心热，午后潮热，失眠盗汗，形体消瘦，神疲乏力，舌质红少苔，脉细数等证。之所以产生这些症状是与肺阴不足关系密切。因肺阴亏虚，肺失滋养而生燥热，肺失肃降而上逆，所以干咳少痰，

口燥咽干；阴虚血少，肌肉失养，则形体消瘦；咳伤肺络，所以痰中带血或咳血；阴虚火旺，所以午后潮热，颧红，手足心热，心烦失眠；阴虚日久，耗气伤血，故神疲乏力；舌质红少苔、脉细数均为阴虚有热的表现。

肺阴虚咳嗽的治法是养阴清肺，化痰止咳。代表方剂是沙参麦冬汤，本方由沙参、麦冬，玉竹、桑叶、甘草、天花粉、白扁豆组成。方中沙参、玉竹、天花粉、桑叶养阴生津，润肺止咳；扁豆、甘草健脾和中。方中可加入贝母、杏仁等化痰止咳药。如有咳血，可选加侧柏叶、仙鹤草、藕节、白芨、阿胶、参三七等止血药。如午后潮热、颧红，可选用银柴胡、地骨皮、黄芩等。

无论是肺气虚型咳嗽，还是肺阴虚型咳嗽，如咳嗽日久不愈，咳而兼喘，治当补肾纳气。用参蛤散（人参、蛤蚧）加熟地、五味子治疗。

肺阴虚咳嗽属于内伤咳嗽之一。在临床上，内伤咳嗽与外感咳嗽，应予以鉴别。外感咳嗽起病较急，病程较短，初期常伴有寒热、头痛等表证，实证居多；治疗方法为疏散外邪，宣通肺气，邪去则正安。一般不宜过早使用苦寒、滋润之品，也不应过早使用收涩、镇咳之药，（如五味子、罂粟壳等）以免碍邪。而内伤咳嗽一般起病缓慢，往往有较长咳嗽病史和脏腑失调的表现，虚证居多。治则以调理脏腑为主。如健脾、清泻肺火、养肺补肾等。无论外感咳嗽还是内伤咳嗽，常可因肺气不利而滋生痰液，故治咳常需加入化痰之品。

小儿肺炎喘咳中肺阴虚型的治疗可参照上述方法治疗。

（三）肺癆

肺癆是具有傳染性的慢性疾病，以身體逐漸消瘦，証見咳嗽、咳血、潮熱、盜汗等為主証。《內經》對本病早有記載，如《素問·玉機真臟論》篇在論述肺癆的主要見証時說，本証常有“大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱，脫肉破腠”的証候。《靈樞·玉版》篇也指出“咳，脫形，身熱，脈小以疾”是肺癆的主証。以上兩段經文說的是患肺癆的人常因骨骼枯槁而軟弱無力。因肌肉失養而瘦削，並可見氣喘胸悶、胸痛牽引肩項、發熱之証，甚至全身肌肉（包括平時隆起的肌肉）也極度消瘦（即“脫肉破腠”），脈常呈細數之象。《難經》中的“虛損”和《金匱要略》中的“虛勞”包括了肺癆的一些臨床表現，供我們在臨床中參照辨証。

本病的別名頗多。如漢·華佗所著《中藏經》稱之為“傳屍”；晉·葛洪的《肘后备急方》稱之為“屍注”、“鬼注”；唐·王焘的《外台秘要》稱之為“骨蒸”；宋·陳言在《三因極一病証方論》則以“癆瘵”定名。

本病的致病原因分為外因和內因兩種。外因是癆蟲感染，內因是氣血虛弱，陰精耗損，兩者相互影響而致肺癆。外因中的癆蟲又稱“瘵蟲”。癆蟲是引起肺癆的重要因素。

《三因極一病証方·勞瘵諸証》篇中說：“諸証雖曰不同，其根多有由。”在病因學上明確指出感染癆蟲是形成本病的唯一因素。因肺癆是一具有傳染性的病証，所以在《肘后备急方》中明確指出“死后復傳之旁人，乃至冥門”。凡直接接觸肺癆病人，感受病者之氣，常可使癆蟲侵入人體，如內因氣血虛弱，或稟賦薄弱，起居不慎，忧思恼怒，酒色劳倦，耗伤气血津液，正气先伤，体虚不复，则常可内外之因相合

而发病。也有大病之后，失于调治，或因外感久嗽不愈，肺气渐弱，外卫不固，最终导致癆虫感染，发为肺癆。

总之本病的形成，往往是内外二因相互作用的结果，而正虚不足之人，最易感染成疾。

本病病变部位虽在肺，但病人则累及脾肾乃至心肝，造成气阴两虚，元气亏损，最后导致阴损及阳，阴阳俱虚。

肺癆一证的临床表现是十分复杂的。一般病情发展缓慢，但也有开始症状即十分明显的。至于病情轻重程度也不尽相同。轻者症状轻微，其主证未必悉具，重者各种症状大多完备。一般患者，其病势的演变规律是初起甚轻，微有咳嗽，倦怠无力，食欲不振，午后发热，偶或痰中挟有少量血丝，随着病情发展，咳嗽加剧，干咳少痰，口干而少饮，潮热颧红，时时咳血，甚则大咳血，盗汗失眠，胸部闷痛，心烦易怒，逐渐消瘦，男子梦遗失精，女子闭经；最后甚至出现大肉枯槁，大肉陷下，发焦毛耸，肌肤甲错，声音嘶哑，便溏，肢体浮肿的危候。本证证候虽复杂，但在辨证中重要的是要抓住肺癆的四大主证——即咳嗽、咳血、潮热、盗汗。再结合其它见证辨证施治。治疗上切不可忘记“一要补虚，二要杀虫”的原则。

前已说过，肺癆的临床分型虽有气阴亏耗、阴虚火旺、阴阳两虚的区别，但因本病的病理基础是阴虚，所以朱丹溪指出，“癆瘵主乎阴虚”，肺阴虚型是肺癆证的重要证型。

肺阴虚损型的肺癆，可见干咳少痰或痰中带血，潮热颧红，咽干口燥，舌质红，苔薄黄少津，脉细数。产生这些症状的原因，主要是由于癆虫感染，肺阴受伤，清肃失职，肺气上逆而致咳，虚火灼津而成痰，所以临证可见干咳痰少的表

现；咳久肺络受伤，故咳血、胸痛；津液不能上输滋润，所以可见咽干口渴。其它症状如潮热颧红、舌红、苔薄黄少津、脉细数，都是阴虚有热的表现。

肺癆总的治疗原则是补虚为主，参以杀虫。正如明·虞抟在《医学正传》中说的那样：“一则杀其虫以绝其根本，一则补其虚以复其真元。”

此证治法为养阴润肺兼以止咳杀虫，用百合固金汤治疗，本方由生地、熟地、麦冬、百合、芍药、当归、贝母、生甘草、玄参、桔梗等组成。方中百合、麦冬润肺生津；玄参、生地、熟地滋阴清热；当归、芍药濡润养血；桔梗、甘草、贝母清肺化痰止咳。可加功劳叶、百部以退虚热杀虫。如肺阴虚甚者，可加沙参、玉竹以养阴；咳血可加白芨、阿胶、花蕊石、仙鹤草；胸痛加郁金、元胡；潮热、颧红加龟版、白薇、青蒿等。如由肺及肾，肾阴也受累及，进而导致阴虚火旺的，可按肺肾阴虚火旺型肺癆治疗。

肺癆的治疗要以补虚为主，参以杀虫；病虽在肺，但在调补脏腑时，则重在肺、脾、肾三脏。这是因为肺癆病的病位在肺，调理肺脏功能，自不待言。但是由于肾为先天之本，肾之精血充足，可以滋养肺阴，补益肺气；脾脏功能健旺，气血来源充足，有利于病体恢复。正如明·汪绮石所著《理虚元鉴》所说那样：“治虚有三本，肺脾肾是也。肺为五脏之天，脾为百骸之母，肾为性命之根，治肺、治肾、治脾，治虚之道毕矣。”此外由于本病是以阴虚为本，所以治疗上不但要补其肺阴，还要兼补肾阴，只有肺肾并补，方能收效显著。但补阴之药，性多滋腻，易碍脾气，影响健运。故在补肺阴或补肺肾之阴时，宜兼顾其脾，以维护生化之

源。同时要忌用过苦过寒和辛燥伤阴之品。还应指出的是杀癆虫之药以黄芩、连翘、百部、夏枯草、泽漆、猫爪草的效果最好，临床可多选用。治疗肺癆还应该重视体疗、食疗等中医的传统疗法。戒酒色、注意起居调理、保持情绪平和也是十分重要的。

小儿肺阴不足型的肺癆除可用百合固金汤外，尚可使用秦艽鳖甲散加减方治疗，本方由秦艽、鳖甲、柴胡、地骨皮、青蒿、知母、黄精、沙参等组成，以清热除蒸。

（四）肺痿

肺痿是指肺叶痿弱不用，临床上出现以咳吐浊唾涎沫为主的病。本证可分为虚热、虚寒两大类。肺阴亏耗是本证发病的关键。

肺阴虚型肺痿的发生原因一是癆嗽日久，久咳伤阴，肺阴消竭；二是肺痈热毒熏灼伤阴，三是消渴日久津液亏伤，四是热病邪热伤津，五是过用汗、吐、下之法，以致重亡津液。上述原因都可造成肺阴大伤，肺失清肃，宣降失司，肺不布津，致使肺阴不足，导致虚热肺痿。所以清·尤在泾在《金匱要略心典·肺痿肺痈咳嗽上气病》中说：“痿者萎也，如草木之枯萎不荣，为津烁而肺焦也。”

由肺阴虚所导致虚热型的肺痿证的表现 为咳吐 浊唾涎沫，其质较稠粘，咳声不扬，气急喘促，口干咽燥，形体消瘦，皮毛干枯，舌红而干，脉虚数。这些症状的产生是由于肺阴不足，虚火内炽，肺失肃降，所以可见气逆喘咳，咳声不扬，热灼津液，所以咳吐浊唾涎沫质稠；津液不足，不能上布，故口干咽燥；阴津枯竭，内不能洒陈脏腑，外不能充身泽毛，所以形体消瘦，皮毛干枯。舌红而干、脉虚数乃阴枯

热灼之表现。

本证型肺痿当用滋阴清肺润燥法治疗。方用麦门冬汤，本方由麦冬、人参、半夏、甘草、粳米、大枣等组成。方中麦冬滋阴生津兼清虚热；人参、甘草、粳米甘缓补脾胃之气阴，则津液能上归于肺；半夏下逆气，止咳化痰。如阴虚燥热较甚，可用清燥救肺汤（见燥热伤肺型失音一节）以清虚热，润肺燥，津伤较重者，可加沙参、玉竹滋养肺津；潮热者，可加银柴胡、地骨皮等。虚热肺痿可常服琼玉膏（生地黄汁、茯苓、人参、白蜜）以资调理。

肺痿是内伤疾病，虚热肺痿当润肺生津、清金降火；虚寒肺痿当温肺益气。但临床仍以虚热为多见。虚热肺痿，久延伤气，可转为虚寒肺痿。另外本证虽以咳吐痰涎为主证，但由于本病的发病关键是肺中津液亏乏，故切勿使用峻剂驱痰之品，同时治疗上也应慎用燥热之药。

肺痿一证当与肺痈之证相鉴别。二者同属肺中疾患，且多因肺中有热，症状有类似之处。但肺痿病机属虚，主要为上焦燥热灼伤津液，或肺中虚冷，气不化津而致肺叶枯萎，总属阴气亏损之疾。临床上以咳吐浊唾涎沫为主证，治疗以补为主。虚热者，以生津清热为主；若属虚寒者，则宜温肺益气为主。而肺痈病机属实，为风热毒邪与瘀血壅结，蕴酿成脓，临床以咳嗽、胸痛、发热和吐痰腥臭，甚至咳吐脓血为主证。治以清热解毒，化瘀排脓为主。除此之外，还须掌握肺痈与肺痿之间尚有先后转化的因果关系。如肺痈实证因误治或失治，或溃脓后正气渐虚，余邪不清，热毒结于上焦而熏灼肺阴，则可以转为肺痿虚证。

（五）虚劳

肺阴虚型虚劳的病因也为外感燥热之邪伤阴，或痨虫袭肺，久咳伤肺以致肺之阴津不足。

肺阴虚型虚劳的主证是干咳、咽燥，甚至失音，潮热盗汗，面色潮红，舌红少津，无苔或少苔，脉细数。由于肺阴亏损，清肃之职失司，故干咳无痰；肺络损伤则咳血；津伤不能上承故咽燥，甚至引起金碎不鸣而失音的肺阴亏损重症；潮热为阴虚火旺的表现；盗汗为阴虚内热、迫汗外泄所致。面色潮红、舌红少津、无苔或少苔、脉细数等均为阴虚内热的征象。

本证治法为养阴润肺。以百合固金汤（见肺阴虚型肺痿一节）为主要方剂。其方义可参考肺阴虚型肺痿一节。如潮热加地骨皮、银柴胡、鳖甲以滋阴退热，盗汗加牡蛎、浮小麦、麻黄根以敛汗；咳血加阿胶、白芨、仙鹤草以养血止血。也可使用拯阴理劳汤治疗，方由人参、麦冬、五味子、当归、白芍、生地、丹皮、薏苡仁、莲子、橘红、炙甘草等组成。如汗多不寐，可加枣仁；干咳无痰加桑皮、贝母；咳血加阿胶；虚热盛者加地骨皮。

（六）咳血

肺阴虚咳血常在肺阴虚损的基础上导致阴亏火旺，虚火扰动肺之络脉，迫血妄行而致。

由于肺阴不足、阴虚火旺而引起的咳血，临证常见咳嗽少痰，痰中带血，血色鲜红，潮热，盗汗，颧红，口干咽燥，舌质红，脉细数。由于肺阴不足，肺失清降润下之功，所以咳嗽少痰；阴虚火旺则潮热、盗汗、颧红；火盛灼肺、损伤肺络则咳血；津液不足难以上承，所以可见咽干口燥；舌红、脉细数均为阴虚有热的表现。

治疗方法应为滋阴润肺，凉血止血。代表方剂为百合固金汤（见肺阴虚型肺癆一节）。本方中可加黄芩、山梔清热；白芨、藕节、茅根等凉血止血；反复咳血而且量多者可加阿胶、三七养血止血；潮热颧红者加青蒿、地骨皮、白薇等以清虚热；盗汗加糯稻根、牡蛎等以敛汗固涩。

由于肾脉贯通横膈，入肺且循咽喉走行，肺肾两脏相连，而肾主水藏真阴，故临床上治疗肺阴不足的咳血，常以滋肾之药配合治疗。

（七）白喉

肺阴虚型白喉是由热毒之邪耗伤阴津所致。常见于白喉病证的后期。其见证为低热，唇干鼻燥，咽喉微痛，舌红少苔，干燥少津，脉细数，咽部可见白点或白膜。之所以产生咽喉微痛、唇干鼻燥等证是由于肺之阴津不足；阴亏不足则虚火旺盛，故可见低热，舌红少苔，干燥少津，脉细数等证。

本证型白喉应用养阴清热解毒的方法治疗。方用养阴清肺汤。方由生地、玄参、麦冬、薄荷、白芍、丹皮、甘草、川贝母组成。方中生地、玄参养阴润燥，清热解毒；麦冬、白芍助生地、玄参凉血解毒而消肿痛，佐贝母润肺止咳，清热化痰；薄荷宣肺利咽；甘草清火解毒。此外还可使用锡类散或冰硼散吹喉，一日可用三次乃至数次。

（八）顿咳

肺阴虚型的顿咳主要见于顿咳的恢复期。其主要症状以干咳无力，手足心热，夜卧不安，神烦盗汗，颧赤唇干，舌苔薄黄，脉细无力，指纹紫淡为特点。由于肺阴不足，所以干咳无力，口唇干燥；阴虚火旺则手足心热，颧赤唇干；虚火扰神则夜卧不安，神烦；虚火妄动而逼汗外出则盗汗；舌

苔薄黄、脉细无力、指纹紫淡均为阴虚不足，虚火妄动之象。

此型顿咳应以滋阴润肺的方法治疗，用麦门冬汤治疗（见肺阴虚型肺痿一节）。方中麦冬清肺之虚热，滋肺胃之阴；党参、甘草、大枣、粳米补益脾胃之气阴，则津液能上归于肺，使肺得养；佐半夏下气降逆化痰开胃；甘草清热利咽。

十、气阴两虚

气阴两虚是指在某些慢性、消耗性疾病过程中或热性病后出现肺的阴津不足和阳气损伤并见的现象。较轻者称为“气阴不足”，较重的称为“气阴两伤”或“气阴两虚”，其主要见证为气虚的神疲形倦，少气懒言，自汗和阴虚的口干咽燥，盗汗，潮热，口渴，舌红无苔，脉虚数等。在肺脏病中，气阴两虚证常见于肺痿和痰证两病中。

（一）肺痿

气阴两虚型肺痿的主要见证是咳嗽、咳血，潮热颧红，自汗，盗汗和面白神疲，气短声怯，倦怠无力，食欲不振，便溏等证，舌质光红，苔薄或光剥，脉细数或虚数。由于肺阴亏耗、肺失润降故咳嗽；阴虚内热、热伤血络则咳血；虚热内生则见潮热、盗汗、颧红；肺虚耗夺母气以自养，所以可见病及于脾，脾气虚弱的表现，如气短声怯，面白神疲，倦怠无力；健运失常则食欲不振、便溏。而舌质光红、苔薄或光剥、脉细数无力是气阴两虚之象。

治疗方法为益气养阴，方用月华丸治疗，方由天冬、麦

冬、生地、熟地、山药、百部、沙参、川贝母、茯苓、阿胶、三七、獭肝、白菊花、桑叶组成。方中沙参、麦冬、天冬、生地、熟地滋阴润肺；百部、獭肝、川贝润肺止咳，兼能杀灭痨虫；阿胶、三七有止血和营之功；茯苓、山药健脾补气，以资生化之源。气短可加党参、莲予以健脾益气；自汗多者加黄芪以益气固表；食少而便溏者，可加扁豆、薏米、砂仁、陈皮以健脾止泻。也可以使用保真汤（党参、黄芪、茯苓、白术、当归、白芍、生地、麦冬、丹皮、地骨皮、五味子、甘草）治疗。

（二）痰证

痰证中属虚者常有气阴两虚的见证，并在此基础上导致痰邪留恋不去的病理变化。这是因为肺为娇脏，有固护卫表和输布津液的功能，如咳嗽日久则损气耗阴，正气不足，邪气留恋而致病久不愈。

本型痰证常见咳喘时间较长，动则益甚，痰粘难咯或痰稠量多，或自汗畏寒，易于感冒，或潮热颧红，舌淡红，苔薄白、脉细滑无力之证。因肺为娇脏，咳喘日久，损气耗阴，故动则咳喘益甚；阴伤生虚火，虚热灼液为痰，则痰粘难咳；肺气不足，气虚不布，津液凝聚为痰，所以痰稠量多，但因肺气虚少，故痰量虽多，也不易咳出；肺主皮毛而卫外，肺虚则卫外不固，故自汗畏寒，且易于外感；阴伤则潮热颧红。舌淡红、苔薄白、脉细滑无力皆为肺虚有痰之象。

本型治法为补肺健脾兼以化痰，方用补肺阿胶散（阿胶、马兜铃、牛蒡子、炙甘草、杏仁、糯米）合半贝丸（川贝母、法半夏）治疗。方中阿胶润肺滋阴，以滋补肺肾；甘草、糯米健脾补肺；马兜铃清肺止咳化痰；杏仁宣肺润燥；牛蒡子利膈滑

痰；贝母、半夏散结化痰。若肺气阴虚甚者，可加黄芪、沙参、玉竹、百合等气阴双补之品。

十一、肺 中 虚 冷

（一）肺痿

前已谈过，肺痿发生的主要原因虽与燥热伤肺，灼伤津液有关，但虚热肺痿日久，由阴虚损及阳气；或大病、久病之后，耗气伤阳，阳虚生寒，导致肺中虚冷，气不化津，津液不布，变成痰涎，储于肺中，经口吐出；由于肺气虚冷，不能温摄津液，而致肺炎濡养，痿弱不用，发生虚寒肺痿。正如《金匱要略·肺痿肺癰咳嗽止气病》篇所说：“肺痿，吐涎沫而不咳者，其人不渴，必遗尿，小便数，所以然者，以上虚不能制下故也，此为肺中冷。”

其临床见证为口吐涎沫，其质清稀量多，口不渴，头眩短气，形寒，神疲乏力，饮食减少，小便数或遗尿，舌质淡，脉虚弱。由于肺气虚寒，气不化津，因此口吐涎沫而口不渴；清阳不升则头眩；肺气不足则气短；阳不卫外则形寒；肺虚及脾，故神疲而食少；上虚不能制下，膀胱失约，故小便数或遗尿。舌质淡、脉虚弱皆属气虚有寒之证。

肺中虚冷型肺痿的治法应取温肺益气的方法。方用甘草干姜汤（甘草、干姜）加味治疗。方以甘草为主药，用药倍于干姜。甘能入脾，益肺，取其甘守津回之意；干姜温肺脾，使气能化津，水谷归于正化，则吐沫自止。方中可加白术、人参、大枣、茯苓之类，则疗效更佳。

十二、肝火犯肺

肝主疏泄，调畅气机，其性开发；肺主气、司呼吸，其性肃降。肝与肺一升一降，相互协调，则人体气机升降功能得以保持正常，通达无阻。如肝气郁结，久郁化火，或邪热蕴结肝经，气火亢逆上行，上犯于肺，致使肺失清宣肃降之功，从而形成肝火犯肺之病变。

肝火犯肺的主要表现为胸胁灼痛，急躁易怒，头晕目赤，烦渴口苔，咳嗽阵作，甚则咳血，舌红、苔薄黄、脉弦数。以上症状的产生是由于肝之经脉布胸胁，如肝经火郁则胸胁灼痛；肝主疏泄，有调畅情志的作用，当肝经火旺时，因火属阳，其性躁动，故可见急躁易怒的表现；火性炎上，致使清窍不利故可见头晕目赤，烦热口苦之证；由于肝火上犯，木火刑金则肺气不降而上逆，故可见咳嗽阵作；火甚则灼伤肺络而咳血。舌红苔薄黄、脉弦数者乃肝火内盛的表现，常见肝火犯肺的病证为咳嗽、咳血、鼻衄等证。

（一）咳嗽

肝火犯肺型咳嗽属脏腑功能失调的内伤咳嗽范畴。本证常由情志不舒，肝失条达，肝气郁结，日久化火所致。由于肝经布胸胁，上注于肺，故肝经火旺时，可循经上犯肺金，熏灼肺脏，火炼津液为痰，以致火热及痰浊相结，阻滞肺气肃降而上逆，所以会引起咳嗽。这即通常所说的“木火刑金”之候。

肝火犯肺型咳嗽的主要证候为咳嗽气逆，牵引胸胁作痛，心烦易怒，咽干口燥，头晕目眩，面红目赤，苔薄黄少津，

脉弦数。由于情志内伤，肝郁化火，肝火上逆，熏灼肺脏，肺气不得肃降而致咳嗽气逆；因两胁为肝经循行之路，故咳时两胁作痛；肝在志为怒，肝火亢盛则急躁易怒；火旺灼阴则咽干口燥；肝火上扰清空则眩晕；肝开窍于目，肝火上炎则目赤。舌红、苔薄黄少津、脉弦数均为肝火旺盛，肺热津亏之象。

本证的治疗方法为清泻肝火、润肺化痰。代表方剂为清金化痰汤（黄芩、山梔、桔梗、麦冬、桑白皮、贝母、瓜蒌仁、橘红、茯苓、甘草）合黛蛤散（青黛、海蛤壳）治疗。方中用青黛、山梔泻肝火；黄芩、桑白皮清肺热，火热得清而咳嗽自平；配合海蛤壳、瓜蒌仁、贝母、知母、麦冬清热化痰、生津润肺以增强止咳之力。如咳黄痰不爽者，可加鱼腥草、冬瓜子、胆南星；肺热伤津者，加沙参、麦冬、天花粉；若心烦少寐、口干、舌尖红者可加黄连、竹叶等。

（二）咳血

肝火犯肺而咳血的病因也与情志因素有关。多因肝气郁结，日久化火，循经上注于肺，以致火热之邪灼伤肺之络脉，自溢之于外，沿气道经口吐出。也有平素肝肾阴亏，肝阳亢盛，燥而化为肝火上扰于肺，引起咳血一证的。

肝火犯肺、咳血的主要临床表现为咳嗽阵作，痰中带血，或见纯血鲜红，咳时两胁作痛，烦躁易怒，大便干燥，小便短赤，舌质红，苔薄黄、脉弦数。上面这些症状的产生是由于肝火上升迫肺，灼伤血络，故咳嗽阵作，痰中带血，甚至纯血鲜红；肝之经脉布于两胁，肝火偏盛，脉络壅滞，故咳时两胁疼痛；肝旺则烦躁易怒；大便干结，小便黄赤、舌质红、苔薄黄、脉弦数均为肝火偏亢的表现。

此证的治法为清肝泻肺、和络止血。代表方剂为泻白散（桑白皮、地骨皮、甘草、粳米）合黛蛤散（见肝火犯肺型咳嗽一节）。二方合用有清肝泻肺的作用。方中桑白皮、地骨皮泻肺火；蛤壳清肺化痰；青黛有清肝凉血的作用。可加丹皮、黄芩、山梔以清热止血；并选用鲜生地、旱莲草、茅根、藕节、仙鹤草以凉血止血。如出血量多不止，为肺伤络损的重证。宜清热凉血，方用犀角地黄汤（犀角、生地黄、丹皮、芍药）加三七研末调服，效果较好。

如果两足厥冷，可急用热水洗足，将附子打烂，外贴于两涌泉穴，以引火归元，导血下行，达到制止咳血的目的。

（三）鼻衄

肝火犯肺之鼻衄证的病因与肝火犯肺引起的咳嗽的病因大致相同。但由于肺开窍于鼻，如木火刑金，上循肺窍，鼻之络脉被伤，迫血妄行故产生鼻衄一证。其临床表现除鼻衄外，尚有因肝火上炎而出现眩晕头痛、目赤易怒之证，因肝火旺盛而引起的溲赤、舌红、苔黄及脉弦数等证。

肝火犯肺引起的鼻衄一证应以清肝泻火、凉血止血为治疗方法。方用龙胆泻肝汤治疗，方由龙胆草、泽泻、木通、车前子、当归、柴胡、甘草、生地黄等组成。方中龙胆草清泄肝火；栀子黄芩苦寒清热泻火；生地凉血止血；车前子、泽泻、木通利小便。方中可酌加牛膝导热下行，茅根、仙鹤草、藕节等药以加强止血之力。

除了肝火犯肺证外，临床尚可见因情怀不遂，忧思气结，气结胸中；或郁怒伤肝，肝气逆乘于肺而引起肺的气机不利，升多降少，不得宣肃而发为喘证的。此型喘证为实喘的一种，主要表现为一派肝郁气滞，逆乘于肺的证候，但尚无化

火的症状，这是区别肝火犯肺的关键所在。如平素忧思气结，复因精神刺激，突然呼吸短促，咽中不适，甚则胸痛，苔薄白，脉弦，即为肝郁气结于胸中之证。此时应采用开郁降气平喘之法治疗。方用五磨饮子（乌药、沉香、槟榔、枳实、木香），上述五味中药皆为芳香降气开郁之品。方中槟榔破滞行气；沉香降气平喘；乌药调肝顺气；木香理气疏肝；枳壳理气平喘。如伴有心悸、失眠者，可酌加酸枣仁、远志、夜交藤以宁心安神。

十三、肺脾气虚

肺主气，脾化气。肺司呼吸，能吸入自然界的清气。脾主运化，能将食物化生为水谷精气，上输于肺，自然界的清气与水谷精气结合在一起而化为宗气。肺气的充盛，有赖于后天水谷精气不断地补充给养。因此，肺气的盛衰在很大程度上决定于脾气的强弱。所以中医有“脾为生气之源，肺为主气之枢”的说法。也就是说脾有助肺益气的作用。再者，肺与脾在人体水液代谢方面也有协同作用。因脾主运化水湿，脾主宣发肃降，通调水道，两脏配合，共同参与水液代谢过程。所以当脾不散精时，肺因之而虚损；而肺失宣降时，则脾因之而呆滞。肺脾之气均不足，则水津无以散布，痰湿因之而生。临床上所见的肺脾气虚多因久咳肺虚，气不布津，影响于脾；或饮食不节，痰湿内生，损伤脾气，不能输精于肺所致。肺脾气虚的临床常见证候为短气乏力，咳喘痰多而稀白，食欲不振，腹胀便溏，甚至面浮足肿、舌淡苔白、脉细弱。由于肺气虚不足以息故气短；脾虚不及于四末故乏力；

痰湿贮于肺，气不能肃降故咳喘而痰多清稀；脾气不足，运化失常，故食欲不振，腹胀便溏；脾不运湿，气不行水，水湿泛滥，故面浮足肿。舌淡、苔白、脉细弱均为肺脾气虚之舌象脉象。常见的内科病证为虚劳；几种病证为小儿遗尿、咳嗽、肺炎喘咳、顿咳等。

（一）虚劳

本证的主要表现，除了肺气虚型虚劳的症状外（见肺气虚型虚劳一节）尚应有脾气不足的表现。如饮食减少，食后胃脘不舒，倦怠乏力，大便溏薄，面色萎黄，舌淡苔薄，脉软弱等。脾虚的一派症状的产生是由于脾不健运，胃肠传化失常，故饮食减少，食后胃脘不舒，大便溏薄；脾虚不能化生津液精微，气血来源不足，肢体失养，故倦怠无力；不能上荣于面，所以可见面色萎黄；血少不能充盈于脉，故脉软弱。此外，内于肺脾气虚，卫外之力不足，所以病人容易感受外邪而经常感冒。邪气内侵，正气愈伤，如此反复不已，乃至虚而不复。

本型虚劳应以扶正祛邪之法治疗。方用薯蓣丸，本方由薯蓣、人参、白术、茯苓、甘草、当归、芍药、川芎、干地黄、阿胶、麦冬、杏仁、桔梗、豆黄卷、防风、柴胡、桂枝、神曲、干姜、白薇、大枣组成。方中以薯蓣、四君、四物、阿胶等并补气血为主；佐以防风、豆黄卷、桂枝、柴胡之属以祛其邪，这样可使邪不致留恋而正气得以恢复。

（二）小儿遗尿

小儿遗尿是指小儿睡中小便自遗，醒后方觉的一种病证。本病又称“尿床”。一、二岁小儿，由于智力未健，排尿的正常习惯尚未养成，或因精神激动，也能引起暂时遗尿，这

都不是病态。若四周岁以后，尚不能自主排尿，日日夜夜遗尿，形成习惯，应视为疾病。

小儿遗尿发生的病因病理虽与肾和膀胱密切相关，但肺脾气虚也可导致遗尿。因肺主一身之气，有通调水道、下输膀胱的功能；脾主运化、性喜燥恶湿而制水。肺功能正常，方能维持机体水液的正常输布和排泄。倘肺脾气虚，则上虚不能制下，下虚不能上承，致使无权约束水道而遗尿。正如清·尤在泾在《金匱翼》一书中所说的那样：“脾肺气虚，不能约束水道而病不禁者，《金匱》所谓上虚不能制下也。”

本型小儿遗尿的主证为睡中遗尿，兼见面白神疲，四肢乏力，食欲不振，大便稀溏，舌淡脉缓。肺为水之上源，脾属中土。肺气虚，则治节无权，不能约束水液，故遗尿；脾虚则生化无权，气血不足，所以面白神疲，舌淡脉缓；脾失运化，所以大便稀薄，食欲不振；四肢为脾所主，脾气虚弱，不能充养四末，所以四肢无力。

本证应以培补元气、固涩止遗为治法。方用缩泉丸（乌药、益智仁、山药）合补中益气汤（见肺气虚型感冒一节）治疗。补中益气汤培补肺脾之气。缩泉丸中益智仁温补脾肾、固精气、涩小便；乌药助膀胱气化，可治疗小便频数；山药健脾补肾。以上两个方剂共同达到温补培元，益气固小便之目的。如小儿睡不易醒而遗尿者，可加石菖蒲、莲子心以醒神开窍。

对于小儿遗尿之证还要注意适当护理。让小儿自幼养成按时排尿及合理的生活习惯，勿使小儿白天过度疲劳，睡前最好要少喝水及少进流食。这些对于本证的预防有积极作用。

(三) 小儿咳嗽

小儿咳嗽除了与成人有相同证型和表现外，还有小儿自己的特点。由于小儿形气未充，肌肤柔弱，卫外功能较差，在春秋气候多变之时，因小儿体质素虚或外感咳嗽日久不愈，耗伤正气，则更易反复感受外邪，致使咳嗽累作，引起肺气不足；如因痰而咳者，则常因小儿脾胃虚弱，运化失司，水谷不能化为精微，反而酿成痰浊上贮于肺，壅阻气道，肺气不得宣畅，加重了小儿咳嗽。此即“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”之意。所以肺脾气虚在小儿咳嗽中占重要地位。

本型的主要表现为咳而无力，痰白清稀，面色晄白，气短懒言，语声低微，喜温畏寒，体弱多汗，舌质淡嫩，脉弱无力。由于肺气虚弱，所以咳而无力、气短懒言而语声低微；气虚不能周行于外，故面色晄白，喜温畏寒；卫外功能不足，故常见多汗之证。舌质淡嫩，脉弱无力是肺脾气虚的舌脉表现。

本证应以健脾益气的方法治疗。方用六君子汤（见痰湿犯肺型咳嗽一节）加黄芪、五味子治疗。方中党参甘温益气补中；白术味甘苦健脾燥湿，合党参以益气健脾；茯苓味甘淡平，有渗湿健脾的作用；甘草甘缓和中；陈皮、半夏健脾燥湿；黄芪补益肺脾之气；五味子收敛正气。

(四) 小儿肺炎喘咳

肺脾气虚型肺炎喘咳之证，常见于肺炎喘咳后期。由正气不足，邪气留恋，耗伤肺脾之阳气所致，常见证为多汗，四肢欠温，咳嗽无力，面色晄白，消瘦神疲，纳呆便溏，舌质淡、舌苔白滑、指纹多沉而色淡等。由于肺气虚，肺失清肃，所以咳嗽无力；卫外功能失司，则多汗；由于“气为血

之帅”，气虚不周流于全身，以致影响血的运行，所以可见面色㿔白、四肢欠温之证；脾虚则运化失常，故纳呆，便溏；脾虚气血生化不足，无力充养肌肉精神，所以消瘦神疲。舌质淡、苔白滑、指纹沉而淡皆为肺脾气虚的表现。

肺脾气虚型小儿肺炎喘咳的治法是益气健脾。方用人参五味子汤加味治疗，方由人参、白术、茯苓、五味子、麦冬、甘草、生姜、大枣、银柴胡、桔梗组成。方中党参、白术、茯苓、甘草、大枣补益肺脾之气；五味子、麦冬兼滋肺阴、退虚热；银柴胡清热；桔梗上浮保肺气。如虚汗特别多者，加黄芪；痰多者加陈皮、法半夏；咳嗽较重者加紫菀、款冬花。

（五）顿咳

肺脾气虚型的顿咳是恢复期的一个证型。常因顿咳日久耗伤肺脾元气所致。其表现为形体虚弱，咳声低微，痰少而稀，手足欠温，神疲面白，自汗无力，食少胀满，大便溏薄，小便清，舌淡苔白，脉沉无力，指纹淡等。由于肺气不足，所以咳声低微，痰少而稀；卫外功能不固，毛孔开泄则自汗；手足不温是气不周流的表现；神疲面白是气血运行及气化不足的表现；脾虚则食少胀满，大便溏薄，小便清；舌淡苔白，脉沉而无力，指纹淡都是肺脾气虚之证。

本型的治法和方剂均与小儿肺炎喘咳的肺脾气虚型的治法和方剂相同。

十四、心 肺 气 虚

肺主气，心主血脉；气可帅血，血可载气；心肺又同居上

焦胸中，故两脏关系十分密切。两脏配合，保证气血运行正常，维持机体各组织的新陈代谢。气属阳，血属阴，血的运行要依靠气的推动，气的运行则要依赖血的运载，两者协调配合，敷布全身。由于心与肺，血与气是相互依存的。因此仅有血而无气的推动，则血凝而不行；如只有气而无血，则气无所依附而涣散不收。心与肺两脏不但在生理上相互联系，而且在病理上也是相互影响的。如肺气虚弱，宗气生成不足，则运血无力；心气不足则血行不畅，也会影响肺气宣发与输布津液的功能，所以心肺气虚的病理改变主要表现在呼吸气息的异常与血的循行障碍两个方面。

心肺气虚的病因为劳倦过度或久病咳喘、耗伤心肺之气所致；也有素体阳气不足而导致血行不畅的，严重时甚至出现外寒乘虚而入，阴寒凝滞，络脉痹阻的情况。

心肺气虚的临床表现以心悸，气短，咳喘少气，胸闷发憋，自汗乏力，动则更甚为主要表现，兼有面色晄白或暗滞，甚则口唇青紫，舌质暗淡或见瘀斑，脉细弱等证。常见的病证为胸痛、心悸等。

（一）胸痛

心肺居于胸中，故胸痛多与心肺有关。心肺气虚所引起的胸痛，常与胸阳痹阻有关。本证常见于素体阳气不足之人，因心肺气虚，胸阳不展，气血运行不畅以致外寒乘虚侵袭，阴寒凝滞，痹阻脉络不通，而成胸痛。

本证型的胸痛的主要表现为胸痛彻背，感寒痛甚，胸闷气短，心悸。重则喘息不能平卧，面色苍白，自汗，四肢厥冷，舌苔白，脉沉细。这是因为诸阳受气于胸中而转行于背，心肺阳气不运，气机阻痹，血行不畅，故见胸痛彻背，

感寒则阳气更呈不足故胸痛加重；心肺气虚则气机不利，故见胸闷气短而心悸，甚则喘息不能卧；气虚则周行不利，则面色苍白，四肢厥冷；气虚不能卫外，腠理不实，故见自汗出。舌苔白、脉沉细等均为心肺气虚之候。

本证治法为补养心肺、宣痹通阳散寒。用保元汤（黄芪、人参、甘草、肉桂、生姜）合瓜蒌薤白半夏汤（瓜蒌、薤白、白酒、半夏），再加枳实、丹参、檀香等药治疗。其中黄芪、人参补养肺气；肉桂、甘草补养心气；薤白辛温通心肺之阳气；瓜蒌、半夏、枳实、檀香宣痹散结；丹参活血脉通阳气。若痰湿内盛，伴有咳唾痰涎者，除可继续重用生姜外，尚可加橘皮、茯苓、杏仁以行气化痰。

（二）心悸

心悸是指病人心中动悸不安，甚则不能自主的一种自觉病证。一般多呈阵发性，每因情绪波动或劳累而发。“心悸”是惊悸、怔忡的合称。惊悸与怔忡两证有所不同，惊悸多由外因引起，常因惊恐、恼怒而发，全身情况较好，其证较为浅暂；怔忡每因内因而成，外无所惊，自觉心中惕惕，稍劳即发，全身情况较差，发病呈渐进性，其病也较深重。

心肺气虚所致心悸常因久病体弱，心肺阳气不足而致。由于肺主一身之气而朝百脉，气又为血之帅，由于肺气不足，无以帅血，心脉失去温运而瘀阻，故心悸不安。正如金·成无己在《伤寒明理论·悸》篇说的那样：“其气虚者，由阳气内弱，心下空虚，正气内动而为悸也。”

心肺阳气不足所致心悸的特点是胸闷气短，面色苍白，形寒肢冷，心中空虚，惕惕而动，舌质淡白，脉象虚弱或细

数。由于心肺居于胸中，如胸中阳气不足则不仅有肺气亏虚的胸闷气短证候以及不能温暖腠理肢体而致形寒肢冷的表现，而且由于心阳不足，心失温养，所以还会出现心中空虚、惕惕而动的心悸表现；心阳不足，鼓动无力，故血行不畅，不仅不能上荣于面及舌，也不能很好鼓动血脉，故见面色苍白、舌质淡白、脉象虚弱或细数之证。

本证型心悸应以滋补心肺，安神定悸为治疗方法。用保元汤（见心肺气虚型胸痛一节）加龙骨、牡蛎等治疗。方中黄芪、人参补益肺气；肉桂、甘草温养心气；龙骨、牡蛎安神定悸。

十五、肺肾气虚

肺司呼吸，肾主纳气。肺的呼吸需要肾的纳气作用来协助。肾中精气充盛，吸入之气才能经过肺的肃降而下纳于肾。若肾气不足，摄纳无权，气浮于上就会出现喘促之证。故中医有“肺为气之主，肾为气之根”的说法。

所谓“肺为气之主，肾为气之根”，也即肺主呼吸，但纳气的功能乃为肾所主的意思。所以久病咳喘，不仅伤肺而且会损伤肾气，临床经常出现由于肺肾气虚而致呼吸气息异常证状。因气之根在肾，故本证又称“肾不纳气”证。肺肾气虚证的临床表现为呼多吸少，喘促短气，动则尤甚，声低气怯，或自汗遗尿，肢冷面青，舌淡，甚或冷汗淋漓，肢体浮肿，脉虚浮无根。由于肺肾气虚，气不归元，肾失摄纳，故呼多吸少，喘促短气，动则尤甚；肺虚则宗气衰微，故声低气怯；肺气不足则卫阳不固，故常自汗出；肺为水之上

源，肾司二便，故肺肾气虚之时，则尿随咳出或遗尿失禁；阳气不能温养肢体，则肢冷，面青、舌淡；阳气欲脱则冷汗淋漓；气浮于外，故脉来虚浮无根。若偏于阴虚，则由于津液不足，阴不敛阳，则于喘咳同时，兼见面赤躁扰，口燥咽干，舌红、脉细数等证，常见病证为喘证和咳嗽等。

（一）喘证

肺肾气虚型喘证产生的原因是久咳伤肺，肺气日弱；或病久迁延不愈，由肺及肾，则肺肾俱虚；或由劳欲伤肾，精气两亏，根本不固，皆使气失摄纳，出多入少，逆气上奔而为喘。所以明·赵献可在《医贯·喘》篇中说：“真元损耗，喘出于肾气上奔……乃气不归元也。”本证到了严重阶段，也可累及心阳。这是因为心阳之盛衰与先天之肾气及后天呼吸之气都有密切关系。一旦肺肾俱衰之时，则心阳也弱，不能鼓动血脉，则心动急促，血行瘀滞，面、唇、舌皆发生青紫；同时由于汗为心之液，心阳虚损不能敛汗，导致大汗液大量外泄，从而会加重心阳虚损之证。

本证型喘证之主证除了有肺气虚的表现外（见肺气虚型喘证一节），还有呼吸少、动则喘息更甚，形瘦神疲，气不得续，肢冷面青，舌质淡、脉弱等肾气不足的表现。这些症状的产生是由于喘促日久，肺病及肾，精气亦虚，故形瘦神疲；肾为气之根，下元不固，气失摄纳，故呼多吸少；动则耗气，故喘息更甚且气不得续；阳气不得温养于外，故肢冷面青。舌淡、脉弱为阳气衰弱之征。

本证的治法应以补肾纳气为主。代表方剂为金匱肾气丸（熟地、山药、茯苓、丹皮、泽泻、山萸肉、桂枝、附子）合参蛤散（人参、蛤蚧）。其中六味地黄汤中的药味有补肾

的作用；桂枝、附子温肾阳，使阳能归于阴，肾气得以固藏，则喘可平；人参、蛤蚧有纳气归肾的作用。病重者可加五味子、补骨脂、胡桃肉之类，以助肾阳、收纳肾气。

（二）咳嗽

肺肾气虚不仅可引起喘证，同时也可以导致内伤咳嗽。其产生机理为肺咳日久，清肃功能失常，久病及肾，肾脏亏损，纳气失司，气逆于上而致咳喘。其主证与肺肾气虚型喘证的表现大致相同。只是本证的特点是以咳嗽为主，兼有喘促。治疗方法也为补肾纳气，常用方剂为参蛤散（见肺肾气虚型喘证一节）。

十六、肺 肾 阴 虚

肺肾阴虚多因久咳伤肺，肺虚不能输津滋肾；或劳伤过度，肾阴虚竭，以致阴津不能上承于肺；或虚火灼肺伤肾，形成肺肾阴虚之变。由于肺肾阴津互相滋养，肾阴又为一身阴液之根本，当肺肾阴虚时，则虚热内生，故肺失清肃而气逆，肾失滋濡而火动，这是肺肾阴虚病变的特点。临床表现的主要证候是咳嗽痰少，或痰中带血，口燥咽干，或声音嘶哑，腰膝酸软，心烦少寐，骨蒸潮热，盗汗颧红，男子遗精，女子月经不调以及舌红少苔、脉细数等。由于阴虚津亏不能上承，肺失清润，故干咳少痰，口燥咽干，甚或音哑；虚火上炎，灼伤肺络，故痰中带血或咳血；阴虚生内热，则可见骨蒸潮热、颧红盗汗，火扰神明，故可引起心烦不寐之证；腰为肾之外府，肾阴亏虚则见腰膝酸软；阴精不足，虚火扰动精室，故男子可见遗精；而女子则可见经少或经闭等

证。

(一) 肺癆

肺癆一证，初起虽病变在肺，但因有“其邪展转，乘于五脏”之说，故本病可累及其它脏腑。尤其在气血不足的情况下，对其它脏腑影响更明显，其中尤以脾肾二脏受累最为多见。那么本证是如何累及于肾的呢？这是由于癆虫蚀肺，肺阴不足，肺虚不能输布津液，下荫于肾，肾失资生之源，则病可致肺肾不足。肾阴亏损，则虚火扰动；如虚火上炎于肺，使肺阴愈致不足。如此反复不已，肺肾阴虚，使肺癆长年不愈。

本证型肺癆的见证为骨蒸潮热，夜寐盗汗，五心烦热，失眠多梦，急躁易怒，咳呛少痰，甚或痰黄粘稠，反复咳血，量多色红，胸胁掣痛，男子梦遗以及舌质红绛、脉细数等。由于肺阴亏损，不能下荫于肾，致肾水也渐亏损，阴虚则虚火旺盛，故见骨蒸、潮热、盗汗、五心烦热等证；水亏不能滋养肝木，肝阳偏亢则急躁易怒；虚火扰心则失眠多梦；阴虚不复、肺燥火盛伤络，故见干咳少痰、咳血而且血色鲜红，并常有胸胁掣痛的见证。如痰热内郁，则痰黄而稠；阴亏火旺、相火扰动精室则梦中遗精。舌质红绛、脉细数等都是阴虚火旺的表现。

本证型治法为滋补肺肾之阴以降虚火。用秦艽鳖甲散治，方由地骨皮、柴胡、秦艽、知母、当归、鳖甲、青蒿、乌梅组成。方中鳖甲、知母滋阴清热；当归补血和血；秦艽、柴胡、地骨皮、青蒿清热除蒸，乌梅酸涩敛阴止汗。若盗汗者加浮小麦、五味子、煅龙骨、煅牡蛎以滋阴敛汗；梦遗者可加龟版、山茱萸、芡实、金樱子以滋肾涩精；烦躁失眠者

加梔子、夜交藤、枣仁、珍珠母以清热安神。痰黄稠粘者加蛤粉、瓜蒌仁、桑白皮、马兜铃、黄芩等以清热化痰。出血不止者尚可加服十灰散（见肺热咳血一节）以凉血止血。

（二）经行吐衄

经行吐衄是指妇女月经来潮前一、二天，或正值行经时，或月经过后，出现有规律的吐血或衄血，每伴随月经周期发作，常可导致月经的减少或不行。由于它很象月经倒行逆上，故也称“倒经”或“逆经”。

经行吐衄的发病机理是血热气逆。因气为血之帅，血随气行，气热则血热而妄行，气逆则血逆而溢。肺肾阴虚为常见的致病原因之一。这是由于平素肺肾阴亏而致阳旺，于是内热滋生，虚火无制而上炎迫血妄行；或因素嗜辛香燥烈之品，伤损阴津，冲任蕴热，经行之时，灼伤肺胃之血络，血随火动，而致吐血或衄血。

肺肾阴虚型的经行吐衄的主要表现是，经期或经后吐血、衄血、量少色红。平素可见头晕耳鸣，手足心热，两颧潮红，潮热咳嗽，咽干，口渴，月经多见先期，量少，舌红或绛，苔花剥或无苔，脉细数等表现。由于肺肾阴虚，虚火内扰，损伤肺胃络脉，故血上逆而为吐衄；阴亏血少，故可见月经量少而色红之证；阴虚内热则手足心热、潮热、两颧潮红、月经先期；虚热灼伤肺津则咽干口渴，肺失润降则咳嗽；舌红绛、苔花剥或无苔、脉细数都是阴虚内热的表现。

本证的治疗方法是滋阴润肺、清热凉血。方用顺经汤（当归、熟地、沙参、白芍、黑荆芥、茯苓、丹皮）加牛膝治疗。方中当归、白芍养血调经；沙参润肺；熟地滋肾养肝；丹皮清热凉血；茯苓健脾宁心；黑荆芥引血归经；牛膝

引血下行，使血不致倒行逆上。

治疗经行吐衄证，应以“热者清之”、“逆者平之”的原则，以滋阴清热降逆、引血下行为主，切不可过用苦寒之品，以免伤其阴，导致变证。

十七、大 肠 湿 热

大肠湿热之证常因暑湿邪气侵犯胃肠或因饮食不节，过食肥甘、生冷与不洁食物，以致脾胃受伤，湿热蕴结大肠而发病。临床常以腹痛、下痢脓血、里急后重，或暴注下泄，臭秽异常，肛门灼热，口渴不欲饮，小便短赤，或伴有发热汗出不解，身重肢倦，胸脘痞满，舌红，苔黄腻，脉滑数等证为主要临床表现。由于湿热蕴结大肠，气血郁滞，传导失司故腹痛；因气机阻滞而里急后重；湿热熏灼肠道损伤血络，则下痢脓血；湿热下注大肠，大肠传导粪便之职失守，则出现暴注下泄，臭秽异常之证；因既有湿邪又有热邪为患，所以口虽干渴而不欲饮水，肛门灼热为大肠湿热之表现；小便短赤为湿热偏盛之象；湿热互结，其邪缠绵难去，故汗出而热不解；身倦体重，胸脘痞满是湿邪为患的表现；而舌红、苔黄腻、脉滑数皆为大肠湿热在舌象和脉象上的表现。常见的病证为痢疾、泄泻、霍乱、便血等证。

（一）痢疾

痢疾古称“肠癖”、“滞下”。是以腹痛、里急后重、下痢脓血为特征的一个疾病。早在金元时期，已经认识到本病是具有传染性的温疫病，故本病又称“时疫痢”。所以朱丹溪在《丹溪心法》这本著作里指出：“时疫作痢，一方一

家之内，上下传染相似。”

痢疾的发生与感受外邪及饮食不洁有关。其病变部位在大肠。其主要病机为外邪与疫毒壅滞肠内，气血与之搏结，大肠传导失司，脉络受伤，气血凝滞腐败引起以腹痛、里急后重、便脓血为主证的病证。

痢疾一证虽有疫毒痢、虚寒痢、寒湿痢、休息痢等证型，但仍以湿热痢为常见的主要证型。湿热痢的病因为感受暑湿、疫毒之邪，侵及肠胃，湿热郁蒸，气血阻滞，气血与暑湿、疫毒相搏结化为脓血而致，伤于气分则为白痢，伤于血分则为赤痢，气血俱伤，则为赤白痢，正如《景岳全书·痢疾》篇所说：“痢疾之病，多病于夏秋之交，古法相传，皆谓炎暑大行，相火司令，酷热之毒蓄积为痢。”

湿热痢的主证除了腹痛、里急后重、便脓血外，还有肛门灼热，小便短赤，舌红，苔黄腻等证。这是由于湿热之邪壅滞肠中，气机不畅，传导失司，故见腹痛、里急后重；湿热熏灼肠道，脉络受伤，气血瘀滞，化为脓血，故下痢赤白。湿热下注，故可见肛门灼热、小便短黄之表现。舌红、苔黄腻、脉滑数是湿热偏盛之象。

本证的治法为清热化湿解毒，辅以调气行血导滞。方用芍药汤，本方由黄芩、芍药、甘草、黄连、大黄、槟榔、当归、木香、肉桂组成。方中黄芩、黄连清热化湿解毒；当归、芍药、甘草行血和营、缓急止痛；木香、槟榔行气导滞，这即是“行血则便脓自愈，调气则后重自除”的道理；大黄泻实且消积滞。如挟食滞者可加山楂、神曲以消导积滞。如病属初起而见恶寒、发热、头痛、身楚等表证者，可先用荆防败毒散（荆芥、防风、羌活、独活、柴胡、前胡、

川芎、枳壳、人参、茯苓、桔梗、甘草)治疗,或在治痢方中加葛根、连翘、荆芥等以疏散表邪,使外邪仍从表而出。外表疏通,则内亦畅通,其痢自愈。倘表邪未解而里热已盛,则宜解肌清热,用葛根芩连汤治疗,方由葛根、黄芩、黄连、炙甘草组成。如表证已减,痢犹未尽可加用香连丸(黄连、木香)以调气清热。如热重下痢,赤多白少,或纯赤痢,发热较高,口渴饮冷,舌红、苔黄、脉滑数者,可用白头翁汤(白头翁、秦皮、黄连、黄柏)以清热解毒。此时也可酌加银花、赤芍、枳实、甘草以解毒和营、行气导滞。

治疗痢疾应依其证候虚实寒热来确定其治疗原则。对于新感属实证、热证的,治宜清化湿热、调和气血,忌用收涩之品。若有表证,兼以解表;里实热盛者,辅以泻下;内有食滞者,治以消导积滞。此外,在治疗痢疾时,应始终顾护胃气。所以俗话说:“见痢莫治痢,提防伤胃气。”说明顾护胃气是不可忽视的一环。特别是治疗湿热痢的方药多系苦寒之品,不应长时间大量使用这一类药物,以防伤胃气。

痢疾一证虽然有大便次数增多的表现,但一般说来仍以通因通用的方法治疗,禁用止痢之法;另外还要注意大便下血较多应该重用止血药;脓多者宜重用理气药。

痢疾一证当与泄泻相鉴别。两者皆有大便次数增多的表现,又都好发于夏秋之际,病变部位又均在肠中,在病因上又都有感受外邪、内伤饮食的因素。但在病情、疾病轻重程度、临床表现和治疗上有很大差别。从病情上看,泄泻轻而痢疾重;从病因上看,泄泻的发生多与湿邪偏盛有关,痢疾多当湿热疫毒之邪有关;从病变部位上看,泄泻病变部位在中焦,治宜分利,痢疾病变部位在下焦,治宜清热解毒。从症

状上看，泄泻并无里急后重、下痢脓血的表现，而痢疾则既有下痢脓血，又有里急后重之证。掌握以上各点，我们在临床鉴别泄泻与痢疾这两种不同病证并不困难。

（二）泄泻

泄泻也有因湿热引起的。尽管外邪引起的泄泻证是以湿邪为多见。但湿邪为病，往往不是单一的，往往挟杂其它邪气发病，如湿热或寒湿。而湿热痢就是湿邪挟有热邪或暑邪，致健运失司，水食相杂而下，自大肠排出而引起泄泻。

大肠湿热型泄泻的临床特点为泄泻、腹痛、泻下急迫，或泻而不爽，粪色黄褐而臭，兼有肛门灼热，烦热口渴，小便短黄，舌苔黄腻，脉濡数或滑数等证。由于湿热之邪，或夏令暑湿之邪伤及肠胃，大肠传化失常，而发生泄泻；由于中医早就有“暴注下迫，皆属于热”的记载，如肠中有热，故泻下急迫；湿热互结，则泻而不爽；湿热下注，故肛门灼热，粪便色黄褐而臭；小便短黄、烦热口渴、舌苔黄腻、脉濡数或滑数均为湿热内盛之征。

本证的治法为清化湿热。方药用葛根芩连汤（见湿热型痢疾一节）。方中黄芩、黄连苦寒清热燥湿，苦坚大肠以止泄；葛根解肌清热，升清止泻；甘草甘缓和中调和诸药。以上各药共成解肌清热之剂。方中可加银花助其清热之力，加茯苓、木通、车前子增强利湿之效，使其湿热分清，其痢可止。若湿邪偏重，证见胸腹满闷，口不渴或渴不欲饮，舌苔微黄厚腻、脉濡缓，可加苍术、厚朴、薏苡仁、车前子燥湿宽中；热邪偏重者加连翘、黄柏、马齿苋，腹痛加木香、白芍；挟食者宜加神曲、麦芽、山楂以消食化滞。如在夏季暑盛之时发生泄泻，证见泄泻如水，自汗面垢，烦渴面赤，则

加霍香、香薷、扁豆衣、荷叶等药以消暑化湿。

泄泻也为小儿常见疾病之一。小儿湿热泄泻最易耗伤气阴。重证患者可引起伤阴、伤阳或阴阳俱伤之危重证候，以致引起小儿营养不良、发育迟缓、疳积等慢性疾病。所以对小儿泄泻证应高度重视。小儿湿热泄泻，除可用葛根芩连汤外，尚可调服益元散治疗，方由滑石、甘草、朱砂组成。方中滑石清热渗湿利水；甘草清热和中，使湿热分消，泄泻自止；朱砂有镇心安神之功效。

（三）霍乱

霍乱是以起病急骤，突然发生上吐下泻，并兼有腹痛或不痛为特征的病证。由于病变起于顷刻之间，挥霍变乱，故称之为“霍乱”。本病的病变部位为脾胃肠道。其发病季节多在夏秋季节。患者多有食凉和饮食腐馊之物等原因可查，故目前认为本病病因为感受寒湿、暑湿等秽浊之气及饮食不洁所致。由于脾胃肠道受伤，升降失司，清浊不分，气机逆乱而致吐泻交作，进而津液大量丧失，故本病可在短时间之内出现面容憔悴，目眶下陷，筋脉挛急，手足厥冷之危象。临床常根据出现症状不同而命以不同病名。如腹中绞痛剧烈者称为“绞肠痧”；目陷皮皱，指纹瘪凹者称为“瘪螺痧”；欲吐不得吐，欲泻不得泻者称为“干霍乱”；筋脉拘急，四肢抽搐，甚则阴囊紧缩者，称为“转筋”，以上诸证皆为危候。

湿热型霍乱又名热霍乱。每见于夏秋之际湿热偏盛、暑湿蒸腾之时。若调摄失宜，感受湿热、暑湿、秽浊、疫疠之气，壅遏胃肠，运化失常，气机不利，升降失司，清浊相混，乱于胃肠，而致上吐下泻之霍乱证。

热霍乱的主证为吐泻骤作，呕吐呈喷射状，泻下如米泔汁，臭秽难闻，头痛，发热，口渴，脘闷心烦，小便黄赤，腹中绞痛，甚则转筋拘挛，舌苔黄腻、脉濡数。这些症状的产生是由于感受暑湿、湿热、秽浊之气，郁遏于胃肠之中，以致清浊相混，故见突发吐泻之证，呕吐呈喷射状，泻下如米泔汁，臭秽难闻，腹中绞痛。由于暑热熏蒸，故头痛、发热；吐泻无度，耗伤津液，故口渴心烦；津亏无以濡养肢体故转筋拘挛；湿热内蕴故胸闷尿赤。舌苔黄腻、脉濡数均为湿热蕴伏之征。

热霍乱的治法为清热化湿，辟秽泄浊。方用燃照汤，本方由滑石、豆豉、焦山栀、酒黄芩、省头草、制厚朴、制半夏、白蔻仁等组成。方中用省头草、黄芩、山栀、滑石、豆豉以清暑泄热；半夏、厚朴、白蔻仁从化湿辟浊。转筋多由吐泻之后，津液大量耗伤而筋脉失所养导致。此时可用蚕矢汤治疗，方由蚕砂、木瓜、薏苡仁、豆卷、黄连、制半夏、黄芩、通草、吴茱萸等组成。方中黄连、黄芩、山栀清泄湿热；豆卷、薏苡仁、半夏、通草解表化湿；蚕砂、木瓜、吴茱萸以舒筋活络，黄连、吴茱萸具有辛开苦降的作用。本方中蚕砂甘辛微苦、木瓜酸温均有舒筋活络的作用，吴茱萸有止呕降逆止痛的作用，以上三味中药均为治疗霍乱吐泻转筋要药。由于治疗转筋时必须迅速复其津液，因此必要时需配合西医补液之法。如脘闷呕吐较剧烈，一时难以服用汤药，或汤药仓卒未备，可先服玉枢丹（见风热袭肺型小儿肺炎喘咳一节）以辟秽止呕。待呕吐稍止，再进汤药治疗。如证见手足厥冷，腹痛自汗，口渴，唇面指甲皆青，呕吐酸腐，泻下臭恶，小便黄赤，六脉俱伏者，此为热遏于内，热深厥

深，真热假寒之象。应急予竹叶石膏汤（竹叶、石膏、麦冬、人参、半夏、粳米、炙甘草）。方中应重用石膏以清热生津，此时切勿投温燥之品。

（四）便血

便血为血证之一。凡血从大便而下，在大便以前或以后下血，或单纯下血者，统称为便血。便血有远血、近血、脏毒和肠风之别。远血是指先大便后下血的便血证，其血来源较远。或在小肠、或在胃；近血是指先下血后大便的便血，其血来源较近，或在大肠、广肠（即直肠）或在肛门。便血血色清而鲜者为肠风；血色浊而黯者为脏毒。

大肠湿热型便血一证的病因常因饮食不节，过食酒热之品以致胃肠受伤，湿热蕴结而下移大肠，最终湿热之邪损伤大肠络脉所致。临床上的见证为便血鲜红，或先血后便，大便不畅，口苦，舌苔黄腻、脉濡数。这些症状的产生是由于饮酒嗜辛，湿热蕴积，下移大肠，湿热之邪灼伤血络，故便血鲜红或先血后便。湿热蕴结大肠，气机失和，传导功能失司，故大便不畅。口苦、苔黄腻、脉濡数是湿热内蕴大肠之象。

大肠湿热型便血的治法是清热利湿、和血止血。用赤小豆当归散（赤小豆、当归）加地榆散（地榆、茜草、黄芩、黄连、山栀、茯苓）治疗。方中黄芩、黄连、栀子清热；茯苓、赤小豆利湿解毒；地榆、茜草、当归止血养血。此二方合用具有清热祛湿、和营止血的作用。如血下色黯而浊、舌红、苔黄腻、脉濡数者称为脏毒下血，为湿热伤于血分所致。可用地榆散加苍术、黄柏以清热化湿，兼投脏连丸（猪大肠、黄连、黄芩、赤芍药、当归、炒槐花、阿胶珠、槐

角、地榆炭、荆芥、地黄）。若便血过多，营阴已亏，湿热未清可用驻车丸（黄连、阿胶、当归、干姜）以和营清热，虚实兼顾。

十八、大 肠 寒 湿

大肠寒湿证是由于饮食不节、食凉饮凉，损伤脾胃之阳气，致使运化水湿功能失司，寒湿停留大肠，传导失常，气机不畅而引起。临床以大便泄泻、肠鸣、脐腹作痛、舌质淡苔白滑、脉缓为主证。由于大肠寒湿内盛，阳气不振，运化失调，传导失司，故见腹泄；寒湿蕴于肠内，阻碍气机故腹痛、肠鸣；舌淡苔白滑、脉缓，皆为寒湿内盛之象。大肠寒湿的主要见证是泄泻、霍乱、痢疾等证。

（一）泄泻

泄泻，是指排便次数增多，粪便清稀，甚如水样之证而言。《内经》将本病称为“泄”、“濡泄”、“洞泄”或“注泄”。汉唐时期称之为“下利”；直到宋代以后才称本病为“泄泻”。中医认为本病病变部位在脾胃、大小肠，但由于大肠有传导粪便糟粕、吸收粪便内多余水分的作用，所以大肠功能失常可导致传导加快，粪便与肠内水分一起排出，而使粪便变为清稀，从而引起泄泻一证。古代医家早就认识到湿邪在本病发病中的意义。因此古有“无湿不成泄”之说。如果可以把泄泻病因分成内因外因的话，那么外因与感受湿邪有关，内因则与脾胃肠道虚损有关。因为脾胃肠道虚损，运化失司，可造成内湿偏盛；而湿盛反过来又可影响脾胃肠道的运化功能。故脾胃肠道的虚损与湿盛是互相影响的、

互为因果的。所以治疗中理应注意补益脾胃肠道，又应注意祛除湿邪。本证也多见于小儿。由于小儿体虚脆弱，最易耗伤气阴，因此对小儿泄泻一定要及时救治，否则会变成慢惊风，甚至气脱液竭而亡。

大肠寒湿所导致的泄泻证的原因是坐卧湿地，汗出入水，外感寒湿之邪。由于外来之湿邪最易困扰脾胃肠道，使运化水谷和传运糟粕的功能失常，水湿之邪由胃下注大肠导致泄泻。而寒邪侵犯人体，经皮毛肺卫，由表入里，由脏及腑，造成大肠传导功能失司，清浊不分，引起泄泻。所以寒湿之邪常为本病发病的重要原因。

大肠寒湿型泄泻的主证为泄泻清稀，甚则如水样，腹痛肠鸣，脘闷食少，或兼有恶寒发热、鼻塞头痛、肢体酸痛、舌苔薄白或白腻、脉濡缓。这些症状的产生主要是由于外感寒湿之邪，侵犯肠胃或过食生冷，脾失健运，升降失调，清浊不分，大肠传导失司，不能吸收水分，故大便清稀；严重时粪便与水相混，或粪少水多而出现水样便；寒湿内盛，脾胃气机受阻则腹痛肠鸣，寒湿困于脾胃肠道，影响运化水谷功能，故脘闷食少；恶寒发热、鼻塞头痛、肢体酸痛为外感寒湿之邪的缘故。苔白腻、脉濡缓皆为大肠寒湿舌脉之象。

本证的治法为解表散寒、芳香化浊。常用方剂为藿香正气散，本方由藿香、紫苏、白芷、桔梗、白术、厚朴、半夏曲、大腹皮、茯苓、橘皮、甘草组成。方中藿香辛温散寒，芳香化浊为主药；辅以半夏曲燥湿降气、和胃止呕；白术、茯苓健脾除湿，厚朴、大腹皮理气化湿、消满宽胸、疏利气机；紫苏叶、白芷助藿香解表散寒，兼可芳香化湿；陈皮理气燥湿并能和中；桔梗宣肺利膈。本方既能疏风散寒，又能

化湿除满，调理肠胃运化功能，使湿浊得化，风寒外解，泄泻自止。若寒邪偏重可加荆芥、防风以增强疏风散寒的能力；湿邪较重应使用胃苓汤治疗，方由苍术、厚朴、陈皮、甘草、生姜、大枣、桂枝、白术、泽泻、茯苓、猪苓等组成。方中苍术苦温性燥，除湿以健运胃肠；厚朴行气化湿，消胀除满；陈皮理气化滞，甘草甘缓和中，调和诸药；生姜、大枣调和肠胃；泽泻、茯苓、猪苓淡渗利湿；白术健运肠胃，运化水湿；桂枝一味既可外解寒邪，又有温化膀胱之功，使湿邪从小便而去。

治疗由外感湿邪引起的泄泻（包括湿热泄与寒湿泄）一般不宜过早用补涩之品。补涩之品仅适用于泄泻证的中期或晚期。因为在中、晚期，湿邪将净，中阳不振，大肠滑脱、或是延及下焦之候，当用温补与固涩之法。而泄泻之初起，既使患者阳气不足，寒湿弥漫，也只宜使用温通之药，而绝不能因虚而用补，见泄而妄止。所以包括寒湿泻在内的急性泄泻不可妄投补涩。此外，正确使用分利小便的药物（如猪苓、泽泻、车前子、滑石、通草、薏苡仁之类药物），对于初期泄泻每每奏效；而中、晚期泄泻，则需配合温中化浊之品才能收效。但此时仍需注意两点：第一，对泄泻日久脾肾俱虚者，如疏利过度则会伤正气，而使病体难复；第二，对泻久而津液耗伤者，疏利过度则阴分愈亏，阴液耗竭，阳气无所依附，易导致孤阳上浮之变。

（二）霍乱

寒湿型霍乱之证常因贪凉露宿，寒湿入侵，外邪秽气，郁遏中焦，使肠胃升降清浊和运化功能失常，气机不利，以致寒湿之邪乱于肠胃，则上为呕吐，下为泄泻，发为霍乱之

证。所以《景岳全书·霍乱》篇在谈到本病的病因时说：

“有外受风寒，寒气入脏而病者……有水土气令寒湿伤脾而病者，有误中秽气阴毒而病者。”

本证的主要表现为暴起呕吐下利。初起时泻下尚有稀粪，继则下利清水如米泔水样，不甚臭秽，腹痛或不痛，四肢清冷，胸腹痞闷，舌苔白腻、脉濡弱。上述症状的产生主要是由于寒湿秽浊之气壅滞肠胃，阳气受遏，以致清浊不分，升降失调，故可见上吐下泻之证；寒气偏盛，则下利清稀，状如米泔水样，不甚臭秽；邪正相争，气机逆乱，故腹痛；阳气不能达于四末，故四肢清冷；寒湿蕴于肠胃，故胸腹痞闷。舌苔白腻、脉象濡弱，为寒湿偏盛、中阳被困之征。

本证的治法为散寒祛湿，芳香化浊。方用霍香正气散（见大肠寒湿型泄泻一节）合纯阳正气丸（陈皮、丁香、茯苓、茅术、白术、藿香、姜半夏、肉桂、青木香、花椒叶、红灵丹），汤药未备时，可先服纯阳正气丸，同时吞服来复丹（玄精石、硝石、硫黄、橘皮、青皮、五灵脂）助阳化浊，理气和中，以图急救。

寒湿霍乱为霍乱证型中最轻的一种。但如果不积极救治，病情迅速发展，可出现危重证候，甚至导致病人死亡。

（三）痢疾

寒湿型痢疾多发生于平素恣食生冷瓜果之人。由于脾胃受伤，脾虚不运，水湿内停，造成中阳不足，湿从寒化，寒湿内蕴肠中的状态。如再次饮食不慎，寒湿壅塞大肠，肠中气机受阻，气滞血瘀，气血与肠中秽浊之气相搏结，化为脓血而成为寒湿痢。

寒湿之痢的主要临床表现为痢下赤白粘冻，白多赤少，

或纯为白冻状粪便，腹痛，里急后重，同时伴有饮食乏味，中脘饱闷，头身重困，舌质淡、苔白腻、脉濡缓之证。以上诸证的产生是由于寒湿滞留肠中，清浊不分，气机阻滞，故见下痢腹痛，里急后重；寒湿之邪多伤于气分，故下痢白多赤少或纯为白冻。寒湿中阻，运化不及，故饮食不香，中脘饱闷，头重身困。舌淡、苔白腻、脉濡缓，皆是寒湿内感之象。

本证治法为温化寒湿，佐以行气散寒。方用胃苓汤（见大肠寒湿泄泻一节），方中苍术、白术、厚朴燥湿运脾；桂枝、茯苓、泽泻、猪苓温化寒湿；陈皮理气散满。方中可加入当归以活血；加木香、枳实、炮姜以助散寒行气之力。

十九、大 肠 实 热

大肠实热证常因饮食不节，过食辛辣、酒热之品，或宿食停滞日久化热，或热病之后，邪热未清，肠道燥热，进而耗伤津液，气机不利，传化失司。临床出现便燥难下或腹泄稀水臭秽，腹痛拒按，肛门灼热肿痛，口燥唇焦，发热，或日晡潮热，手足汗出，烦渴，谵妄，小便短赤，舌红少津，苔黄燥，甚至起芒刺，脉数实有力之证。因实热结于大肠致大便秘结，腹痛拒按；但如果为热结旁流，则无便秘反见腹泄稀水、臭秽异常之证；肛门灼热肿痛是实热壅结大肠的表现；热盛伤津则口燥唇焦、小便短赤；发热或日晡潮热是邪气内播之象；胃气上逆则呕吐；邪热扰动神明则谵语烦躁；热邪蒸腾于内则使腠理开泄，故手足汗出。舌红苔黄、干燥起芒刺是热毒内盛之象；脉数而沉实有力是大肠实热的表

现。常见病证为便秘、腹痛、昏迷等。

（一）便秘

便秘是指大便秘结不通，排便时间延长，或虽有便意，而排便困难而言。有部分患者，大便次数正常，但粪质干燥，坚硬难排；或时有便意，而大便并不干燥，但排出困难等都属于本病范畴。本病的病因主要由于大肠传导功能失常，粪便在肠内停留时间过久，水分吸收过多，而使粪质干燥坚硬所致。《伤寒论》中将本病称为“阳结”、“阴结”或“脾约”。后世医家将本病分为“风秘”、“热秘”、“虚秘”、“气秘”、“湿秘”、“热燥”、“风燥”等类型。但这种方法比较繁杂，对临床指导意义不大，所以目前只按实秘与虚秘两大证型分类。

饮食入胃，经过脾胃的运化，吸收精微水分之后，所剩糟粕，最后由大肠传导而出，成为粪便。所以《内经》说：“水谷者，常并属于胃中，成糟粕而俱下于大肠。”如果脾胃运化和大肠传导功能正常，则大便通畅，不致发生便秘。若肠胃受病，或由于其他原因影响大肠正常功能时，则可发生便秘。

大肠实热型的便秘的原因常因素体阳盛；或因饮酒过多、过食辛辣厚味导致大肠积热；或热病之后，邪热留恋，肠胃燥热而耗伤津液，津失输布，不能下润大肠，而致大便干燥，排便困难。所以明·王肯堂在《证治准绳》中说：“热秘是由大肠燥热所致。”

大肠实热型便秘的临床表现为大便干结，小便短赤，面红身热，或兼有腹胀腹痛，口干口臭，心烦，舌红苔黄或黄燥、脉滑数等证。由于大肠积热，热盛伤津，肠道津液枯

燥，故大便干燥，肠热上蒸则口干口臭；热移膀胱，则小便短赤；热盛于内，故面红身热而心烦；热积大肠、腑气不通，故腹胀腹痛。舌红、苔黄或黄燥均为热盛伤津之象。

此证的治法以清热为主辅以润肠。方用麻子仁丸（麻子仁、芍药、炙枳实、大黄、炙厚朴、杏仁）。方中大黄、麻子仁泄热兼润肠通便为主药，辅以杏仁降气润肠，芍药养阴和里，枳实、厚朴行气除满。若津液已伤，可加生地、玄参、石斛之类以养阴生津；若兼郁热伤肝，证见急躁易怒、目赤等证，可另吞服更衣丸（芦荟、朱砂）以清肝通便。

便秘的治疗，虽以通下为基本原则，但因便秘的原因较多，因此必须明辨寒热、虚实、不可一见便秘之证就妄用大黄、芒硝、牵牛、巴豆之类通下。

除了药物治疗外，有便秘习惯者应保持精神舒畅，加强身体锻炼，注意饮食调理，养成按时登厕排便的习惯。这些措施均有利于便秘的预防与治疗。

（二）腹痛

腹痛是指自觉胃脘以下，耻骨毛际以上的部位发生疼痛的病证。由于腹腔是包括大肠在内的许多脏腑的居处，并且是手足三阴、足少阳、足阳明、冲、任、带等经脉循行之处，因此腹痛的病因病理比较复杂。临床上常分为寒、热、虚、实四大类。而这几类腹痛的表现往往相互错杂交织，因此，临床需仔细辨识。

大肠实热型腹痛多因暑热之邪外侵或腹中寒邪郁久不解化热；或恣食辛辣厚味，热邪与食滞交阻，气机失和，传导失司，以致腹中作痛。故《素问·举痛论》说：“热气留于小肠，肠中痛，瘴热焦渴，则坚干不得出，故痛而闭不通矣。”

本证的临床表现有腹痛拒按，腹满不舒，兼有大便秘结，烦渴引饮，自汗，小便短赤，舌苔黄腻、脉象洪数。上述症状的产生是由于热结于肠，气血郁滞，实邪在内，腑气不通，“不通则痛”，故见腹痛拒按，腹满不舒；热邪耗津，大肠传导功能失常，故大便秘结、烦渴引饮；内热则腠理开发津液外泄故自汗。尿赤、苔黄、脉数均为大肠实热之象。

本证的治法为清热攻下，常用大承气汤（大黄、芒硝、枳实、厚朴）治疗。方中大黄苦寒泄热，荡涤肠中之燥属为主药，芒硝咸寒泻热，软坚破结，佐以厚朴、枳实破气导滞、消除痞满。如燥结不甚而热重者可去芒硝再加黄芩、金银花等；如腹痛引及两胁者可加柴胡、郁金等。

需要指出的是，实热腹痛多见于现代医学的急腹证中。其病势较急，病程进展较快。临证可参照内、外科有关病证处理。

（三）昏迷

昏迷是以神志不清为特征的病证。中医在文献中论及本病时，常以“不省人事”、“不知与人言”、“昏蒙”、“昏不知人”、“昏愠”、“神昏”来描绘本证的神志不清的特点。

昏迷一证病理总属清窍失灵，神明失用。但其中邪闭清窍的属实，而神不守舍的属虚。热结大肠所致昏迷证，属实证昏迷之一，本证型昏迷的产生常因外感时邪，蕴结化热，或风热闭肺，传变入里。由于肺与大肠相表里，故邪热可内传于大肠，由于邪热炽盛，火炎于上，扰及神明而致神明昏愠，不醒人事。热结肠胃型昏迷的临床表现为昏不知人，躁

扰不宁，谵语，同时兼见发热，大便不通，腹部胀满，按之坚硬，口舌干燥，气粗喘满，舌苔焦黄起刺或焦黑燥裂，脉沉实有力或沉滑有力。由于外感六淫，化热入里，热结大肠，而使大肠传导功能失司，故临床可见发热、大便不通、腹部胀满，按之坚硬之证；里热炽盛，灼伤津液，故口舌干燥；热壅气逆而上迫于肺，故气粗喘满；邪热蒸迫，神明逆乱，清窍失灵，故昏不知人，躁扰不宁，并可见谵语一证。舌苔焦黄起刺或焦黑燥裂、脉沉实有力或沉滑有力均为里热燥实之象。

本证的治法为通腑泄热。方用大承气汤（见大肠实热型腹痛一节）。方中大黄苦寒泄热，荡涤肠胃；芒硝咸寒软坚润燥；枳实、厚朴苦寒行气，破结除满。四味相合以峻下热结，热去则神识自清。

二十、大 肠 虚 寒

大肠虚寒多由于年老体衰。身体虚弱或脾肾阳虚。阳气不足，不能温煦肠胃，寒自内生，凝滞于大肠，或原由脾胃虚寒，健运无权，逐渐演变下移，造成大肠虚寒之证。此外其临床表现为腹部冷痛绵绵，或便秘，或大便鹜溏，泄下如注，久痢滑脱，神疲气短，喜温怯寒，四肢不温，面色苍白，舌淡苔白滑、脉沉迟或弱而无力等。上述症状的产生是由于大肠虚寒，阳气不足，不能温煦肠胃，故腹部冷痛绵绵；阳气虚衰，运化失司，故有泄泻，甚则泄下如注；日久中气不足，可见痢下滑脱之证，但大肠虚寒之证也可以因为阳气不足、传导无力而引起秘结的；阳气不足则气短神疲；

阳虚生外寒，卫外不固、温煦无力，故怯寒怕冷，四肢不温；面色苍白是阳虚、气不周流所致。舌质淡、苔白滑、脉沉迟或弱皆为大肠虚寒、阳气不足之象。常见的病证为泄泻、便秘、腹痛、痢疾等。

（一）泄泻

大肠虚寒泄泻证常因久病之后，伤及肾阳，命门火衰，进而造成脾胃肠道失其濡养，虚寒内生，运化无力以致清浊不分而引起。

本证型泄泻常有腹泄或黎明即泻，伴有脐周疼痛、泻后痛减的表现；兼有腹痛畏寒、形寒肢冷、舌淡、苔白、脉弱等证。这些症状的产生常因肾阳不足所致。因肾为一身之元阳，有温煦脾胃肠道的作用，若肾阳虚衰则大肠虚寒而运化无力，传导失司而致泄泻；泻后腑气得通，故痛减。如本证与肾阳不足、命门火衰关系密切，则常在阳气未复、阴寒极盛的黎明时分发生泄泻；腹痛畏寒，形寒肢冷乃脾肾阳虚而不能温布之故。舌淡、苔白、脉弱为大肠虚寒之舌脉表现。

本证型的泄泻当用温补命门及肠胃、固涩止泻的方法治疗。方用四神丸（补骨脂、吴茱萸、肉豆蔻、五味子），方中补骨脂补命门之火，以温养脾阳；吴茱萸温补肠胃散寒；肉豆蔻温肾暖脾、涩肠止泻；五味子酸敛固涩。以上各药合用，以期达到温补命门及肠胃、固涩止泻的目的。若年老体虚，久泄不止，甚至中气下陷，造成滑脱不禁，肛门脱出者，可在上方中加入黄芪、党参、白术以健运胃肠、补中益气。必要时可合用桃花汤（赤石脂、干姜、粳米）以固涩止泻。

（二）便秘

大肠虚寒型便秘也称为“冷秘”。常因身体虚弱，或年老体衰，阳气不足，温煦无权，寒自内生，凝滞肠胃而致。由于阳虚不运，传导无力，粪便难出，而引起排便困难。所以《景岳全书·秘结》篇指出：“凡下焦阳虚，则阳气不行，阳气不行则不能传送而阴凝于下，此阳虚而阴结也。”

本证型便秘的主要证候为大便难涩，排出困难，腹中冷痛或腰脊酸冷，小便清长，兼有面色㿔白，四肢不温，喜热怕冷，舌淡苔白，脉沉迟等证。上述症状的产生主要由于大肠虚寒，肠道传导无力，故大便艰涩，排出困难；阴寒内盛，气机阻滞，寒又为阴邪，故腹中冷痛、喜热怕冷；阳虚温煦无权，致四肢不温，腰脊酸冷，小便清长。面色㿔白、舌淡苔白、脉沉迟皆为阳虚内寒之象。

本型便秘的治法为温阳通便。方用济川煎（当归、牛膝、肉苁蓉、泽泻、升麻），方中肉苁蓉咸温润降，补肾并能润肠，为本方的主药；当归辛甘温润，养血润肠；牛膝强腰肾为辅药；泽泻入肾而止泻，与牛膝合用具有宣通下降之功效；枳壳宽肠下行，稍加升麻为佐，以升清阳。腹痛者可加肉桂、木香以温阳散寒止痛。本证型的便秘也可选用半硫丸（半夏、硫磺），以温通寒凝、开通闭结。

便秘一证虽为闭塞不通之证，但冷秘却为阳气不足所致，因此当以补为通，这即中医所说的“塞因塞用”的治则。当大肠得以温养，运化传送功能得以恢复时，则便秘自开。

（三）腹痛

大肠虚寒型腹痛为素体阳气亏虚导致健运无权或寒湿停滞，渐致阳气衰惫，气血不能温养脏腑，而产生腹中作痛一

证。正如《诸病源候论·腹痛病诸侯》所说：“久腹痛者，脏腑虚而有寒，客于腹内，连滞不歇，发作有时。”

本证型腹痛的特点为腹痛绵绵，喜热恶冷，痛时喜按，饥饿和劳累后更甚，得食或休息后稍减，大便溏薄。兼有神疲、气短、怯寒等证，舌淡苔白、脉沉细。上述症状的产生，主要由于阳气不足，不能温养大肠，故腹痛绵绵，喜热恶冷，痛时喜按；劳累时或饥饿时，耗伤阳气及阴血，气血不能温养脏腑故腹痛易于发作。阳气不足，运化无权故大便溏薄；中气不足，卫阳不固故有神疲、气短、怯寒等证。舌质淡苔白、脉弱为虚寒之舌脉表现。

本证的治法为甘温补养、益气散寒。可用小建中汤（桂枝、白芍、甘草、生姜、大枣、饴糖）治疗。方中桂枝配饴糖，干姜配大枣均有温阳补虚的作用；芍药配甘草以和里缓急。如见精神困惫，或大便虽软而排出艰难者，可加黄芪以补气；若虚寒腹痛见证较重者，可用大建中汤治疗，方由川椒、干姜、人参、饴糖等组成。方中饴糖温阳补虚、缓急止痛；人参补中扶正；干姜辛热温阳散寒；川椒辛热逐寒温养。上四味药共同作用使寒去阳回，则痛逆自平。

腹痛一证的治疗，虽以“通”字立法，但“通”并非单指攻下通利而言。特别是虚寒之证，更应灵活掌握，才能治疗得当。所以《医学传真》说：“夫通则不痛，理也，但通之之法各有不同。调气以和血，调血以和气，通也。下逆者使之上行，中结者使之旁达，亦通也。虚者助之使通，寒者温之使通，无非通之之法也。若必以下泄为通，则妄矣。”

（四）痢疾

虚寒痢常见于脾胃素弱的人，其病因为感受寒湿之气，

或湿热痢过服寒凉之品，克伐中阳而成。其临床表现为久痢不止，下痢稀薄，带有白冻，腹部隐痛，口淡不渴，食少神疲，畏寒肢冷，甚则下痢滑脱不禁，舌质淡、苔薄白、脉弱。由于寒湿滞留肠中，大肠虚寒，故下痢稀薄带有粘冻、腹部隐痛、食少神疲、口淡不渴；由于阳气不足，不能温煦四末，故见畏寒肢冷；如中气下陷、固摄无权，则下痢滑脱不禁。舌淡、苔薄白、脉弱皆为大肠虚寒之舌脉表现。

虚寒痢的治法为温阳散寒、健脾化湿。常用方剂为理中汤，方由人参、甘草、干姜、白术组成。方中人参补中强壮胃肠；干姜温肠胃、散虚寒，助阳气；白术健脾燥湿；甘草补气益脾。方中可加附子、肉桂以助干姜温中散寒；加苍术、薏仁、茯苓以助白术健脾燥湿。

如久痢不止，体羸脉弱，下痢稀薄，滑脱不禁，为大肠虚寒，关门不固所致。此时应从温补脾肾着手，以收涩固脱。用桃花汤（见大肠虚寒型泄泻一节）或真人养脏汤（诃子、木香、肉桂、甘草、生姜、大枣）治疗。如痢久中气下陷而导致脱肛者，治宜益气升陷，可用补中益气汤（见肺气虚型感冒一节）治疗。

二十一、大 肠 液 亏

大肠液亏常因大肠燥热，日久不解，耗伤津液，或胃阴不足不能下及大肠而致。本证也多见于老年人及妇女产后或热病后期，其证可见大便秘结干燥、难于排出，常伴有头晕口臭，舌红少津、苔黄燥、脉细涩等证。由于大肠液亏，肠道失其滋润而传导不利，故大便燥结难于排出，甚至数日方

排便一次；大肠腑气不通，则影响胃气的下降，以致胃失和降，浊气上逆故可见口臭兼见头晕之证。燥热液亏，所以脉来细涩、舌苔黄燥少津。常见病证为便秘和产后大便难等证。

（一）便秘

大肠液亏型便秘的病因为劳倦内伤或病后、产后以及年老体虚之人，阴血津液亏虚，不能下润大肠以致大便干燥，排便不畅，甚至秘结不通。

本型便秘的主要症状为大便秘结，面色无华，头晕目眩，心悸，舌质淡少津、脉细等。由于阴血津液亏少，不能润肠故见大便秘结；阴虚精微亏虚不能上荣于面，故面色无华；不能滋养于脑则见眩晕；心失所养则心悸不安。舌淡少津、脉细均为阴津不足之象。

本证的治法以养阴润燥为主。常用方剂为润肠丸，方由当归、生地、麻仁、桃仁、枳壳组成，方中生地、当归滋阴润燥，与麻仁、桃仁共用兼能润肠通便；枳壳能引气下行。若阴虚内热者，可以出现烦热，口干，舌红少津等证。临证时可加入玄参、首乌、知母以清热生津；若津液已复而便仍干燥者，可用五仁丸（杏仁、柏子仁、松子仁、郁李仁、桃仁）治疗，以润肠通便。

大肠实热证和大肠液亏两种病证均可以产生便秘，临床见证又很相似，因此要对这两证加以鉴别。一般说来，大肠实热证属实，是腹中实热或燥热之邪所引起，临床上除了便秘证外，还有腹痛拒按，肛门灼热肿痛，发热，甚至出现日晡潮热，心烦不安，谵语等表现。治以苦寒攻下，药涤实热。而大肠津亏是属虚证范畴，是温热之邪侵袭人体，日久不解，耗津灼液，或年老体虚之人，妇女产后失血，阴液亏损所致。

临证有阴液不足的表现，如眩晕、口干咽燥、舌红少苔以及脉细数等，治宜滋阴润肠通便。

（二）产后大便难

产后饮食如常，而大便数日不解或大便时干燥疼痛难以解出者，称为产后大便难。

本证的致病原因为分娩失血，营血骤虚，津液亏耗，不能濡润肠道，以致肠燥便难；也有因阴虚火旺，内灼津液、津亏液少，肠道失于滋润，传导不利而致大便困难的。所以明·薛己说：“产后大便不通，因去血过多，大便干涸，或血虚火燥。”

本型的主要临床表现为产后大便干燥，数日不解，或解时艰涩难下，但腹无胀痛，饮食如常，面色萎黄，皮肤不润，舌淡苔薄、脉虚而涩。以上见证是由于产后失血伤津，津亏液少而肠道失于濡润，以致便难；由于证非外感里实，故饮食如常，腹无胀痛；阴血不足不能荣于头面皮肤，故见面色萎黄、皮肤不润；舌淡、脉虚涩为血少津亏之证。

本证应以养阴润肠的方法治疗。临证常用四物汤（见风寒袭肺型产后发热一节）加肉苁蓉、柏子仁、火麻仁、生首乌治疗。方中四物汤养血润燥，肉苁蓉、火麻仁、柏子仁、生首乌等滋补肾精，滑肠通便。若证见口干，腹满胀痛，手足心热，舌质红、苔薄黄、脉细数者，属阴虚火旺。宜滋阴清热，润肠通便。可在四物汤内加玄参、麦冬治疗；若证见大便难兼气喘自汗，头晕目眩，精神疲倦，脉大而虚者，为产后气血两虚之证。宜补气养血，润肠通便，方用圣愈汤（党参、黄芪、当归、熟地、白芍、川芎）加杏仁、郁李仁治疗。

附篇：常 见 疾 病

一、感 冒

感冒是风邪侵袭人体所引起的以头痛、鼻塞、流涕、喷嚏、恶寒、发热等为主要临床表现的常见外感疾病。

（一）风寒感冒型

【主证】 鼻塞声重，喷嚏，流清涕，喉痒，咳嗽，痰多稀薄，甚则恶寒发热，头痛身痛，无汗，舌苔薄白，脉浮或浮紧。

【治法】 辛温解表，宣肺散寒。

【方剂】 轻证用葱豉汤，风寒重证用荆防败毒散。

（二）风热感冒型

【主证】 发热，微恶风寒，或有汗出，头痛，鼻塞涕浊，口干而渴，咽喉红肿疼痛，咳嗽，痰黄粘稠，苔薄黄，脉浮数。

【治法】 辛凉解表，清肺透热。

【方剂】 银翘散加减。

（三）表寒里热型

【主证】 发热恶寒，无汗，肢节烦痛，鼻塞声重，口渴，咽痛，咳嗽气急，痰黄粘稠，心烦，或溲赤便秘，舌苔白或黄，脉浮数。

【治法】 疏风宣肺，散寒清热。

【方剂】 麻杏石甘汤加味。

（四）体虚感冒型

1. 气虚感冒

【主证】恶寒发热，头痛鼻塞，咳嗽痰白，倦怠无力，气短懒言，舌淡苔白，脉浮无力。

【治法】益气解表。

【方剂】参苏饮加减。

2. 阳虚感冒

【主证】身热轻，恶寒较甚，头痛身痛，无汗或自汗，面白，语声低微，四肢不温，舌淡胖苔白，脉沉无力。

【治法】助阳解表。

【方剂】参附再造丸加减。

3. 血虚感冒

【主证】头痛身热，微寒无汗，面色不华，唇甲色淡，心悸头晕，舌淡苔白，脉细，或浮而无力。

【治法】养血解表。

【方剂】葱白七味饮。

4. 阴虚感冒

【主证】头痛身热，微恶风寒，无汗或微汗，头晕心烦，口渴咽干，手足心热，干咳少痰，舌红，脉细数。

【治法】滋阴解表。

【方剂】加减葳蕤汤。

二、咳 嗽

咳嗽是肺系疾患的主要证候之一。

（一）外感咳嗽

1. 风寒咳嗽

【主证】咳嗽，痰稀色白。可伴有头痛，鼻塞，流清涕，骨节酸疼，寒热无汗，舌苔薄白，脉浮。

【治法】疏散风寒，宣通肺气。

【方剂】杏苏散加减。

2. 风热咳嗽

【主证】咳嗽不爽，痰稠而黄，口渴咽痛。可伴有头痛，身热，恶风汗出，舌苔薄黄，脉浮数。

【治法】疏风清热，宣肺化痰。

【方剂】桑菊饮加减。

3. 燥热咳嗽

【主证】干咳无痰，或痰少粘稠难出，鼻燥咽干，咳甚则胸痛，或有恶风发热，痰中带血丝，舌尖红，苔薄黄而干，脉细略数。

【治法】清肺润燥止咳。

【方剂】桑杏汤加减。

（二）内伤咳嗽

1. 痰湿犯肺

【主证】咳嗽痰多，痰白而稀，胸脘作闷，或胃纳不香，神疲乏力，大便时溏，苔白腻，脉濡滑。

【治法】健脾燥湿，化痰止咳。

【方剂】二陈汤。也可选用六君子汤。

2. 肝火犯肺

【主证】气逆咳嗽，面红喉干，咳时引胁作痛，舌苔黄少津，脉弦数。

【治法】清肝泻火，润肺化痰。

【方剂】黛蛤散合清金化痰汤加减。

3. 肺虚咳嗽

【主证】起病较慢，干咳少痰，或痰中带血，或咯血，口燥咽干，午后潮热，两颧红赤，手足心热，失眠盗汗，形体消瘦，神疲乏力，舌质红少苔，脉细数。

【治法】养阴清肺，化痰止咳。

【方剂】沙参麦冬汤加减。

三、喘 证

喘证以呼吸急促，甚至张口抬肩，鼻翼煽动为特征。

（一）实喘

1. 风寒袭肺

【主证】喘急胸闷，伴有咳嗽，咯痰稀薄，色白，初起多兼恶寒，头痛。无汗，口不渴，舌苔薄白，脉象浮紧。

【治法】散寒宣肺平喘。

【方剂】麻黄汤加味。

2. 风热犯肺

【主证】喘促气急，甚则鼻翼煽动，伴有咳嗽，痰稠色黄，难以咯出，或有胸痛，烦闷口渴，身热，汗出，恶风，苔薄黄，脉浮数。

【治法】清热解表，宣肺平喘。

【方剂】麻杏石甘汤加减。

3. 痰浊阻肺

【主证】喘咳痰多而粘，咯出不爽，胸中窒闷，恶心，纳呆，口粘无味，舌苔白腻，脉滑。

【治法】祛痰降气平喘。

【方剂】 三子养亲汤合二陈汤加减。

4. 气郁伤肺

【主证】 平素忧思气结，复因精神刺激，突然呼吸短促，咽中不适，甚则胸痛，可伴有失眠、心悸等症，苔薄，脉弦。

【治法】 开郁降气平喘。

【方剂】 五磨饮子。

(二) 虚喘

1. 肺虚

【主证】 喘促短气，言语无力，咳声低弱，自汗畏风，或咽喉不利，口干面红，舌质淡红，脉象软弱。

【治法】 益肺定喘。

【方剂】 生脉散加味。

2. 肾虚

【主证】 喘促日久，呼多吸少，动则喘息更甚，形瘦神惫，气不得续，汗出，肢冷而青，舌质淡，脉沉细。

【治法】 补肾纳气。

【方剂】 以金匱肾气丸为主方。

四、哮 证

哮证是一种发作性的痰鸣气喘疾患，以呼吸急促，喉间哮鸣为特征。

(一) 发作期

1. 冷哮

【主证】 呼吸急促，喉中有哮鸣音，痰白而粘，或稀薄多

沫，胸膈满闷如室，面色晦滞带青，口不渴，或渴喜热饮，舌苔白滑，脉象浮紧，或兼有头痛，发热，恶寒，无汗等表证。

【治法】 温肺散寒，豁痰利窍。

【方剂】 射干麻黄汤、小青龙汤均可选用。

2. 热哮

【主证】 呼吸急促，喉中有哮鸣声，胸高气粗，咳呛阵作，痰稠黄胶粘，咳吐不利，烦闷不安，汗出，口渴喜饮，舌质红，苔黄腻，脉滑数。或兼头痛，发热，微恶风等表证。

【治法】 宣肺清热，化痰降逆。

【方剂】 越婢加半夏汤或用定喘汤。

（二）缓解期

1. 肺虚

【主证】 平素怯寒自汗，发前喷嚏、鼻塞、流清涕。

【治法】 补肺固卫。

【方剂】 玉屏风散或桂枝加黄芪汤。

2. 脾虚

【主证】 平素咳嗽痰多，食少脘痞，倦怠乏力，大便不实，或食油腻、海腥易腹泻腹痛，可因饮食不当而诱发哮喘。

【治法】 健脾化痰。

【方剂】 六君子汤。

3. 肾虚

【主证】 平素即短气，动则息促，腰酸膝软，怯寒神疲，或盗汗，手足心热。

【治法】 补肾纳气。

【方剂】 金匱肾气丸或七味都气丸。

五、饮 证

饮证是指水液在体内运化输布失常，停积于某些部位的一类病证。

（一）实证

1. 饮留胃肠

【主证】脘腹坚满而痛，胃中有振水声，或肠间水声漉漉，脉沉弦有力。或伴有下利而利后腹仍坚满，舌苔白腻或微黄，或伴有便秘而无矢气，口舌干燥，舌苔黄厚。

【治法】攻下逐饮。

【方剂】饮邪伏胃，或热象不著者，用甘遂半夏汤；饮热互结，大肠壅塞者，用己椒苈黄丸。

2. 饮停胸胁

【主证】胸胁胀痛，咳唾、转侧、呼吸时则疼痛加重，肋间饱满，气短息促，苔白，脉沉弦。

【治法】攻逐水饮。

【方剂】十枣汤或葶苈大枣泻肺汤。

3. 饮犯胸肺

【主证】咳嗽胸满，甚则不能平卧，痰如白沫量多，久咳则面目浮肿，舌苔白腻，脉弦紧。

【治法】温肺化饮。

【方剂】以小青龙汤为主。

4. 饮溢四肢

【主证】四肢沉重或关节疼痛，甚则肢体微肿，无汗恶寒，口不渴。或兼有咳喘，痰多白沫，苔白，脉弦紧。

【治法】 温散化饮。

【方剂】 小青龙汤。

如表寒外束，饮邪郁而化热，则宜大青龙汤发表清里。

（二）虚证

1. 脾胃阳虚

【主证】 胸胁支满，脘腹喜温喜按，胃中有振水音，背部寒冷如掌大，不欲饮水，或热饮不多，或饮入易吐，恶心，呕吐清水痰涎，心悸气短，头目昏眩，舌苔白滑，脉弦细而滑。

【治法】 温脾化饮。

【方剂】 苓桂术甘汤。

2. 肾阳虚弱

【主证】 怯寒肢冷，少腹拘急不仁，脐下悸动，气息短促，小便不利，或吐涎沫而头目昏眩，舌体胖大，苔白腻或灰腻，脉沉细带滑。

【治法】 温肾化饮。

【方剂】 金匱肾气丸。

六、肺 痿

肺痿，指肺叶痿弱不用，临床是以咳吐浊唾涎沫为主证。

（一）虚热

【主证】 咳吐浊唾涎沫，其质较粘稠，咳声不扬，气急喘促，口干咽燥，形体消瘦，皮毛干枯，舌红而干，脉虚数。

【治法】 滋阴，清热，润肺。

【方剂】 麦门冬汤。

（二）虚寒

【主证】 吐涎沫，其质清稀量多，口不渴，头眩短气，形寒，神疲乏力，饮食减少，小便数或遗尿，舌质淡，脉虚弱。

【治法】 温肺益气。

【方剂】 甘草干姜汤。

七、肺 痛

肺痈是肺部生脓疡的一种病证。以咳嗽、胸痛、发热和吐痰腥臭，甚则咳吐脓血为主证。

（一）初期

【主证】 恶寒发热，咳嗽痰少而粘，胸痛，咳时尤甚，呼吸不利，口干鼻燥，舌苔薄黄，脉浮滑而数。

【治法】 疏散风热，清肺化痰。

【方剂】 银翘散加鱼腥草治之。

喘甚者，可用麻杏石甘汤清肺平喘。

（二）成痈期

【主证】 壮热汗出，寒战，胸闷作痛，转侧不利，咳嗽气急，咳吐脓痰，其味腥臭，口干咽燥，烦燥不安，舌苔黄腻，脉象滑数。

【治法】 清热解毒，化瘀散结。

【方剂】 千金苇茎汤加味。

热毒瘀结，痰味异臭者，合用犀黄丸以解毒化瘀。

（三）溃脓期

【主证】 咳吐脓血，腥臭异常，胸中烦满而痛，甚则气喘不能平卧，身热面赤，烦渴喜饮，舌质红或绛，苔黄腻，脉多滑数。

【治法】 排脓，清热，解毒。

【方剂】 桔梗汤合千金苇茎汤。

（四）恢复期

【主证】 邪退而正气日渐恢复，身热渐退，咳嗽减轻，脓痰日少，诸证逐渐好转，神疲纳呆，舌质红，脉细数无力。

【治法】 润肺化痰，益气养阴。

【方剂】 清燥救肺汤。

八、肺 癆

肺癆是具有传染性的慢性虚弱疾患。以身体逐渐消瘦，证见咳嗽、咳血、潮热、盗汗等为特征。

（一）肺阴亏损

【主证】 干咳少痰，或痰中带血，胸痛，潮热颧红，咽干口燥，舌质红，苔薄黄少津，脉细数。

【治法】 养阴润肺。

【方剂】 百合固金汤加减。

（二）阴虚火旺

【主证】 骨蒸潮热，夜寐盗汗，五心烦热，失眠多梦，急躁易怒，咳呛痰少，或痰黄粘稠，反复咯血，量多色鲜，胸胁掣痛，男子梦遗，舌质红绛，脉象细数。

【治法】 滋阴清火。

【方剂】 秦艽鳖甲散加減。

出血不止者加服十灰散以涼血止血。

（三）氣陰兩虛

【主証】 咳嗽，咳血，潮熱，顫紅，自汗盜汗，面自神疲，氣短聲怯，倦怠乏力，食慾不振，舌質光紅，苔薄或剝，脈細數無力。

【治法】 益氣養陰。

【方剂】 月華丸加減。

（四）陰陽兩虛

【主証】 咳哈咯血，勞熱骨蒸，盜汗遺精，聲嘶失音，形體羸弱，形寒惡風，自汗，喘息氣短，面浮肢腫，飲食少進，大便溏薄，舌光質紅少津，或舌淡體胖有齒痕，脈象微細。

【治法】 填補精血，溫補脾腎。

【方剂】 保真湯加減。或與白風膏、補髓丹等同用，以培益先天之精。

九、痢疾

痢疾以腹痛，里急後重，下痢赤白膿血為主証。

（一）濕熱痢

【主証】 腹痛，里急後重，下痢赤白，肛門灼熱，小便短赤，舌紅，苔黃膩，脈滑數。

【治法】 清熱化濕解毒，輔以調氣行血導滯。

【方剂】 芍藥湯。

（二）疫毒痢

【主证】 发病急骤，壮热，口渴，头痛烦躁，甚至昏迷
痉厥，或腹痛剧烈，里急后重，痢下鲜紫脓血，舌质红绛，
苔黄燥，脉滑数。

【治法】 清热凉血解毒。

【方剂】 白头翁汤。

（三）寒湿痢

【主证】 痢下赤白粘冻，白多赤少，或纯为白冻，伴有
腹痛、里急后重，饮食乏味，中脘饱闷，头身重困，舌质淡，
苔白腻，脉濡缓。

【治法】 温化寒湿，佐以行气散寒。

【方剂】 胃苓汤。

（四）虚寒痢

【主证】 久痢不愈，下痢稀薄，带有白冻，腹部隐痛，
口淡不渴，食少神疲，畏寒肢冷，舌质淡，苔白薄，脉细强。

【治法】 温中散寒，健脾化湿。

【方剂】 理中汤。

（五）休息痢

【主证】 下痢时发时止，日久不愈，发作时便下脓血，
里急后重，腹部疼痛，饮食减少，倦怠怯冷，舌质淡苔腻，
脉细。

【治法】 健脾温中，清热化湿，佐以调气和营。

【方剂】 连理汤。

十、便秘

便秘是指大便秘结不通，排便时间延长，或虽有便意，

而排便困难而言。

(一) 实秘

1. 热秘

【主证】 大便秘结，小便短赤，面红身热，或兼有腹胀腹痛，口干口臭，心烦，舌红苔黄或黄燥、脉滑数。

【治法】 清热润肠。

【方剂】 麻子仁丸。

2. 气秘

【主证】 大便秘结，欲便不得，噎气频作，胁腹痞满，甚则腹中胀痛，纳食减少，舌苔薄腻，脉弦。

【治法】 顺气导滞。

【方剂】 六磨汤。

(二) 虚秘

1. 气虚

【主证】 大便并不一定干硬，虽有便意，临厕努挣乏力，挣则汗出短气，面气㿔白，神疲肢倦，舌淡苔白，脉虚。

【治法】 益气健脾升阳。

【方剂】 黄芪汤。

2. 血虚

【主证】 大便秘结，面色无华，头晕目眩，心悸，唇舌淡，脉细。

【治法】 养血润燥。

【方剂】 润肠丸。

3. 阳虚

【主证】 大便艰涩，排出困难，小便清长，面色㿔白，四肢不温，喜热怕冷，腹中冷痛，或腰脊酸冷，舌淡苔白，

脉沉迟。

【治法】 温阳通便。

【方剂】 济川煎，亦可选用半硫丸。

十一、汗 证

汗证是指因阴阳失调，营卫不和，腠理开阖不利而引起汗液外泄的病证。

（一）自汗

1. 营卫不和

【主证】 汗出恶风，周身酸楚，时寒时热，常见于表虚之人而冒见，或经常失眠者，而遇情绪波动，则汗自出或汗出加重，脉缓，苔薄白。

【治法】 调和营卫。

【方剂】 桂枝汤。

2. 肺气不足

【主证】 汗出畏寒，动则益甚，久病体弱，平时不耐风寒，极易感冒，面色晄白，脉细弱，苔薄白。

【治法】 益气固表。

【方剂】 玉屏风散。

3. 热淫于内

【主证】 蒸蒸汗出，口渴喜冷饮，面赤烘热，烦躁不宁，或兼发热，或肢节烦痛，或大便干结，舌红苔黄，脉洪大。

【治法】 清里泄热。

【方剂】 白虎汤。

（二）盗汗

1. 心血不足

【主证】 睡则汗出，醒则汗止，心悸少寐，面色不华，气短神疲，舌淡苔薄，脉虚。

【治法】 养心补血敛汗。

【方剂】 归脾汤。

2. 阴虚火旺

【主证】 潮热盗汗，虚烦少寐，五心烦热，形体消瘦，女子月经不调，男子梦遗，舌红少苔，脉弦细数。

【治法】 滋阴降火。

【方剂】 当归六黄汤。

（三）脱汗

【主证】 急病或重证患者，突然大汗不止或出汗如油，声短息微，精神疲惫不支，四肢厥冷，脉微欲绝或脉大无力，舌卷少津。

【治法】 益气回阳固脱。

【方剂】 参附汤。

（四）战汗

【主证】 急性热病中发热口渴，躁扰不宁，突然全身恶寒战栗，而后汗出，脉浮数，苔薄黄。

【治法】 扶正祛邪。

【方剂】 战汗顺利者可不必处理。若仍无汗属正虚者，用党参、生姜煎汤。

（五）黄汗

【主证】 汗出色正黄如柏汁，染衣着色，口中粘苦或口渴不欲饮，胁痛纳呆，身体浮肿，小便不利，发热烦躁，苔黄腻，脉弦滑。

【治法】 清热利湿。

【方药】 茵陈五苓散。

十二、痰 证

痰证是指脏腑气血失和，水湿、津液凝结成痰所产生的各种病证。

（一）实痰

1. 痰浊壅肺

【主证】 胸闷，咳喘，喉中痰鸣，痰多或白或黄，或稀或稠，苔腻，脉滑。

【治法】 祛痰肃肺。

【方剂】 杏苏散。

2. 痰阻中焦

【主证】 胃脘堵闷，嘈杂不饥，泛吐痰涎，头目眩晕，肢体沉重，或腹泻肠鸣，苔白腻，脉濡滑。

【治法】 和胃化痰。

【方剂】 二陈汤。

3. 痰郁互结

【主证】 心悸失眠，易怒善惊，胸痛脘闷，喜太息，或精神失常；或突然昏仆，呕吐痰涎；或进食发噎；或咽喉不利，似有物梗塞，吐之不出，咽之不下；或发瘰癧瘰癧。舌红苔厚腻，或白或黄，脉弦滑。

【治法】 解郁化痰；镇心宁神。

【方剂】 温胆汤。

4. 风痰闭阻

【主证】 口眼歪斜，半身不遂，肢体麻木，或突然昏仆不省人事，喉中痰鸣，苔厚腻，脉弦滑。

【治法】 祛风通络，豁痰开窍。

【方剂】 风痰阻络者用牵正散。风痰闭窍用涤痰汤。

（二）虚痰

1. 肺虚痰恋

【主证】 咳喘日久，动则益甚，痰粘难咯或痰稠量多，或自汗畏寒，易于感冒，或潮热颧红，舌淡红，苔薄白，脉细滑而无力。

【治法】 补肺化痰。

【方剂】 补肺阿胶散合半贝丸。

2. 脾虚痰盛

【主证】 纳呆恶心，泛吐痰浊，神疲乏力，面色萎黄不泽或虚浮，腹胀便溏，舌苔腻，脉细软。

【治法】 健脾化痰。

【方剂】 六君子汤。

3. 肾虚痰泛

【主证】 久病痰喘气促，呼多吸少，动则更甚，痰多而稀薄，浮肿畏寒，腰膝冷痛，晨泻尿频，舌淡苔薄，脉沉细无力。

【治法】 温肾行水化痰。

【方剂】 金匱肾气丸。

若肺肾阴虚者，再与生脉散合治。

十三、小 儿 感 冒

感冒是小儿时期最常见的疾病，乃由外感时邪所致。

临床以发热、怕冷、鼻塞、流涕、咳嗽、头痛、身痛为主证，俗称“伤风”。

（一）风寒型

【主证】恶寒、发热，无汗，鼻塞，流清涕，喷嚏，咳嗽，吐痰清稀，头痛，喉痒，舌苔薄白，脉浮紧，指纹浮红。

【治法】辛温解表，宣肺散寒。

【方剂】荆防败毒散。

（二）风热型

【主证】发热重，恶寒轻，有汗，头痛，鼻塞，流脓涕，喷嚏，咳嗽，吐痰黄稠，咽部红肿疼痛，口干而渴，舌质红，苔薄白或薄黄，脉浮数，指纹浮露，色较红赤。

【治法】辛凉解表，宣肺清热。

【方剂】银翘散或桑菊饮。

（三）兼证

1. 夹痰

【主证】兼见咳嗽较剧，咳声重浊，喉中痰鸣，舌苔厚腻，脉象浮滑而数。

【治法】偏于风寒者，治宜辛温解表，佐以宣肺化痰，偏于风热者，治宜辛凉解表，佐以清肺化痰。

【方剂】偏于风寒者，加用二拗汤；偏于风热者，加用杏苏饮。

2. 夹食滞

【主证】兼见脘腹胀满，不思乳食，呕吐酸腐，口气秽浊，大便酸臭，或腹痛泄泻，或大便秘结，小便短赤，舌苔厚腻，色白或黄，脉象滑实，指纹紫滞。

【治法】解表兼消食导滞。

【方剂】 兼服保和丸。

3. 夹惊

【主证】 兼见惊惕啼叫，睡卧不宁，齟齿，舌尖红赤，脉象弦数，指纹青紫。

【治法】 安神镇惊。

【方剂】 加用钩藤、僵蚕、地龙、蝉衣、磁石。

十四、小 儿 咳 嗽

咳嗽是小儿肺系疾患中一个常见的证候。无论外感、内伤所致之肺失清肃而壅遏不宜者，皆可发生咳嗽。

（一）外感咳嗽

1. 风寒咳嗽

【主证】 咳嗽频作，痰白稀薄，恶寒无汗，发热头痛，鼻塞流涕，喉痒声重，或全身酸痛，舌苔薄白，脉象浮紧。

【治法】 疏风散寒，宣肺止咳。

【方剂】 金沸草散。

2. 风热咳嗽

【主证】 咳嗽不爽，痰黄粘稠，不易咯出，口渴咽痛，鼻塞浊涕，伴有发热头痛，微汗出，舌苔薄黄，脉象浮数。

【治法】 疏风清热，宣肺止咳。

【方剂】 桑菊饮。

（二）内伤咳嗽

1. 肺热咳嗽

【主证】 咳嗽阵作，痰稠难咯，咽喉干燥，发热口渴，面赤唇红，目赤口苦，甚则鼻衄，小便短赤，或大便干燥，烦

躁不宁，舌红少津，苔黄，脉象滑数。

【治法】 清热泻肺，止咳化痰。

【方剂】 清宁散。

2. 痰湿咳嗽

【主证】 咳嗽痰壅，色白而稀，胸满纳呆，神乏困倦，舌质淡红，苔白腻，脉滑。

【治法】 健脾燥湿，止咳化痰。

【方剂】 二陈汤。

倘痰郁久化热，治以清热化痰，方用加味泻白散加竹沥。

3. 阴虚燥咳

【主证】 干咳无痰，或痰少而粘，不易咯出，口渴咽干，喉痒声嘶，手足心热，或咳痰带血，午后潮热，舌红少苔，脉象细数。

【治法】 清肺润燥。

【方剂】 沙参麦冬汤。

4. 肺脾气虚

【主证】 咳而无力，痰白清稀，面色晄白，气短懒言，语声低微，喜温畏寒，体弱多汗，舌质淡嫩，脉细无力。

【治法】 健脾益气。

【方剂】 六君子汤。

十五、小儿肺炎喘咳

肺炎喘咳是小儿主要的常见病之一，尤多见于婴幼儿，四季均有发病，但以冬春为多。典型的肺炎喘咳，临床是以发热、咳嗽、气促、鼻煽为主要特征。

（一）风邪闭肺型

1. 风寒闭肺

【主证】恶寒发热，无汗，不渴，咳嗽不畅而气促，痰白且稀，舌苔薄白或白腻，舌质不红，指纹青红，多在风关，脉浮紧而数。

【治法】辛温解表，宣肺化痰。

【方剂】华盖散加减。

2. 风热闭肺

【主证】发热有汗，口渴，咳嗽痰浓，气促鼻煽，面赤唇红，咽红，舌苔黄，舌质红，小便黄，大便不畅或有粘液，指纹青紫，多在气关，脉浮数或滑数。

【主治】辛凉解表，宣肺化痰。

【方剂】麻杏石甘汤加味。

（二）痰热闭肺型

【主证】壮热烦躁，喉鸣痰壅。气促喘憋，呼吸困难，鼻煽，甚则两肋煽动，胸高抬肩，摇身撷肚，舌苔黄腻，舌质红，小便黄少，大便干结，指纹青紫多在气关以上，脉洪滑数。

【治法】清热宣肺，豁痰平喘。

【方剂】五虎汤合葶苈大枣泻肺汤。

（三）正虚邪恋型

1. 阴虚邪恋

【主证】低热多汗，面唇樱红或潮红，干咳痰少，舌苔光剥或干，舌质红干，脉象细数，指纹多为沉而略紫。

【治法】养阴清肺。

【方剂】沙参麦冬汤。

2. 肺脾气虚

【主证】低热起伏，多汗，四肢欠温，咳嗽无力，面色㿔白，消瘦神倦，纳呆便溏，舌苔白滑，舌质偏淡，指纹多为沉而色淡。

【治法】益气健脾。

【方剂】人参五味子汤。

（四）变证的治疗

1. 肺气闭塞、心阳虚衰

【主证】面色苍白，口唇紫绀，呼吸浅促，四肢欠温，虚烦不安，舌质暗紫，脉虚数或微弱，指纹沉而色青，可达命关。

【治法】开宣肺气，温补心阳。

【方剂】麻黄汤合参附汤。

2. 邪陷心肝、热盛动风

【主证】壮热神昏，烦躁谵语，四肢抽搐，口噤项强，两目上视，呼吸浅促微弱或间歇叹息，舌质绛红，指纹青紫，可达命关或透关射甲。

【治法】清心开窍，平肝熄风。

【方剂】羚角钩藤汤。

十六、小 儿 哮 喘

哮喘是小儿时期常见的一种呼吸道疾病。以阵发性的哮鸣气促、呼气延长为特征。

（一）寒喘型

【主证】咳嗽气促，喉间有哮鸣声，痰多白沫，形寒无

汗，面眇色晦，四肢不温，口不渴或渴喜热饮，舌苔薄白或白腻，脉浮滑或濡数。

【治法】 温肺化痰，止咳平喘。

【方剂】 小青龙汤合三子养亲汤。

（二）热喘型

【主证】 咳喘哮鸣，痰稠色黄，发热面红，胸闷膈满，渴喜冷饮，小便黄赤，大便干燥或秘结，舌苔薄黄或黄腻，脉滑数。

【治法】 清肺化痰，止咳平喘。

【方剂】 定喘汤。

（三）寒喘兼阳虚

【主证】 面色青灰，神疲肢冷，头汗涔涔，张口抬肩，端坐喘息，小便清长，舌淡苔薄白，脉细无力。

【治法】 温肺平喘，补肾摄纳。

【方剂】 小青龙汤合二味黑锡丹。

十七、小 儿 汗 证

是指小儿在安静的状态下（如静坐、静卧，睡眠等），全身或身体某些部位汗出很多，或大汗淋漓不止为主的一种病证。

（一）表虚不固

【主证】 以自汗为主，有时伴盗汗，汗出以头项、肩背明显，动则益甚，汗后乏力神倦、畏冷，平时易患感冒。甚则面色眇白，唇淡，肢端欠暖。舌质淡，苔薄白，脉细弱，指纹淡。

【治法】 益气固表。

【方剂】 牡蛎散合玉屏风散。

(二) 营卫不和

【主证】 自汗为主，汗出遍身，恶风，不发热或时有低热，神倦，胃纳欠佳。舌淡红，苔薄白，或白腻，脉沉缓，或细缓，指纹淡滞。

【治法】 调和营卫。

【方剂】 黄芪桂枝五物汤。

(三) 气阴虚弱

【主证】 以盗汗为主，常伴自汗，汗出较多，遍身湿润，身冷，动则更甚，形寒肢冷，神萎不振，嗜睡而不易叫醒。舌质淡白，苔薄白或剥苔，脉沉细或细弱，指纹紫伏。

【治法】 益气养阴。

【方剂】 生脉散。

若气虚偏甚者，易伴脱肛或泄泻，可用补中益气汤合生脉散。

(四) 脾胃积热

【主证】 时时自汗出，以四肢明显，或局限于四肢、头额，口渴欲饮而饮不多，胃纳呆滞，大便不调，常伴腹胀。舌质微干，苔薄微黄，脉濡数或弦，指纹黄或紫滞。

【治法】 健脾泻热。

【方剂】 异功散。

十八、麻 疹

麻疹是一种急性发疹性传染病。临床以发热 3 ~ 4 天后，

皮肤出现色红如麻粒大小的疹子为特征。

(一) 顺证

1. 初热期

【主证】 由发热至皮疹出现约3天。发热渐高，咳嗽流涕，目赤怕光，眼胞浮肿，泪水汪汪，神倦纳呆，或伴呕吐，泄泻，咽痛，热甚时或伴有惊惕，口腔颊部近白齿处可见“麻疹粘膜斑”，舌苔薄白，或微黄，脉浮数，指纹紫。

【治法】 辛凉透表。

【方剂】 银翘散或宣毒发表汤。

2. 见形期

【主证】 皮疹开始出现至消退，约3~4天。高热不退，肌肤灼热，口渴引饮，咳嗽加剧，神倦懒动，目赤眵多，烦躁或嗜睡，或伴惊跳、抽风、皮肤出现玫瑰样丘疹，如针尖大小，扪之碍手。先见于耳后发际及颈部，渐及头面、胸背、四肢，依序出现。手掌足底见疹为麻疹透齐。初起稀疏，色较鲜红，以后逐渐稠密，融合成片，色转暗红，分布均匀。舌质红，苔黄，脉洪数，指纹紫。

【治法】 清热解毒透疹。

【方剂】 清解透表汤。

3. 疹没期

【主证】 皮疹按出现的次序消退。皮屑细微如糠样脱落，皮肤遗留棕褐色的斑迹，热退身凉，精神爽快，胃纳日增，咳嗽大减，舌质红、少津、苔少、脉细弱或细数。指纹淡红。

【治法】 养阴益气，清解余邪。

【方剂】 沙参麦冬汤。

(二) 逆证

1. 麻毒闭肺

【主证】 麻毒炽盛内陷，闭郁于肺，肺闭不宣，肃降失常，邪毒化火，炼液为痰所致。是麻疹常见的一种逆证。证见高热不退，咳嗽剧烈，气促鼻煽，喉间痰鸣，疹出不透。甚则烦躁不宁，口唇紫绀，四肢欠温，舌质红绛，苔薄黄或黄厚，脉浮数或洪数，指纹青紫。

【治法】 清热解毒，宣肺化痰。

【方剂】 麻杏石甘汤。

2. 麻毒内陷心包

【主证】 高热不退，神志模糊，或神昏谵语，狂躁不安、呕吐、抽风，甚则呼吸微弱，面色苍白，四肢欠温，舌质红绛，苔黄干，脉滑数或洪数。

【治法】 清热解毒，平肝熄风。

【方剂】 犀角地黄汤。

3. 麻毒攻喉

【主证】 咽喉肿痛，吞咽不利，呛咳呕吐，声音嘶哑，心顺不宁。甚则呼吸困难，抬肩张口，舌质红，苔黄，脉浮数。

【治法】 清热解毒，利咽消肿。

【方剂】 清咽下痰汤。

十九、风 疹

风疹是一种较轻的发疹性传染病。临床初起类似感冒，发热一、二天后，皮肤出现淡红色斑丘疹，耳后及枕部淋巴结肿大为其特征。

(一) 邪郁肺卫型

【主证】恶风发热，咳嗽流涕，目赤喷嚏，精神倦怠，胃纳欠佳，疹色浅红。先起于头面，继发于身躯，分布均匀，稀疏细小，二、三日消退，有瘙痒感，耳后及枕部淋巴结肿大，舌苔薄黄，脉浮数，指纹紫在风关。

【治法】疏风清热。

【方剂】银翘散。

(二) 邪热炽盛型

【主证】高热口渴，心烦不宁，神倦懒动，小便黄赤，短少，疹色鲜红或紫暗，成片相见，扪之碍手，瘙痒较甚，消退延缓，纳呆食少，或伴胸腹闷胀，大便干结，口唇较干，舌质红，苔黄粗或黄厚，脉洪数，指纹紫，风关或上达气关。

【治法】凉血解毒。

【方剂】透疹凉解汤。

二十、幼儿急疹

幼儿急疹是由病毒感染引起的一种急性出疹性传染病，多发生于哺乳的婴儿。临床以先有发热，热退后皮肤即出现玫瑰红色的小丘疹为特点。

(一) 发热期

【主证】突发高热，胃纳差，小便黄短，常伴呕吐、腹痛、泄泻、惊跳、咽部红肿、目赤，但精神如常，舌苔薄黄，脉浮数，指纹青紫。

【治法】疏风清热。

【方剂】 桑菊饮。

（二）出疹期

【主证】 热退身凉，全身出现如麻粒样的玫瑰红色丘疹，如针尖大小。常先见于颈部，很快延及全身。以躯干明显，压之退色，无痒感，1～2天后消退。不留疤痕，不脱糠屑，或伴有颈周围淋巴结肿大，苔薄黄，脉浮数，指纹紫淡。

【治法】 凉血解毒。

【方剂】 化斑解毒汤加减。

二十一、猩 红 热

猩红热是以发热，咽喉肿痛，或伴腐烂，全身有弥漫性猩红色皮疹为特征。

（一）邪在卫气型

【主证】 突然起病，发热，恶寒，头痛，呕吐，咽喉焮红肿痛，或伴白腐糜烂，面赤，大便干，小便黄，舌苔白，脉浮数有力。

【治法】 清热利咽。

【方剂】 银翘散。

（二）邪入营血型

1. 热毒炽盛

【主证】 壮热，面赤，口渴引饮，烦躁不安，咽喉肿烂伴白腐，疹色猩红，弥漫全身，压之退色，大便干，小便黄赤，口唇干红，舌色红绛，舌起刺，形似杨梅，脉数有力。

【治法】 清营解毒。

【方剂】 清瘟败毒饮。

2. 邪毒内陷

【主证】 壮热不已，神昏谵语，惊搐躁动，皮疹紫红，甚或可见瘀点，口干，唇燥，舌质红绛，脉数。

【治法】 解毒凉血开窍。

【方剂】 清营汤。

(三) 肺胃阴虚型

【主证】 神疲，食少，唇干，皮肤干燥脱屑，舌质干，脉细。

【治法】 养阴和中。

【方剂】 沙参麦冬汤。

二十二、水 痘

水痘是由于感染水痘病毒引起的一种急性传染病。临床以发热、皮肤及粘膜分批出现斑疹、丘疹、疱疹、痂盖为特征。

(一) 风热夹湿型

【主证】 发热，咳嗽，流涕，纳减，痘疹红润，稀疏椭圆，清净明亮，内含水液，并有瘙痒，二便调和，舌苔薄白，脉浮数或略数。

【治法】 疏风清热，解毒祛湿。

【方剂】 银翘散。

(二) 湿热炽盛型

【主证】 壮热烦渴，口齿干燥，唇红面赤，神萎不振。痘疹稠密，疹色紫暗。痘浆混浊不透亮，甚则口腔亦见痘疹，并有牙龈肿痛，大便干结，小便短赤，舌苔黄糙而厚，脉洪

数或滑数。

【治法】 清热凉血、解毒渗湿。

【方剂】 加味消毒饮或清胃解毒汤。

二十三、 疳 腮

疳腮证是由腮腺炎病毒所引起的一种急性传染病。临床以发热、耳下腮部肿胀疼痛为主要特征。

（一）温毒在表型

【主证】 畏寒发热，头痛轻咳，耳下腮部酸痛，咀嚼不便。继之一侧或两侧腮部肿胀疼痛。边缘不清、舌苔薄白微黄，脉象浮数。

【治法】 疏风清热，散结消肿。

【方剂】 银翘散。

（二）热毒蕴结型

【主证】 高热头痛，烦躁口渴，食欲不振，或伴呕吐，精神倦怠，腮部漫肿，灼热疼痛，咽喉红肿，吞咽咀嚼不便，大便干结，小便短赤，舌苔薄腻而黄，脉滑数。

【治法】 清热解毒，软坚消肿。

【方剂】 普济消毒饮。

二十四、 白 喉

白喉又称“白缠喉”，是由白喉杆菌引起的一种急性传染病。临床以鼻、咽、喉部粘膜有白色假膜形成，犬吠样咳嗽，喘鸣和全身毒血症状为特点。

（一）风热型

【主证】 发病初起，表证明显。发热恶寒，头痛身疼，苔薄白，脉浮数，咽红有白点或片状假膜，证属风热邪毒客于肌表。

【治法】 疏风清热解毒。

【方剂】 银翘散。

（二）阳热型

【主证】 高热微汗，面红目赤，口渴心烦，小便短少，舌红苔黄，脉洪数，咽红肿较甚，假膜面积较大，证属疫毒内盛。

【治法】 泻火解毒消肿。

【方剂】 神仙活命饮。

（三）阴虚型

【主证】 低热，鼻干唇燥，咽喉微痛，舌红少苔、干燥少津，脉细数，咽部白点或白块，证属阴虚燥热。

【治法】 养阴清热解毒。

【方剂】 锡类散或冰硼散吹喉。

（四）痰浊闭塞型

【主证】 面色苍白，痰鸣唇绀，烦躁出汗，吸气困难，有三凹表现。

【治法】 逐痰通闭，辟秽解毒。

【方剂】 解毒雄黄丸。

（五）疫毒内侵型

1. 心气不足

【主证】 面色苍白，神疲乏力，头面汗出，舌淡，脉数无力，并有结代脉出现。

【治法】 益气养心。

【方剂】 独参汤。

2. 心阳不振

【主证】 四肢不温，血压下降，脉缓无力。

【治法】 温振心阳。

【方剂】 四逆加人参汤。

二十五、百 日 咳

百日咳又名“顿咳”，是小儿时期常见的一种急性呼吸道传染病。由百日咳嗜血杆菌所引起。

（一）初咳期

【主证】 咳嗽初起似外感，但有逐渐加剧之势，常有流涕，痰白而稀，多泡沫，舌苔薄白，脉浮有力，指纹淡红。

【治法】 宣肺化痰。

【方剂】 金沸草散。

（二）痉咳期

【主证】 咳嗽频频阵作，咳后有回吼声，反复不已，入夜尤甚，痰多而粘，呕吐后阵咳暂停。神烦面赤，大便干，小便黄，舌苔微厚，脉数有力，指纹紫滞。

【治法】 清热泻肺，止咳化痰。

【方剂】 桑白皮汤。

（三）恢复期

1. 气虚型

【主证】 形体虚弱，咳而声低，痰少而稀，手足欠温，神疲面眺，自汗无力，食少便溏，小便清，舌苔薄白，脉沉

无力，指纹淡。

【治法】 益肺健脾。

【方剂】 人参五味子汤。

2. 阴虚型

【主证】 干咳无力，手足心热，夜卧不安，心烦盗汗，颊赤唇干，舌苔薄黄，脉数无力，指纹紫淡。

【治法】 滋阴润肺。

【方剂】 麦门冬汤加减。

二十六、小 儿 肺 癆

肺癆证是小儿时期较为多见的一种由结核杆菌引起的慢性传染病。临床以潮热、盗汗、干咳及咳血为特征。小儿肺癆也称“疳癆”、“童子癆”等。

（一）阴虚内热型

【主证】 潮热，盗汗，颧红，干咳少痰，神烦，食少，咽干，口渴，唇燥，大便干，小便黄，舌苔薄，舌质红，脉数无力。

【治法】 滋阴清热。

【方剂】 秦艽鳖甲散。

（二）肺火炽盛型

【主证】 高热起伏，咳嗽汗多，呼吸急促，颧赤唇青，烦躁不安，大便秘结，小便短赤，舌苔黄厚，舌质红，脉数有力。

【治法】 清肺泻火。

【方剂】 清骨散。

（三）气阴两虚型

【主证】 低热多汗，咳嗽，气短乏力，形羸面白，食少，大便溏薄，小便清长，舌质淡少苔，脉沉数无力。

【治法】 养阴益气。

【方剂】 百合固金汤。

二十七、经行吐衄

月经来潮前一、二天，或正值经行时，出现有规律的吐血或衄血，常伴随月经周期而发作，可导致月经减少或不行。似乎月经倒行逆上，故称为“经行吐衄”，古称“倒经”或“逆经”。

（一）肝经郁火

【主证】 经前或经期吐血、衄血，量较多，色红，心烦易怒，或见两胁胀痛，口苦咽干，头晕耳鸣，尿黄便结，月经可见提前，量少或不行，舌红苔黄，脉多弦数。

【治法】 疏肝清热，降逆止血。

【方剂】 清肝引经汤。

（二）肺肾阴虚

【主证】 经期或经后吐血、衄血，量少，色黯红，平素可见头晕耳鸣，手足心热，两颧潮红，潮热咳嗽，咽干，口渴，月经多见先期，量少，舌红或绛，苔花剥或无苔，脉多见细数。

【治法】 滋阴润肺，清热凉血。

【方剂】 顺经汤加牛膝。

二十八、妊娠咳嗽

妊娠期中，久嗽不已，甚或五心烦热，胎动不安者，称为“妊娠咳嗽”，古名“子嗽”。

【主证】 妊娠咳嗽，日久不止，干咳无痰，甚者痰中带血，头晕目眩，手足心热，咽干口燥，两颧红赤，午后身有微热，舌红少苔或薄黄而干，脉细数而滑。

【治法】 养阴润肺，止嗽安胎。

【方剂】 百合固金汤。

二十九、产后大便难

产后饮食如常，大便数日不解，或排便时干燥疼痛，难以解出者，称为“产后大便难”。

【主证】 产后大便干燥，数日不解，或解时艰涩难下，但腹无胀痛，饮食如常，面色萎黄，皮肤不润，舌淡苔薄，脉虚而涩。

【治法】 养血润燥。

【方剂】 四物汤。

三十、产后发热

产后如果持续发热不减，或突然高热，伴有其他症状者，称“产后发热。”

（一）感染邪毒

【主证】 发热恶寒，小腹疼痛拒按，恶露量多或少，色紫黑如败酱，有臭味，烦躁口渴，尿少色黄，大便燥结，舌红苔黄，脉数有力。

【治法】 清热解毒，凉血化瘀。

【方剂】 五味消毒饮。

若小腹疼痛加剧，恶露不畅，有臭味，大便秘结，高热不退者，宜用大黄牡丹皮汤。

若证见高热，汗出，烦躁，斑疹隐隐，舌红绛，苔黄燥，脉弦细而数者，宜用清营汤。

（二）血瘀

【主证】 寒热时作，恶露不下，或下亦甚少，色紫暗有块，小腹疼痛拒按，口燥而不欲饮。舌紫黯或有瘀点，脉弦涩。

【治法】 活血化瘀。

【方剂】 生化汤。

（三）外感

【主证】 产后恶寒发热，头痛，肢体疼痛，无汗，或见咳嗽，流涕。舌苔薄白，脉浮。

【治法】 养血疏风。

【方剂】 四物汤加苏叶、防风、荆芥、甘草。

（四）血虚

【主证】 产后失血较多，身有微热，自汗，头晕目眩，心悸少寐，腹痛绵绵，手足麻木。舌淡红，苔薄，脉虚稍数。

【治法】 补血益气。

【方剂】 八珍汤去川芎，加黄芪。

三十一、产后自汗、盗汗

产后如汗出多而持续时间长，则为“产后自汗”。若睡中汗出，醒来即止者，称为“产后盗汗”。

（一）气虚

【主证】汗出较多，不能自止，动则加剧，时或恶风，面色㿔白，气短懒言，语声低怯，倦怠乏力，舌淡苔薄，脉虚弱。

【治法】补气固表，和营止汗。

【方剂】玉屏风散。

（二）阴虚

【主证】产后睡中不觉而汗出，醒来自止，面色潮红，头晕耳鸣，口燥咽干，渴不思饮，或有五心烦热，午后较甚，腰膝酸软，舌嫩色红或绛，无苔，脉细数无力。

【治法】益气养阴，生津敛汗。

【方剂】生脉散加煅牡蛎，浮小麦、生地黄、白芍。

三十二、产后身痛

产褥期内，出现肢体关节酸痛，麻木重着等证者，为“产后身痛”，或称“产后关节痛”。

（一）血虚

【主证】遍身关节疼痛，肢体酸楚、麻木，头晕心悸，舌淡红，少苔，脉细无力。

【治法】养血益气，温经通路。

【方剂】 黄芪桂枝五物汤加秦艽、当归、鸡血藤。

(二) 外感

【主证】 周身关节疼痛，屈伸不利，或痛无定处，或疼痛剧烈，甚如锥刺，或肢体肿胀，麻木重着，步履艰难，得热则舒。舌淡，苔薄白，脉细缓。

【治法】 养血祛风，散寒除湿。

【方剂】 独活寄生汤。